

XỬ TRÍ NHIỄM TRÙNG SAU MỔ KẾT HỢP XƯƠNG

XỬ TRÍ NHIỄM TRÙNG SAU MỔ KẾT HỢP XƯƠNG

I. Dấu hiệu sớm của nhiễm trùng:

Sau mổ 2-3 ngày BN sốt cao đau nhức vết mổ tăng dần. Cần kết hợp với siêu âm vùng mổ xem lượng dịch, máu có nhiều không.

Nếu lượng máu tụ nhiều và tiếp tục sốt cần mổ bán cấp cắt lọc và làm sạch vết mổ. Tuyệt đối tránh động tác cắt chỉ vết mổ để máu tụ tự thoát ra vì như thế việc làm sạch vết mổ không triệt để và có nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn từ ngoài vào.

II. Phương tiện kết hợp xương nên duy trì hay cần thiết tháo bỏ?

Sau khi cắt lọc 2-3 lần, việc dò dịch vẫn tiếp diễn → đánh giá xem KHX có đủ vững chắc?

Nếu không đủ vững → cần tháo bỏ ngay và thay thế bằng cố định ngoài. Nếu vững chắc → duy trì KHX đó thêm một thời gian. (chờ hiện tượng cal lệch có thể xảy ra)

→ Sau 2-3 tháng mổ cắt lọc lại thấy bắt đầu có cal → tiếp tục duy trì cho cal xương vững chắc hơn.

Nếu chẳng thấy chút cal xương nào → phải lấy phương tiện KHX ra và thế bằng cố định ngoài.

III. Lấy phương tiện KHX.

- Phương tiện là nẹp ốc: Sau khi lấy nẹp ốc, cần nạo sạch lớp vỏ bọc quanh nẹp và xương (lấy bỏ lớp Glycocalix), cắt lọc phần mềm, nạo sạch lòng tủy nơi có các vít chui qua.

- Phương tiện là đinh nội tủy. Sau khi lấy đinh nội tủy ra. Ví dụ trường hợp là xương đùi lòng tủy cũng phải được làm sạch bằng cách dùng khoang lòng tủy để làm bong tổ chức hoại tử và mô hạt viêm bên trong. Sau đó luồn ống cao su vào và bơm nước có áp lực để đẩy hết tổ chức viêm ra, bơm cho đến khi nước trào ra trở nên trong.

- Đặt cố định ngoài: Sau khi tháo bỏ phương tiện KHX. Cần phải được cố định ngoài bằng khung CĐN, chân đinh Shanz phải xa ổ gãy xương.

IV. Kháng sinh:

Sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ.

XỬ TRÍ VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM

I. ĐỊNH NGHĨA:

Vết thương phần mềm chỉ các thương tích gây rách da và gây tổn thương các mô liên kết dưới da, cân và cơ.

Vết thương phần mềm chỉ có thể là vết thương cắt gọn, cũng có thể là vết thương giập nát.

Vết thương phần mềm chiếm một tỷ lệ cao trong tổng số các vết thương nói chung.

Hầu hết các vết thương đặc hiệu (vết thương mạch máu, vết thương thần kinh, gãy xương hở...) có kèm theo vết thương phần mềm.

Nên về thực tế, vết thương phần mềm có thể coi là bao gồm tất cả mọi loại vết thương.

II. NGUYÊN NHÂN VÀ PHÂN LOẠI:

2.1. Loại I: Vết thương đâm chọc nhỏ:

2.1.1 Nguyên nhân:

- Tác nhân gây ra vết thương này là các vật nhỏ sắc nhọn. Trong lao động, đó là những vụn sắt nhỏ sắc nhọn, gai nhọn, giẫm gỗ...

- Trong sinh hoạt, những kim khâu, đinh ghim, những vết cắn của súc vật là những vết thương thường gặp.

- Trong ngành y tế, những PTV, điều dưỡng, nhân viên xét nghiệm khi làm việc sơ ý cũng có thể bị kim đâm vào tay gây thương tích.

2.1.2 Tổn thương:

- Vết thương rách da nhỏ nhưng tùy theo chiều dài của vật nhọn gây thương tích mà có tổn thương đi sâu vào các tổ chức mô mềm gây ra sự lan truyền nhiễm trùng từ ngoài vào trong các lớp mỡ, cơ, khoang kín.

2.1.3 Vấn đề quan tâm:

→ Nhiễm trùng là nguyên nhân chính gây ra trong loại vết thương này, nhưng nó tùy thuộc vào độ sâu của tổn thương, vào cấu trúc và tính chất của dị vật, vào nơi xảy ra vết thương, vào thời điểm được xử trí đúng, nhiễm trùng nặng nếu tổn thương sâu, do súc vật cắn, vết đâm chọc do vật dơ, các phẫu thuật viên, nhân viên y tế nếu bị thương cũng có nguy cơ nhiễm trùng cao.

→ Đau nhức: Do sự tồn tại của dị vật trong mô mềm gây nên đau nhức vùng vết thương. Nếu dị vật không được lấy ra, đau nhức càng tăng. Nó cũng chính là tác nhân gây ra nhiễm trùng.

→ Nhiễm trùng uốn ván: Cũng thường xảy ra, mặc dù thời gian ủ bệnh kéo dài nhưng hậu quả vô cùng trầm trọng.

→ Nguy cơ bị nhiễm HIV: Phẫu thuật viên và nhân viên y tế điều trị bệnh nhân có HIV (+), nghiện ngập ma túy... vô ý bị thương cũng có thể bị lây nhiễm HIV.

2.2. Loại II: Các vết thương cắt gọn

2.2.1 Nguyên nhân: Tác nhân gây ra là các vật sắc bén như dao, máy cắt công nghiệp, mảnh kính, tấm tôn... Vết thương có thể gây ra ở người nội trợ, công nhân và PTV.

2.2.2 Tổn thương: Tổn thương giải phẫu đáng kể. Vết rách da có thể rộng và sâu, tổn thương mô dưới da và cơ gây ra chảy máu vết thương.

2.2.3 Vấn đề quan tâm: có bốn vấn đề đặt ra:

- Cấp cứu: Phải làm ngừng chảy máu.
- Chẩn đoán phải liệt kê đầy đủ các mô bị tổn thương.
- Điều trị: Phải phục hồi cả về giải phẫu và chức năng.
- Theo dõi: Tránh phù nề và nhiễm trùng vết thương.

2.3. Loại III: Vết thương tróc da.

2.3.1 Phân loại: VT tróc da dựa trên nguồn gốc của sự cung cấp máu:

- Kiểu ngẫu nhiên.
- Kiểu theo trục.
- Vạt da cơ.
- Vạt da cân cơ

2.3.2 Tróc da không hoàn toàn:

- Là sự tróc da của một vạt da do một va chạm móc vào da theo hướng tiếp tuyến với mặt da. Da bị tróc còn dính bằng một cuống có chiều rộng tùy theo vết thương. Có khi là một tróc da ngầm, vết thương rách da nhỏ nhưng cả một vùng da rộng bị tróc bởi chấn thương đè trực tiếp và lăn xoắn trên mặt da.

- **Tổn thương:** Vùng tổn thương thường gặp là da đầu (tai nạn máy đuôi tôm, nhà máy), lưng và tứ chi. Thương tổn chỉ là da và mô dưới da, nhưng cũng có khi tới cơ và màng xương.

Vấn đề quan tâm:

Nguy cơ nhiễm trùng vết thương rất cao.

Nguy cơ hoại tử cuống da do hiện tượng thuyên tắc động mạch rải rác do sự lưu thông máu trong vạt da bị giới hạn ở động mạch của cuống da và giảm xuống rất nhanh bởi sự đông tụ máu trong thành mạch.

Hoại tử các tổ chức dưới da: Nếu không dùng vạt da che phủ kịp thời các tổ chức dưới da thì sự hoại tử các tổ chức này sẽ xảy ra.

2.3.3 Tróc da hoàn toàn:

- Là một mảng da bị tróc ra hoàn toàn khỏi cơ thể

- **Tổn thương:** Vùng tổn thương thường là tróc da đầu, tróc da ở đầu cuối các đốt ngón tay, ngón chân...tróc da ở mặt trước cẳng chân...

- **Vấn đề quan tâm:**
 - + Nhiễm trùng cao
 - + Hoại tử tổ chức dưới da.

+ Choáng chân thương

2.4. Loại IV: Vết thương giập nát.

- Theo lý thuyết về sự truyền năng lượng trong môi trường lỏng của Bush → tiếp tục mở rộng sự phá hủy mô mềm xung quanh và gây ra rất nhiều góc ngách. Do đó vết thương sẽ gây ra những tổn thương nhiều hơn những gì mà mắt thường nhìn thấy.

- **Tổn thương:** Tổn thương giải phẫu trầm trọng. Thường kèm theo các tổn thương khác như gãy xương, mạch máu, thần kinh.

- Vấn đề quan tâm:

+ Choáng chân thương.

+ Nhiễm trùng nặng.

+ Tắc mạch máu do mỡ.

+ Nguy cơ có thể mất chi hoặc liên quan tính mạng người bệnh.

III. ẢNH HƯỞNG CỦA VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM

Da: là cửa ngõ cho vi trùng xâm nhập dù vết thương lớn hay nhỏ. Trường hợp tróc da không hoàn toàn các mạch máu nuôi dưỡng da có thể bị đứt do đó dễ bị hoại tử. Trường hợp tróc da hoàn toàn các tổ chức dưới da như mạch máu thần kinh, gân, xương có nguy cơ hoại tử.

Mô liên kết sẽ ứ đọng máu khi bị tổn thương, tạo điều kiện tốt cho vi trùng phát triển.

Cân cơ thường rách theo chiều dọc, hẹp và khép giữ lại bên trong một lượng máu tụ ngày càng tăng do tổn thương cơ và mạch máu nhỏ tạo nên hiện tượng tăng áp lực gây chèn ép khoang.

Cơ giập nát đưa đến hoại tử là môi trường tốt cho vi trùng phát triển. Cần phải khám kỹ để đánh giá đúng mức độ tổn thương. Tiên lượng có thể xấu nếu chỉ tổn thương bị tổn thương động mạch chính.

IV. ĐIỀU TRỊ:

Nếu có choáng chân thương phải điều trị ổn định trước khi tiến hành điều trị vết thương.

4.1. Xử trí tại nơi xảy ra tai nạn và tại phòng cấp cứu:

- Liệt kê đầy đủ các tổn thương nhất là trong trường hợp vết thương cắt gọn, vết thương tróc da và vết thương giập nát.

- Cầm máu tốt và bảo vệ an toàn cho trường hợp da tróc còn cuống da. Có thể băng ép hoặc băng ép có trọng điểm đối với những mạch máu nhỏ bị tổn thương.

- Bảo vệ vết thương khỏi bị tiếp tục nhiễm khuẩn thêm, bằng cách băng kín vết thương. Điều kiện tốt nhất là dùng gạc và băng đã được thanh trùng và người sơ cứu phải đội mũ, mang khẩu trang và găng tay vô trùng.

- Xử trí vết thương, cắt lọc sớm (tốt nhất trước 8 giờ sau khi bị thương).

4.2. Xử trí chính thức vết thương:

4.2.1 Kháng sinh trị liệu:

- Dùng kháng sinh sớm ngay từ đầu, kháng sinh mạnh và phổ rộng: Cefotaxim 1g 1lọ x 3 TMC/8h.

- Phòng ngừa uốn ván bằng chích SAT.

4.2.2 Vết thương đâm chọc nhỏ:

- Nếu không có nguy cơ nhiễm trùng chỉ cần băng vô trùng bảo vệ.

- Nếu có nguy cơ nhiễm trùng, phải rạch rộng và cắt hai mép vết mổ để vết thương toát rộng. Băng vô trùng, kháng sinh trị liệu.

4.2.3 Vết thương phẳng gọn:

- Xối rửa, làm sạch vết thương bằng nước muối sinh lý + Oxyginèse, việc xối rửa dễ dễ nhìn nhận đánh giá rõ vết thương.

- Cắt lọc được tiến hành một cách tỉ mỉ và từ tốn, từ nông đến sâu, từ ngoài vào trong: da, mô mỡ dưới da và cơ.

- Khâu da kín nếu vết thương sạch và đến sớm trước 6 giờ mà không cần dẫn lưu, sau đó băng vô trùng và dùng kháng sinh trị liệu liều cao.

4.2.4 Các vết thương tróc da:**4.2.4.1 Tróc da có cuống:**

- Chúng ta cần xem vạt da này còn sống được hay không. Vạt da có cuống có thể sống được nếu chiều dài vạt da bằng chiều rộng cuống da và mạch máu lưu thông vùng da phải tốt.

- Nếu vạt da có thể giữ lại được, ta phải cắt lọc tiết kiệm lớp dưới da, cố gắng bảo vệ các mạch máu nuôi da. Sau khi khâu cần dẫn lưu tốt.

4.2.4.2 Tróc da hoàn toàn:

- Nếu tróc da để lộ mạch máu, thần kinh, gân, xương, sau khi cắt lọc cần phải tìm cách khâu che lại bằng cách rạch đối bên, xoay vạt da, ghép da có cuống...

4.2.5 Các vết thương giập nát:

- Rạch rộng và cắt lọc vết thương đúng quy cách (gồm 05 bước).

- Kháng sinh liều cao, phổ rộng.

- Bất động chi có vết thương.

- Kê cao chi tổn thương.

- Khâu da thì hai khi có mô hạt đỏ và hết nhiễm trùng.

- Trường hợp dập nát nhiều, nhiễm trùng nặng có khi phải cắt cụt chi sớm để cứu lấy sinh mạng bệnh nhân.

CHẨN THƯƠNG NGỰC

I. Gãy sườn:

1.1. Chẩn đoán:

- Đau khi hít vào.
- Sờ đau, tiếng lạo xạo nơi sườn gãy.
- Dấu bầm máu dưới da nơi thành ngực có thể là chỉ điểm của gãy sườn.
- X Quang ngực thẳng.

1.2. Các loại gãy sườn:

- Gãy sườn 1,2,3: thường ít gặp. Cần theo dõi tổn thương mạch máu bên dưới.
- Gãy sườn 11, 12 phải theo dõi vỡ gan (nếu bên phải), hoặc vỡ lách (nếu là bên trái). Vỡ thận, hoặc đầu sườn gãy, đâm thủng cơ hoành.
- Gãy sườn ở trẻ em: lồng ngực trẻ em rất co dãn, ít phát hiện gãy sườn, dù chấn thương cực mạnh. Cần dựa vào cơ chế chấn thương và theo dõi sát chấn thương ngực kín trẻ em.

- Gãy sụn sườn: dễ gây đau sau chấn thương và viêm sụn sườn sau này.

1.3. Điều trị:

- Gãy 1,2 xương sườn, không có tổn thương phổi - màng phổi đi kèm có thể điều trị ngoại trú.
- Gãy trên 3 xương sườn nên nhập viện, cho thuốc giảm đau và theo dõi hô hấp.
- Giảm đau là điều then chốt:
 - + Thuốc giảm đau nhóm NSAIDs
 - + Phong bế thần kinh liên sườn.
 - + Cố định sườn gãy bằng băng keo thun bản rộng, ở người lớn tuổi và bệnh nhân có bệnh phổi mạn tính nên tránh vì gây hạn chế khả năng hô hấp, ứ đọng đàm, dễ bị viêm phổi. Chỉ cần nằm tư thế Fowler, kết hợp giảm đau tốt là đủ.

II. Mảng sườn di động (MSDD):

2.1. Chẩn đoán:

- MSDD chỉ có thể xảy ra khi gãy 2 hoặc nhiều chỗ trên cùng 1 xương sườn và trên 3 sườn liên tiếp.
- Quan sát thấy hình ảnh chuyển động đảo nghịch của MSDD: khi hít vào lồng ngực dãn ra, mảng sườn bị kéo vào trong; khi thở ra lồng ngực thu nhỏ lại, mảng sườn bị đẩy ra.
- X Quang: đánh giá dập phổi đi kèm. Tất cả MSDD đều có dập phổi đi kèm.
- Cần đánh giá những tổn thương khác đi kèm: CTSN, gãy xương chi, chấn thương bụng kín.

2.2. Dấu hiệu tiên lượng nặng của MSDD:

- MSDĐ xảy ra ở cung trước bên mà:
- + Diện tích di động có đường kính > 15 cm
- + Biên độ di động $> 1,5$ cm

2.3. Nguyên tắc điều trị:

a. Hồi sức:

- Hạn chế tối đa dịch truyền, tránh biến chứng phù phổi.
- Corticoid liệu pháp.
- Kháng sinh.

b. Giảm đau hiệu quả:

- Cố định thành ngực tạm thời trong sơ cứu: đặt 1 đệm bông dày phủ kín lên bề mặt của mảng sườn rồi băng chặt quanh ngực.

- Thuốc giảm đau narcotic.
- Phong bế thần kinh liên sườn.

c. Điều chỉnh phục hồi chức năng hô hấp do dập phổi:

- Chỉ định thở máy:
- + BN không thể thở tự nhiên.
- + Nhịp thở $> 35-40$ lần / phút.
- + $PaO_2 < 60$ mmHg (khí phòng) hoặc $PaO_2 < 80$ mmHg với $FiO_2 \geq 0,5$
- + $PaCO_2 > 55$ mmHg với $FiO_2 \geq 0,5$
- Vật lý liệu pháp hô hấp tích cực : hút đàm thường xuyên, làm ẩm khí hít vào.

III. Vết thương thủng hoành:

- Vết thương từ vú đến ngang rốn (chiếm tỉ lệ 80%).
- Dấu gián tiếp:
 - + Vết thương chột vùng ngực mà có hội chứng xuất huyết nội ở bụng hoặc hội chứng VPM .
 - + Vết thương vùng bụng mà lại có hội chứng tràn máu hoặc tràn khí màng phổi.
- X Quang ngực thẳng, nghiêng thấy hình ảnh mất liên tục của vòm hoành. Bóng hoành nâng cao.
- Điều trị: mở bụng cấp cứu.

BÀN CHÂN TIỂU ĐƯỜNG

I. Thay đổi bệnh lý

Có 3 đặc điểm:

- Bệnh thần kinh ngoại vi
- Tình trạng nhiễm khuẩn
- Tình trạng thiếu máu nuôi

II. Phân độ

Thương tổn của bàn chân tiểu đường được chia làm 6 độ tùy theo độ sâu của vết thương, có áp xe, viêm xương tủy hay không và mức độ lan rộng của tổn thương.

- Độ 0: Da lành có nhiều chỗ chai sần, biến dạng như ngón chân quắp, ngón cái vẹo ra, các chỏm đốt bàn thấp xuống, gan bàn chân chai sần nhưng không có vết thương.

- Độ 1: Da bị hở, có vết thương nhưng chỉ tổn thương ở lớp da thôi. Đáy vết thương sạch hoặc có mủ.

- Độ 2: Loét sâu đến xương, khớp lộ gân. Đáy vết thương sạch hoặc có mủ.

- Độ 3: tổn thương lan rộng dần tới áp xe sâu hay viêm xương tủy.

- Độ 4: hoại tử ngón chân hay hoại tử một phần ở trước bàn chân.

- Độ 5: hoại tử lan rộng, phải cắt cụt cao ở cẳng chân trở lên.

III. Điều trị:

3.1 Điều trị ổn định đường huyết

3.2 Kháng sinh

3.3 Xử trí tổn thương:

- Độ 0: cho mang giày bảo vệ chân, nếu có biến dạng bàn chân tiến triển mổ chỉnh hình biến dạng.

- Độ 1: Điều trị cho loét da liền sẹo. Cắt lọc vết thương, dùng kháng sinh và chăm sóc vết thương. Khi vết thương lành nếu có biến dạng bàn chân cho mang giày chỉnh hình, nếu thất bại thì mổ sửa.

- Độ 2: cho thuốc kháng sinh. Cần phải mổ làm sạch vết thương, lát hết mô chết ở da cân gân dây chằng, không khâu da. Một số trường hợp cần phải lấy bỏ xương nằm dưới để khâu da lại. Khi vết thương lành có thể mổ chỉnh hình biến dạng nếu có.

- Độ 3: Nhiễm trùng sâu: áp xe, viêm xương tủy. Cần phải mổ lấy bỏ mô hoại tử, có khi phải mổ cắt cụt. Nếu hoại tử ngón 4,5 lên tới đốt bàn, có thể cắt cụt chéo bàn chân, để lại phần gót và đốt bàn 1,2. Nếu hoại tử đốt bàn ngón 1,2 thì phải cắt cụt bàn chân theo kiểu Lisfranc. Sau mổ dẫn lưu, khâu da.

- Độ 4: Dựa theo chỉ số thiếu máu nuôi và tình trạng da mà lựa chọn vị trí cắt cụt

- Độ 5: Hoại tử phần lớn bàn chân. Chọn vị trí cắt cụt cũng dựa vào chỉ số thiếu máu nuôi và tình trạng da, thông thường phải cắt cụt 1/3 trên cẳng chân hay cao hơn nữa.

CHẨN THƯƠNG NIỆU ĐẠO

I. ĐẠI CƯƠNG:

Chẩn thương niệu đạo là cấp cứu ngoại khoa phải được xử trí kịp thời để tránh các tai biến trước mắt là bí đái, viêm tấy nước tiểu tăng sinh môn và tránh các di chứng phức tạp về sau: viêm niệu đạo, hẹp niệu đạo.

Về giải phẫu niệu đạo chia làm 2 phần: niệu đạo trước và niệu đạo sau

Chẩn thương niệu đạo trước và sau khác hẳn nhau về:

- + Nguyên nhân sinh bệnh.
- + Lâm sàng
- + Phương pháp điều trị.

II. CHẨN THƯƠNG NIỆU ĐẠO TRƯỚC:

2.1. Triệu chứng lâm sàng:

Sau khi bị ngã ngồi xoạc 2 chân, đập tầng sinh môn lên vật cứng, nạn nhân thấy:

- ***Đau nhói*** ở tầng sinh môn, có khi mạnh quá có thể ngất đi không ngồi dậy được, không đi lại được ngay.

- ***Chảy máu ở miệng sáo nhiều hay ít***, từng đợt hay liên tục, không tự ngừng, mặc dầu bệnh nhân tự lấy tay ép vào vùng bị tổn thương.

- ***Thăm khám tại chỗ:***

- + Ấn tầng sinh môn có điểm đau chói và thấy máu chảy ra ở miệng sáo.
- + Tầng sinh môn bầm tím tụ máu hình cánh bướm to hoặc nhỏ. Máu tụ lớn, có thể lan rộng hai bên bẹn và ra phía trước, búi căng to.

Tùy theo mức độ thương tổn (đứt niệu đạo không hoàn toàn hay hoàn toàn), có những biểu hiện sau đây:

- + Giáp vật xóp chủ yếu là máu to hay nhỏ ở tầng sinh môn.
- + Đứt niệu đạo máu chảy ra ở miệng sáo.
- + Đứt niệu đạo hoàn toàn, chảy máu tụ niệu đạo và máu chảy tụ hình cánh bướm ở tầng sinh môn.

2.2. Các giải pháp cụ thể:

a/- Trường hợp bệnh nhân đái được

- Nước tiểu trong
- Nước tiểu đỏ đầu bãi

Theo dõi, giảm đau và kháng sinh và không can thiệp gì.

Sau 1 tuần ngưng niệu đạo, chụp niệu đạo kiểm tra.

b/- Bệnh nhân không đái được:

- Có cầu bàng quang

- Không chảy máu niệu đạo nhiều

Thông bàng quang: vô trùng và nhẹ nhàng để tháo nước tiểu, có thể đặt thông tại chỗ 1-3 ngày, giảm đau, kháng sinh. Sau khi rút ống thông, chụp niệu đạo kiểm tra (hoặc nong thử).

c/- Bệnh nhân không đái được:

- Bàng quang căng.
- Chảy máu niệu đạo nhiều.

Mở thông bàng quang đơn thuần hoặc mở thông bàng quang kết hợp, đặt ống thông niệu đạo.

d/- Trường hợp máu tụ vùng tầng sinh môn lớn, hoặc viêm tấy nước tiểu tầng sinh môn:

- Mở thông bàng quang
- Mở tầng sinh môn khâu cầm máu

Niệu đạo đứt, lấy máu tụ tầng sinh môn.

Hoặc viêm lan tấy nước tiểu, rạch rộng tầng sinh môn tháo nước tiểu

e/- Phẫu thuật khâu nối phục hồi niệu đạo:

- Thì đầu: cấp cứu: Dẫn lưu bàng quang kết hợp lấy máu tụ tầng sinh môn, cầm máu niệu đạo.

- Thì hai: mổ sớm: Cắt đoạn niệu đạo, khâu nối, kết quả sẽ chắc chắn hơn.

III. CHẤN THƯƠNG NIỆU ĐẠO SAU:

Đứt niệu đạo sau là một trong những tai biến của vỡ xương chậu (VXC).

Thái độ xử trí tùy theo tình trạng chấn thương VXC hay đau chấn thương.

3.1. Lâm sàng: Thể điển hình: đứt niệu đạo màng do VXC

a/- Bệnh cảnh chung:

- Sốc vừa và nặng
- Tụ máu lớn trước bàng quang, sau phúc mạc

b/- Triệu chứng đứt niệu đạo sau:

Khi phát hiện VXC, phải nghĩ tới đứt niệu đạo sau. Tìm các triệu chứng sau:

- Chảy máu niệu đạo thường ít.
- Bí đái.

- Thăm khám: không có máu tụ tầng sinh môn, chỉ có thể có máu tụ quanh trước hậu môn. Khám trực tràng có vùng đau tương ứng với niệu đạo sau ở thành trước trực tràng.

c/- Chẩn đoán rất quan trọng vì triệu chứng đứt niệu đạo sau thường rất kín đáo:

- Do vỡ xương chậu.
- Khi có bí đái. Bàng quang căng.

- Máu chảy ra miệng sáo ít hay không có.
- Thông bàng quang (vô trùng và nhẹ nhàng), ống thông dừng lại. Lúc rút ống thông ra có máu chảy ra ở miệng sáo: đứt niệu đạo sau.
- X Quang: chụp niệu đạo bàng quang ngược dòng, thuốc cản quang trào ra ngoài niệu đạo.

d/- Nguyên tắc xử trí:

- Hồi sức chống sốc.
- Đánh giá các thương tổn bụng ngực, gãy xương.
- Khi bệnh nhân trong tình trạng chảy máu nặng và tăng nhanh trước bàng quang, sau phúc mạc, có chỉ định mổ cầm máu hoặc thắt động mạch chậu trong một bên hoặc hai bên.
- Xử trí đứt niệu đạo sau:
 - + Mở thông bàng quang đơn thuần
 - + Mở thông bàng quang và đặt ống thông niệu đạo, chỉnh lại niệu đạo.

e/ - Phẫu thuật tạo hình niệu đạo sau.

CHẨN THƯƠNG SỌ NÃO

I. Chẩn đoán:

Tri giác: Đánh giá theo thang điểm Glasgow

+ 13 - 15 điểm : nhẹ

+ 9 - 12 điểm: vừa

+ 3 - 8 điểm : nặng

Các dấu hiệu thần kinh khu trú: Dẫn đồng tử một bên, yếu liệt chi một bên

Có thể xuất hiện động kinh

Tình trạng sốc: thường do đa thương

Cận lâm sàng: - XQ sọ - CAG - CT Scanner - NGFL - TS-TC - HCT - GS ..

II. Điều trị:**2.1. Điều tra nội khoa:****2.1.1. Thông khí:**

- Thở Oxy đường mũi 6 - 8 l/phút
- Mở khí quản nếu có tắc nghẽn hô hấp trên
- Lấy dị vật - hút đàm nhớt
- Đặt nội khí quản giúp thở nếu suy hô hấp.

2.1.2. Chống phù não:

- Mannitol 20% 1gm/kg truyền nhanh 80 - 100g/phút
- Tiếp theo 0,25gm/kg mỗi 6h cũng truyền nhanh (80 - 100 giọt/ph)
- Furosemide: 20mg (TM)

2.1.3. Kháng sinh: Nếu có vết thương hoặc vỡ sán sọ

- | | |
|---|--------------|
| a- Penicillin G: 100.000 - 200.000 đv/kg/24h (4 - 6h) | } TB hoặc TM |
| b- Gentamycin 80mg: 3 - 5mg/kg/24h (8 - 12h) | |
| c- Cefotaxim: 100 - 200mg/kg/24h (6 - 8h) | |
| d- Ceftriaxon: 30 - 50mg/kg/24h (1 hoặc 2 lần/ngày) | |

* Note: Có thể sử dụng phối hợp (a + b; b + c) hoặc đơn độc.

2.1.4. Nước và điện giải:

Truyền NaCl 0,9% chậm, 20 - 30 giọt/phút

(48 giờ đầu). Sau 48 giờ điều chỉnh theo Ion đồ

2.1.5. Điều chỉnh kiềm toan: Theo khí máu

2.1.6. Giảm chuyển hóa: Phenobarbital 1 - 5mg/kg/24h (chia đều tiêm TM mỗi 6h hoặc truyền duy trì trong 24h chú ý theo dõi HA không sử dụng hoặc nhưng nếu HA tâm thu < 9 cmHg)

Kiểm soát bằng CT Scanner

Hạ thân nhiệt: thuốc hạ nhiệt - lau mát

2.1.7. Chống động kinh: Có thể sử dụng một trong các thuốc sau.

- Phenobarbital: 1 - 5mg/kg/24h (tiêm bắp hoặc TM chậm)
- Diazepam: 5 - 10mg (tiêm bắp hoặc TM Chậm 2 - 3') theo dõi hô hấp
- Diphenyl hydantoin: 3 - 8mg/kg/24h

2.1.8. Đau đầu: Giảm đau thuần túy - theo dõi.

2.1.9. Nôn liên tục: chống nôn - theo dõi

2.1.10. Đặt sond mũi - dạ dày
Sond tiêu } nếu BN mê

2.1.11. Theo dõi thường xuyên áp lực trong sọ (nếu có điều kiện)

2.2. Điều trị phẫu thuật:

Nếu BN có Glasgow từ 6 điểm trở lên khi đã xác định máu tụ trong sọ phải phẫu thuật khẩn cấp.

Nếu Glasgow nhỏ hơn 6 điểm:

- Nên đánh giá tình trạng BN và các thương tổn phối hợp của các cơ quan khác.
- Tình trạng hô hấp, tim mạch, các bệnh đi kèm, v.v...
- Tổ chức hội chẩn để có kết luận xử trí phù hợp.

ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN TRẬT KHỚP

I. ĐẠI CƯƠNG:

- Đơn vị khớp: có 5 thành phần:
 - + Sụn khớp và bao hoạt dịch.
 - + Dây chằng và bao khớp.
 - + Cơ gân quanh khớp
 - + Thần kinh vận động và cảm giác.
 - + Mạch máu.
- Phải khám toàn diện trước khi điều trị một trật khớp.
- Điều trị trật khớp là một cấp cứu :giảm đau, giảm thiểu các biến chứng.
- Nắm được cơ chế (thông qua bệnh sử) và kiểu trật (thông qua lâm sàng + x-quang) để có hướng điều trị thích hợp.
- Vô cảm khi nắn khớp : tê ổ khớp, tê từng, gây mê. Nắn khớp không tê, mê chỉ thực hiện một số khớp và đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của bệnh nhân.
- Bất động sau khi nắn nhằm phục hồi các thành phần trong đơn vị khớp.
- Tập vận động ngay sau khi bất động để đủ phục hồi chức năng khớp.

II. TRẬT KHỚP VAI:

- Rất thường gặp.
- Chú ý phát hiện gãy cổ phẫu thuật kèm theo (trước và sau khi nắn) nhất là ở người già.
- Vô cảm: gây tê ổ khớp (bằng novocain) hoặc không tê.
- Đối với người khoẻ mạnh, to con đôi khi phải dùng gây mê.
- Kỹ thuật nắn:
 - + Thủ thuật Hippocrate
 - + Thủ thuật Kocher (Dessault)
- Bất động bằng bột hoặc băng thun Dessault 2 - 3 tuần.
- Tập vận động nhẹ nhàng sớm để tránh viêm quanh khớp vai ở người già.

III. TRẬT KHỚP KHUỖY:

- Chú ý các biến chứng mạch máu, thần kinh.
- Vô cảm : gây tê ổ khớp hoặc không tê.
- Kỹ thuật nắn:
 - + Kéo dọc trục + nắn di lệch
 - + Gập khuỷu để mỏm khuỷu ngang với hố khuỷu.
 - + Duỗi khuỷu + nắn lại chỏm quay.

+ Kiểm tra lại.

- Bất động nẹp vít cánh bàn tay khuỷu gấp 90 độ 2 - 3 tuần.

- Lao động nặng sau 3 tháng.

IV. TRẬT KHỚP HÁNG:

- Thương do chấn thương nặng, có thể gây choáng, bể ổ chảo....

- Có thể xác định kiểu trật (chậu, ngồi, mu, bịt) qua lâm sàng, tuy nhiên vẫn phải kiểm tra lại bằng x-quang.

- Vô cảm: gây mê, đôi khi phải dùng dẫn cơ.

- Kỹ thuật nắn: Boehler, Kocher.

- Bất động: - bột đùi bàn chân

- bột chữ A

- Tập vận động lấy biên độ khớp háng trong 4 - 8 tuần.

V. TRẬT KHỚP GỐI:

- 50 - 70% phải can thiệp bằng phẫu thuật do biến chứng mạch máu.

- Để lại các di chứng nặng nề do tàn phá các thành phần của khớp.

VI. TRẬT KHỚP BÀN NGÓN VÀ LIÊN ĐÓT:

- Thường là nắn dễ dàng, ít để lại di chứng.

- Có thể nắn không cần gây tê.

- Nếu nắn khó khăn có thể do chèn của dây chằng hoặc gân gấp hoặc đầu xương chui qua gân gấp khi đó cần phẫu thuật để giải quyết.

ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG CHI DƯỚI

I. Gãy cổ xương đùi

- Là loại gãy xương rất khó lành xương, hay xảy ra ở người lớn tuổi
- Sơ cứu bằng cách cho thuốc giảm đau, bó bột chống xoay chân gãy, điều trị bệnh phối hợp
- Chuyển tủy tủy trên, phẫu thuật thay khớp hay xuyên đinh hay vis xóp.

II. Gãy liên mấu chuyển xương đùi

- Hay xảy ra ở người lớn tuổi
- Điều trị bằng cách cho thuốc giảm đau, bó bột chống xoay hay xuyên đinh kéo tạ nếu có di lệch nhiều
- Nếu bệnh nhân còn trẻ, thể trạng còn tốt có thể kết hợp xương

III. Gãy thân xương đùi

- Do một lực chấn thương lớn gây nên. Do đó có thể tổn thương nhiều cơ quan kèm theo, cần phải khám toàn diện.
- Lưu ý biến chứng sốc chấn thương và tổn thương mạch máu.
- Phẫu thuật kết hợp xương được ưu tiên ở người lớn bao gồm : đóng đinh nội tủy, đóng đinh nội tủy + cột chỉ thép, nẹp vis, cố định ngoài. Điều trị bảo tồn bằng xuyên đinh kéo tạ áp dụng cho những bệnh nhân lớn tuổi, tình trạng không cho phép phẫu thuật, kéo tạ khi có can lâm sàng thì chuyển sang bó bột.
- Ở trẻ em, gãy thân xương đùi được ưu tiên cho bó bột bụng - đùi - bàn chân giữ 6 → 8 tuần, nếu di lệch nhiều thì kéo tạ qua da, điều chỉnh di lệch khi có can lâm sàng chuyển sang bó bột. Phẫu thuật khi gãy xương hở hay điều trị bảo tồn thất bại.

IV. Gãy trên hai lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi

- Lưu ý biến chứng tổn thương mạch máu
- Cần thiết phải nắm chính xác, phục hồi giải phẫu. Do đó chỉ nên điều trị bảo tồn khi gãy không di lệch hoặc tình trạng bệnh nhân không cho phép phẫu thuật.
- Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vis, xuyên đinh
- Điều trị bảo tồn bằng bó bột đùi - bàn chân sát háng chỉ định cho trường hợp gãy gài, gãy không di lệch, giữ 6 tuần sau đó cắt bột, làm bột chức năng tập gôi cho đến khi lành xương (khoảng 4 tháng)
- Điều trị bảo tồn bằng kéo tạ phải điều chỉnh di lệch trong giới hạn chấp nhận được ($\text{ngang} \leq 7^0$, trước sau $\leq 10^0$, chông ngắn $\leq 1 - 1,5$ cm, cấp kênh mặt khớp ≤ 2 mm) cho tới khi có can lâm sàng thì làm bột chức năng điều trị tiếp như trên.

V. Gãy xương bánh chè

- Điều trị bảo tồn bằng bó bột ống hay bột đùi bàn chân, giữ 4 - 6 tuần được chỉ định cho các trường hợp gãy không lệch hoặc lệch ít (di lệch xa < 2 mm, cấp kênh mặt khớp < 2 mm).

- Điều trị phẫu thuật kết hợp xương bằng phương pháp nẹp ép, xuyên kim ... áp dụng cho các trường hợp di lệch nhiều.

VI. Gãy mâm chày

- Điều trị bảo tồn : chỉ định cho các trường hợp gãy không hoàn toàn, gãy không di lệch, gãy di lệch ít ($< 3 - 4$ mm) hay ở bệnh nhân lớn tuổi. Làm bột chức năng khóa ở tư thế duỗi 0^0 , tuần thứ 3 cho tập tăng tầm độ khớp, tuần thứ 4 có thể cho gối gấp 90^0 , thường để bột 8 - 12 tuần cho đến khi lành xương, chịu sức nặng sau 4 - 6 tuần.

- Điều trị phẫu thuật kết hợp xương cho những trường hợp gãy lún mất xương, gãy di lệch nhiều, gãy có kèm các biến chứng của gãy xương.

VII. Gãy thân hai xương cẳng chân

- Là loại gãy xương thường gặp nhất ở chi dưới

- Điều trị bảo tồn cho tất cả các trường hợp gãy kín, gãy hở độ I, độ II không biến chứng (C.E.K, chèn ép thần kinh mạch máu) : nắn, bó bột đùi - bàn chân, giữ bột 6 tuần, sau đó làm bột Sarmiento cho bệnh nhân tập gối, giữ bột cho đến khi lành xương (thường từ 13 - 16 tuần). Có thể điều trị bảo tồn bằng xuyên đinh kéo tạ qua xương gót, khi có can lâm sàng thì bó bột.

Di lệch chấp nhận được:

- gấp góc: trong - ngoài $< 5^0$

trước - sau $< 10^0$

- sang bên: $< \frac{1}{2}$ thân xương

- chùng ngắn $< 1,5$ cm

- Điều trị phẫu thuật kết hợp xương có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp gãy 2 xương cẳng chân bằng các phương pháp như nẹp vis, đóng đinh nội tủy, cố định ngoài (gãy hở độ III)

VIII. Gãy xương mắt cá

- Phân loại theo Weber: có 3 loại A, B, C dựa vào ổ gãy mắt cá ngoài trên hay dưới dây chằng chày mác dưới (DCCMD)

Weber A: mắt cá ngoài gãy dưới dây chằng chày mác dưới

Weber B: mắt cá ngoài gãy ngang dây chằng chày mác dưới

Weber C: mắt cá ngoài gãy trên dây chằng chày mác dưới

- Điều trị bảo tồn bằng bó bột cho gãy loại Weber A. Bó bột Botte 8 tuần, 4 tuần đầu đi 2 nạng không chạm chân đau, 4 tuần sau đi 2 nạng chạm nhẹ chân đau.

- Điều trị phẫu thuật kết hợp xương cho gãy loại Weber B, C

IX. Gãy xương gót

- Gãy ngoài đôi gót:

☐ Gãy không di lệch: điều trị chức năng hoặc bó bột cẳng - bàn chân 6 - 8 tuần. Sau đó đi 2 nạng trong 2 - 3 tháng.

☐ Gãy có di lệch: mổ kết hợp xương

ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG CHI DƯỚI

- Gãy phạm đôi gót: mổ kết hợp xương

X. Gãy xương bàn chân, xương ngón chân

- Gãy xương bàn chân thông thường chỉ cần bó bột cứng - bàn chân giữ 6 - 8 tuần là liền xương
- Gãy xương ngón chân chỉ cần nắn chỉnh lại rồi băng kèm giữa 2 ngón lành với nhau, giữ 3 - 6 tuần. Bệnh nhân tránh đi tì đè ngón chân đau trong thời gian bất động.

ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG CHI TRÊN

I. Gãy xương đòn

- Là loại gãy thường gặp nhất ở vùng vai và chi trên, rất dễ liền xương
- Ưu tiên điều trị bảo tồn
- Điều trị bằng cách mang nẹp vải xương đòn hay băng số 8, giữ 4 tuần
- Phẫu thuật cố định xương gãy bằng kim Kirschner hoặc nẹp vis chỉ khi: gãy hở, gãy có biến chứng thần kinh mạch máu, đe dọa thủng da, không liền xương hay vì lý do thẩm mỹ.

II. Gãy xương vai

- Là loại gãy ít gặp, dễ liền xương
- Điều trị bảo tồn là chính
- Gãy cổ xương vai, gãy các góc và mỏm gai: bó bột Desault hoặc mang đai vải Desault giữ 3 tuần rồi tập khớp vai
- Gãy thân xương vai, gãy hõm khớp: bó bột Desault hoặc mang đai vải Desault giữ 2 tuần rồi tập vận động khớp vai.

III. Gãy cổ phẫu thuật xương cánh tay

- Thường gặp ở người lớn tuổi (phụ nữ mãn kinh) hay ở trẻ em
- Gãy gài, di lệch không đáng kể: bó bột Desault hoặc mang đai vải Desault 10 ngày sau đó dùng băng đeo treo tay và tập vận động khớp vai.
- Gãy có di lệch ít (thường gặp góc): nắn sửa di lệch và bất động như trên
- Gãy không gài: nắn sửa cho gài nhau và bó bột ngực - vai - cánh tay (dạng vai), giữ 3 tuần mở bột và tập vai.
- Nếu nắn không được thì phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp, vis xóp hay kim Kirschner.

IV. Gãy thân xương cánh tay

- Là loại gãy xương có nhiều biến chứng, đặc biệt là liệt thần kinh quay và khớp giả
- Đa số được điều trị bảo tồn
- Điều trị bảo tồn bằng cách bó bột chữ U hay bó bột treo giữ 6 tuần. Điều trị bảo tồn không cần phải nắn thật chính xác, nếu liền xương vững chắc mà còn một ít di lệch chông ngán hay gập góc nhẹ cũng dễ dàng chấp nhận.
- Điều trị phẫu thuật bằng nẹp vis, đinh Rush khi điều trị bảo tồn thất bại, xương còn di lệch nhiều, di lệch xa hay kèm theo liệt thần kinh quay.

V. Gãy trên hai lồi cầu xương cánh tay

- Hay gặp ở trẻ em
- Hay có biến chứng chèn ép khoang, chèn ép động mạch và thần kinh giữa

- Ưu tiên điều trị bảo tồn
- Nắn các di lệch, bó bột cánh - bàn tay giữ 3 tuần, mở bột tập khuỷu (ở trẻ em)
- Phẫu thuật khi gãy hở, gãy xương có biến chứng, nắn các di lệch không đạt. kết hợp xương bằng kim Kirschner, giữ 3 tuần rút kim tập vật lý trị liệu (ở trẻ em)

VI. Gãy liên lồi cầu xương cánh tay

- Là loại gãy rất khó nắn và hay di lệch thứ phát. Do đó cách điều trị thường là phẫu thuật.
- Điều trị bảo tồn chỉ áp dụng cho trường hợp gãy không di lệch. Bó bột cánh - bàn tay giữ 3 tuần, sau đó cắt bột, treo tay và tập khuỷu
- Phẫu thuật bắt nẹp vis, xuyên kim Kirschner cho những trường hợp gãy có di lệch.

VII. Gãy mỏm khuỷu

- Gãy không lệch: bó bột cánh-bàn tay khuỷu gấp 45^0 , giữ 4 tuần cắt bột tập khuỷu.
- Gãy có di lệch: phẫu thuật kết hợp xương bằng phương pháp nẹp ép hoặc vis ép. Cố định vững chắc, tập khuỷu sớm.

VIII. Gãy hai thân xương cẳng tay

- Là loại gãy có di lệch phức tạp và nắn chỉnh khó khăn nhất là ở 1/3 trên
- Điều trị bảo tồn: nắn xương, bó bột cánh - bàn tay, giữ bột 6 tuần
gãy 1/3 trên cẳng tay ngửa hoàn toàn
gãy 2/3 dưới cẳng tay ngửa nhẹ

- Điều trị phẫu thuật: kết hợp xương bằng nẹp vis hay đinh Rush

IX. Gãy trật Monteggia

- Là gãy 1/3 trên xương trụ kèm trật khớp quay-trụ trên
- Điều trị bảo tồn bằng bó bột thường thất bại do di lệch thứ phát nên cần phẫu thuật kết hợp xương
- Điều trị bảo tồn: nắn xương, nắn chỏm quay, bó bột cánh-bàn tay tư thế cẳng tay để ngửa giữ 3 tuần. Nếu chỏm quay không trật ra thì bó bột cánh - bàn tay mới tư thế cẳng tay trung tính, giữ thêm 3 tuần nữa. Nên thường xuyên kiểm tra nếu có di lệch thứ phát thì phẫu thuật.

- Điều trị phẫu thuật: ngay từ đầu hoặc khi điều trị bảo tồn thất bại. Kết hợp xương trụ bằng nẹp vis, bằng đinh Rush.

X. Gãy trật Galeazzi

- Là gãy 1/3 dưới xương quay kèm trật khớp quay - trụ dưới
- Điều trị bảo tồn bằng bó bột thường thất bại do di lệch thứ phát nên cần phẫu thuật kết hợp xương
- Điều trị bảo tồn: nắn xương, bó bột cánh-bàn tay giữ bột 6 tuần. Nên thường xuyên kiểm tra nếu có di lệch thứ phát thì phẫu thuật.

- Điều trị phẫu thuật: ngay từ đầu hoặc khi điều trị bảo tồn thất bại. Kết hợp xương quay bằng nẹp vis, bằng đinh Rush. Nếu khớp quay trụ dưới dễ bị trật lại thì có thể găm kim Kirschner cố định khớp này 4 tuần, sau đó tháo bỏ để tập vận động sắp ngửa.

XI. Gãy đầu dưới xương quay

- Là loại gãy hay gặp ở người lớn tuổi
- Ưu tiên cho điều trị bảo tồn
- Điều trị bảo tồn:

Gãy không thấu khớp: nắn xương, bó bột cẳng - bàn tay giữ bột 4 tuần

Gãy thấu khớp: nắn xương, bó bột cánh-bàn tay giữ bột 6 tuần

- Điều trị phẫu thuật: ngay từ đầu hoặc khi điều trị bảo tồn thất bại. Có thể xuyên kim Kirschner, nẹp vis hay cố định ngoài.

XII. Gãy xương đốt bàn

- Gãy nền xương đốt bàn 1: nắn, bó bột cẳng-bàn tay qua khớp bàn đốt, ngón 1 ở tư thế dạng và đối chiếu, giữ bột 6 tuần. Phẫu thuật bằng cách găm kim Kirschner.

- Gãy nền xương đốt bàn 2 → 5: thường ít di lệch, nên thường bó bột cẳng - bàn tay giữ bột 4 tuần.

- Gãy thân và chỏm xương đốt bàn 1: nắn, bó bột cẳng-bàn tay qua khớp bàn ngón, giữ bột 4 tuần. Mỗi khi nắn thất bại, bằng cách xuyên kim Kirschner nội tủy.

- Gãy thân và chỏm xương đốt bàn 2 → 5: nắn, bó bột cẳng - bàn tay + nẹp Iselin, giữ bột 4 tuần. Mỗi khi nắn thất bại, bằng cách xuyên kim Kirschner nội tủy.

XIII. Gãy xương đốt ngón

- Gãy đốt gần:

☐ Ngón cái: bó bột cẳng - bàn tay qua khớp liên đốt, giữ bột 4 tuần

☐ Các ngón khác: bó bột cẳng - bàn tay + nẹp Iselin ở mặt lòng, giữ bột 4 tuần.

Có thể mổ KHX bằng kim Kirschner xuyên chéo, xuyên nội tủy hoặc đặt nẹp vis

- Gãy đốt giữa:

☐ Ngón cái: bó bột cẳng - bàn tay qua khớp liên đốt, giữ bột 4 tuần, chỉ mổ khi đứt chỗ bám của gân

☐ Các ngón khác: bó bột cẳng - bàn tay + nẹp Iselin ở mặt lòng, giữ bột 4 tuần

- Gãy đốt xa:

☐ Không di lệch: quấn băng keo quanh đốt gần và đốt xa, đốt xa gập nhẹ 20°, giữ 4 tuần.

☐ Gãy đứt chỗ bám gân duỗi: bó bột trong tư thế đốt xa duỗi quá mức hoặc phẫu thuật

VẾT THƯƠNG SỌ NÃO VÀ LỖM SỌ HỖ

I. Khái niệm:

- Lỗm sọ hở: có rách da đầu nơi sọ lõm
- VT sọ não: tổn thương da đầu - xương sọ màng não và mô não, có sự thông thương trực tiếp giữa dịch não tủy - mô não với môi trường bên ngoài.

II. Chẩn đoán:

- Tri giác: có thể mê hoặc tỉnh (đánh giá theo thang điểm: Glasgow)
- Các dấu hiệu thần kinh khu trú: có thể có hoặc không
- Thương tổn tại chỗ: Xương sọ lõm, vỡ nơi vết thương.
- Có dịch não tủy hoặc mô não chảy ra ngoài vết thương.
- Cận lâm sàng: XQ sọ: hình ảnh lõm - vỡ xương sọ. CT Scanner: để phát hiện thêm thương tổn để phối hợp và đánh giá hết tổn thương tại chỗ.

III. Điều trị:

3.1. Điều trị bước đầu tại chỗ:

- Rửa sạch VT bằng nước muối sinh lý
- Cạo tóc quanh VT hoặc hết đầu
- Băng kín VT nhưng không ép.

3.2. Điều trị nội khoa: (Xem phần CTSN chú ý kháng sinh bắt buộc + SAT)

3.3. Phẫu thuật:

3.3.1. Sau khi sơ cứu và làm các CLS cần thiết

3.3.2. Những vấn đề cần đảm bảo trong phẫu thuật.

- Gỡ xương sọ 1 cách tiết kiệm
- Lấy hết: dị vật, mảnh xương vỡ, mô não dập
- Cầm máu tốt
- Nếu có điều kiện nên đóng kín màng cứng.

CHẤN THƯƠNG VÀ VẾT THƯƠNG BỤNG**I. Nguyên nhân và cơ chế:****1.1. Chấn thương kín vùng bụng:**

- Tai nạn giao thông.
- Tai nạn lao động.
- Tai nạn sinh hoạt.
- Đụng đập trực tiếp.
- Thay đổi quán tính.

1.2. Vết thương bụng:

- Thấu bụng:
- + Xuyên thấu.
- + Vết thương chột
- + Vết thương tiếp tuyến.
- Không thấu bụng.

II. Đặc điểm tổn thương:**2.1. Tạng đặc:**

a/ Gan: phân độ tổn thương gan theo Moore

- Độ 1:
 - + Tụ máu dưới bao gan <10% diện tích.
 - + Rách bao gan và nhu mô <1cm chiều sâu.
- Độ 2:
 - + Tụ máu dưới bao gan 10 – 50% diện tích hay trong nhu mô < 10cm đường kính.
 - + Vỡ gan 1 – 3cm chiều sâu và < 10cm chiều dài.
- Độ 3:
 - + Tụ máu dưới bao gan lan rộng > 50% diện tích hay trong nhu mô > 10cm đường kính.
 - + Vỡ > 3cm bề sâu.
- Độ 4: Vỡ trên 75% thùy gan hay từ 1 – 3 hạ phân thùy trong một thùy gan.
- Độ 5:
 - + Vỡ trên 75% thùy gan hay trên 3 hạ phân thùy trong 1 thùy gan.
 - + Có tổn thương mạch máu.
- Độ 6: Gan bị đứt ra khỏi các dây chằng treo gan, cuốn gan.

b/ Lách: phân độ tổn thương lách theo Moore:

- Độ 1:

+ Tụ máu dưới bao lách < 10% diện tích.

+ Rách bao lách, vỡ < 1cm bề sâu.

- Độ 2:

+ Tụ máu dưới bao 10 – 50% diện tích, vỡ trong nhu mô < 5cm bề sâu.

+ Vỡ nhu mô 1 – 3 cm bề sâu, không ảnh hưởng đến mạch máu bề.

- Độ 3:

+ Tụ máu dưới bao > 50% diện tích, vỡ khối máu tụ dưới bao. Tụ máu trong bao trên 5cm bề sâu.

+ Vỡ trên 3cm bề sâu hay có ảnh hưởng mạch máu bề.

- Độ 4: Vỡ thùy lách hay đứt mạch máu rốn lách chi phối 25% lách.

- Độ 5: Vỡ nát và đứt cuốn lách.

c/ Tụy: thường ít tổn thương, nếu có tổn thương thường phối hợp.

d/ Thận: dập thận, vỡ dưới bao, vỡ 1 phần tạo thành khối máu tụ quanh thận, vỡ nát thận, đứt cuốn thận.

2.2. Tạng rỗng:

- Dạ dày.

- Tá tràng.

- Ruột non.

- Đại tràng - trực tràng.

- Bàng quang.

- Cơ hoành.

III. Chẩn đoán:

3.1. Chấn thương bụng kín:

3.1.1. Chẩn đoán mức độ trầm trọng của tổn thương

a/ Xác định hoàn cảnh xảy ra tổn thương:

- Cơ chế chấn thương.

- Tư thế khi bị tai nạn.

- Thời gian từ lúc chấn thương đến lúc nhập viện.

b/ Đánh giá chức năng sinh tồn của bệnh nhân: Mạch, huyết áp, hô hấp, tri giác.

c/ Khám bụng: Vị trí đau, mức độ đau, mẫn cảm vùng bụng, đề kháng thành bụng, khám vùng bìu, tăng sinh môn, thăm trực tràng, âm đạo,...

3.1.2. Cân lâm sàng:

- X quang.

- Xét nghiệm huyết học, sinh hóa.

- Siêu âm bụng.
- CT Scanner bụng: đánh giá mức độ tổn thương của tạng đặc.

3.1.3. Trong ca khẩn cấp có thể chọc dò ổ bụng sẽ giúp chẩn đoán xác định nhanh chóng là có xuất huyết ổ bụng.

3.2. Vết thương bụng:

- Chẩn đoán vị trí vết thương.
- Chẩn đoán nguyên nhân do hỏa khí, bạch khí.
- Chẩn đoán tính chất thấu bụng:
 - + Lâm sàng: hướng đi của tổn thương, lỗ vào, lỗ ra.
 - + Đề kháng thành bụng.
 - + Ra máu hậu môn, miệng sáo,...
 - + Thăm sát vết thương.

IV . Điều trị:

4.1. Điều trị nội:

- Hồi sức
- Lập các đường truyền cấp cứu.
- Kháng sinh trước mổ.
- Thông tiểu.
- Thông dạ dày.
- Xét nghiệm thường quy.

4.2. Điều trị ngoại:

a/ Chỉ định mổ bụng:

- Shock hay huyết động học không ổn định.
- Chọc dò ổ bụng ra máu không đông dễ dàng
- Lòì ruột, mạc nối, hay chảy dịch tiêu hóa qua lỗ vết thương.
- Viêm phúc mạc sớm hay muộn.
- Hơi tự do trong ổ bụng.
- Vỡ thủng cơ hoành.
- Vỡ bàng quang trong phúc mạc.
- CT Scanner thấy rõ tổn thương tụy, ống tiêu hóa, tổn thương gan nặng, lách hay thận.
- Mổ bụng thăm dò.

b/ Đường vào: Đường trắng giữa được nhiều phẫu thuật viên ưa chuộng.

c/ Xử trí nguyên nhân:

- Tùy tổn thương mà phẫu thuật viên xử lý cho phù hợp như khâu gan, cắt lách, khâu ruột, cắt khối tá tụy...

- Chú ý thăm sát toàn bộ ổ bụng tránh bỏ sót tổn thương. Theo những nguyên tắc: như nguyên tắc số chấn trong tổn thương ruột, hay nguyên tắc đối diện.

d/ Chăm sóc sau mổ:

- Hồi sức, bù nước điện giải.
- Kháng sinh.
- Giảm đau.
- Nuôi ăn.

e/ Biến chứng:

- Chảy máu.
- Bỏ sót tổn thương.
- Nhiễm trùng vết mổ.
- Viêm phúc mạc sớm.
- Áp xe tồn lưu.

RÒ HẬU MÔN

Rò hậu môn là bệnh rất thường gặp ở vùng hậu môn, đứng thứ hai sau trĩ.

Rò hậu môn và áp se hậu môn trực tràng là hai giai đoạn của một quá trình nhiễm trùng mưng mủ của vùng này. Áp xe là giai đoạn cấp tính và rò là giai đoạn mãn tính.

I. Nguyên nhân:

- Rò hậu môn bao giờ cũng bắt nguồn từ áp xe hậu môn.
- Vi khuẩn thường là *Esecherychia Coli*, tụ cầu khuẩn, liên cầu khuẩn.
- Do lao, do Crohn.

II. Thương tổn:

- Lỗ trong: là lỗ nguyên thủy.
- Có thể có 1 hoặc nhiều lỗ ngoài.
- Đường rò có thể đơn giản hay phức tạp.
- Định luật Goodsall:

Bệnh nhân nằm ở tư thế sản phụ khoa, kẻ đường ngang đi qua lỗ hậu môn.

* Trong loại rò mà lỗ rò ngoài nằm trước đường ngang thì đường rò đi theo hướng nang hoa đi thẳng vào đường lược.

* Trong loại rò mà lỗ rò ngoài nằm sau đường ngang thì lỗ rò trong nằm ở vị trí sáu giờ.

III. Phân loại:

- **Rò dưới niêm mạc:** đường rò, lỗ trong, lỗ ngoài hoàn toàn nằm trong lòng hậu môn.

- **Rò dưới niêm mạc da:** Lỗ trong ở niêm mạc lỗ rò ngoài ở da gần hậu môn.

- **Rò liên cơ thắt:** lỗ rò ngoài nằm ở phí ngoài và gần lỗ hậu môn.

- **Rò xuyên cơ thắt:** đường rò đi xuyên qua phần dưới các cơ thắt hậu môn, lỗ ngoài nằm xa lỗ hậu môn.

- **Rò xuyên cơ thắt cao:** đường rò xuyên qua phần trên các cơ thắt, lỗ ngoài nằm xa lỗ hậu môn.

- **Rò trên cơ thắt:** đường rò đi ngay bờ trên cơ thắt, lỗ ngoài nằm xa lỗ hậu môn.

- **Rò ngoài cơ thắt:** Đường rò đi từ khoang trên cơ nâng xuyên qua cơ nâng để ra ngoài da.

IV. Triệu chứng:

- Triệu chứng lâm sàng nghèo nàn.
- Vài tháng trước có nhọt hậu môn, dập ra tái đi tái lại nhiều lần
- Bệnh nhân khai trung tiện hoặc đại tiện xì ra lỗ rò

- Bệnh nhân đến khám vì nước vàng, mủ chảy ra lỗ rò làm ẩm ướt, ngứa ngáy khó chịu và đũng quần lót luôn vậy bẩn.

- Khám:

+ Vị trí lỗ rò ngoài:

+ Có thể một lỗ hay nhiều lỗ.

+ Thăm trực tràng kết hợp với tay ngoài có thể định hướng được hướng đi của đường rò.

- Chụp X quang đường rò cản quang giúp xác định đường rò.

V. Điều trị:

5.1. Nguyên tắc:

- Lấy hết đường rò.

- Không làm tổn thương cơ thắt.

5.2. Chuẩn bị trước mổ:

- Điều trị nguyên nhân gây rò.

- Phẫu thuật khi có điều kiện thuận lợi nhất.

- Làm sạch đại tràng: bơm thuốc Fleettenema.

5.3. Vô cảm: thường là gây tê tủy sống.

5.4. Đánh giá tổn thương:

- Tìm lỗ trong qua bơm hơi hoặc xanh Methylen qua lỗ ngoài.

- Dùng que thăm dò.

5.5. Phẫu thuật cắt đường rò: có thể khâu kín hoặc để hở.

Dùng KS và giảm đau sau mổ.

THÙNG DẠ DÀY – TÁ TRÀNG

I. ĐẠI CƯƠNG:

Thùng dạ dày, còn gọi là thùng dạ dày-tá tràng hay thùng ổ loét tiêu hóa là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp tại Việt Nam, đứng hàng thứ hai sau viêm ruột thừa trong cấp cứu ngoại khoa về bụng.

Gọi là thùng dạ dày khi có sự thông thương các chất trong dạ dày-tá tràng vào xoang phúc mạc qua ổ loét. Xuất độ thùng dạ dày vào khoảng 7-10/100.000 người/năm. Và chiếm 7% số bệnh nhân nhập viện vì loét tiêu hóa. Xuất độ thùng của những bệnh nhân loét hành tá tràng là 0,3% / năm.

Nguyên nhân:

- Loét dạ dày-tá tràng là nguyên nhân thường gặp nhất.
- Ung thư dạ dày.
- Loét Curling, loét Cushing, hội chứng Zollinger-Ellison, bệnh nhân đã được ghép cơ quan, thuốc kháng viêm không có nhân steroid, Corticosteroid cũng có thể có vai trò gây thùng.

II. CHẨN ĐOÁN

Chủ yếu dựa vào 5 tiêu chuẩn sau đây:

- Bệnh sử đau đột ngột dữ dội ở thượng vị.
- Tiền sử có đau thượng vị.
- Gõ mất vùng đục trước gan.
- Sờ bụng thấy co cứng hoặc cảm ứng phúc mạc.
- X quang bụng hoặc ngực thẳng thấy khí tự do dưới cơ hoành.

III. ĐIỀU TRỊ

Nguyên tắc điều trị thùng dạ dày – tá tràng do loét là khâu lỗ thùng có hoặc không có kèm theo phẫu thuật điều trị bệnh loét.

Gồm điều trị trước, trong và sau mổ.

3.1. Điều trị trước mổ:

Bao gồm 8 bước chính sau đây:

- Cho thuốc giảm đau khi có chẩn đoán xác định. Có thể cho Morphin, Dolargan, Nisidol...
- Đặt ống Levin.
- Nhịn ăn.
- Truyền dịch.
- Đặt thông tiểu.
- Cho kháng sinh. Có thể dùng Cephalosporin thế hệ thứ 2 hoặc 3; hoặc dùng Ampicillin + aminoglycoside; hoặc một trong các kháng sinh trên + metronidazole.

- Đo ECG khi có chẩn đoán phân biệt với nhồi máu cơ tim hoặc những bệnh nhân lớn tuổi có nguy cơ cao.

- Giải thích cho bệnh nhân và gia đình và làm giấy cam đoan.

3.2. Phẫu thuật:

Gồm 2 loại phẫu thuật: các phẫu thuật điều trị biến chứng thủng và các phẫu thuật vừa điều trị thủng vừa điều trị bệnh loét.

Các phẫu thuật để điều trị bệnh loét như cắt bán phần dạ dày hoặc cắt thần kinh X có thể được áp dụng để vừa điều trị loét vừa giải quyết được biến chứng thủng. Nhưng chỉ được áp dụng trong một số trường hợp nhất định. Những điều kiện chung để áp dụng các phương pháp này là:

- Thủng sớm, được phẫu thuật trước 24 giờ.
- Toàn trạng bệnh nhân cho phép kéo dài thời gian mổ.
- Phẫu thuật viên có thể thực hiện phương pháp phẫu thuật này thành thạo.
- Ê kíp gây mê và trang thiết bị đầy đủ.

Khâu lỗ thủng:

3.2.1. Mổ nội soi:

Đánh giá lỗ thủng và tình trạng xoang bụng như trong mổ mở. Khâu lỗ thủng bằng chỉ vicryl 1.0 hoặc 2.0 mũi chữ X hoặc mũi gấp (chữ I) rồi cột trong. Có thể dùng clip để làm kín lỗ thủng hoặc dùng keo Gelatin.

Mổ khâu lỗ thủng qua nội soi ổ bụng có những ưu điểm sau:

- Bệnh nhân mau hồi phục sau mổ.
- Trung tiện sớm hơn.
- Thâm mỹ hơn.
- Có thể ra viện sớm hơn.

Chỉ định khâu lỗ thủng qua nội soi:

- + Thời gian thủng trước 24 giờ.
- + Vị trí lỗ thủng ở vùng tiền môn vị hoặc mặt trước hành tá tràng.
- + Kích thước lỗ thủng < 10mm.

3.2.2. Mổ mở:

- Mổ bụng đường giữa trên rốn.
- Xác định vị trí lỗ thủng, kích thước lỗ thủng và đánh giá xem có hẹp môn vị không.
- Nếu thủng ổ loét dạ dày, phải sinh thiết bờ lỗ thủng.
- Khâu lỗ thủng, có thể đắp mạc nối hoặc không. Khi đắp mạc nối có thể theo một trong 2 cách sau đây: phương pháp Roscoe Graham hoặc phương pháp Cellan-Jones.
- Đánh giá lại môn vị sau khi khâu lỗ thủng.

- Nếu môn vị hẹp phải nối vị tràng hoặc dùng các phẫu thuật điều trị triệt để khác như cắt 2/3 dạ dày hoặc cắt thần kinh X tại thân + cắt hang vị hay các phẫu thuật khác.

- Rửa bụng và dẫn lưu ổ bụng.

3.3. Chăm sóc sau mổ:

Giống như các trường hợp phẫu thuật khác về ống tiêu hóa. Nhưng lưu ý đến một số điểm đặc biệt sau đây:

Nếu bệnh nhân chỉ được khâu lỗ thủng đơn thuần tức chỉ điều trị biến chứng thủng, chúng ta phải tiếp tục điều trị nội khoa để làm lành ổ loét theo các nguyên tắc sau đây:

- Dùng thuốc làm giảm tiết acid (ức chế thụ thể H_2 hoặc ức chế bơm proton).
- Dùng thuốc kháng acid.
- Dùng thuốc băng niêm mạc dạ dày-tá tràng.
- Tiêu diệt xoắn khuẩn *Helicobacter pylori* (theo phác đồ điều trị của khoa nội)
- Thay đổi chế độ sinh hoạt và ăn uống, ví dụ phải bỏ hút thuốc lá.

Nếu ổ loét không khỏi sau điều trị nội khoa mới chỉ định can thiệp phẫu thuật.

Nếu ổ loét dạ dày có kết quả sinh thiết là ung thư phải đánh giá toàn trạng bệnh nhân để mổ cắt dạ dày.

TRĨ

Bệnh trĩ rất thường gặp, nhất là ở những người lớn tuổi. Một thống kê của nước ngoài cho tỷ lệ mắc bệnh người trên 50 tuổi là 50%.

I. Nguyên nhân và yếu tố thuận lợi:

- Tư thế đứng: Người đứng lâu, ngồi nhiều.
- Táo bón kinh niên.
- Hội chứng ly.
- Hội chứng ruột kích thích.
- Tăng áp lực ổ bụng.
- U bướu vùng hậu môn, trực tràng và vùng xung quanh.

II. Tổn thương:

2.1. Trĩ nội: Nằm dưới niêm mạc, phía trên đường lược.

- Độ I: Búi trĩ sa thấp xuống dưới đường lược nhưng vẫn nằm hoàn toàn trong ống hậu môn.

- Độ II: Búi trĩ ra ngoài khi rặn, tự lên được.
- Độ III: Búi trĩ sa ra ngoài khi rặn, phải nhét vào.
- Độ IV: Búi trĩ gần như nằm ngoài ống hậu môn, nhét vào cũng tụt ra ngay.

2.2. Trĩ ngoại: Nằm ngoài ống hậu môn, bao bọc búi trĩ ngoài là da.

2.3. Trĩ hỗn hợp: Kết hợp giữa trĩ nội và ngoại.

2.4. Trĩ vòng:

Trĩ nội cộng trĩ ngoại tạo thành trĩ hỗn hợp. Trĩ hỗn hợp to lên, giữa các búi trĩ chính xuất hiện búi trĩ phụ kèm, chúng liên kết với nhau tạo thành một vòng tròn.

III. Triệu chứng:

- Chảy máu.
- Sa búi trĩ ra ngoài ống hậu môn.
- Đau: chỉ xuất hiện khi có biến chứng tắc mạch, sa nghẹt.
- Khám:

+ Nhìn thấy xung quanh hậu môn phồng lên, căng bóng, mất nếp nhăn bình thường. Là trĩ ngoại.

- + Cảm thấy búi trĩ thò ra ngoài khi rặn.
- + Thấy rõ 3 búi trĩ thò ra ngoài hay trĩ vòng, trĩ hỗn hợp.
- Soi hậu môn giúp xác định trĩ.

IV. Chẩn đoán: lâm sàng kết hợp nội soi hậu môn

V. Điều trị:

5.1. Nguyên tắc:

- Không điều trị trĩ triệu chứng, trừ khi có biến chứng.
- Điều trị yếu tố thuận lợi.
- Trĩ có nhiều loại hỗn hợp, nhiều mức độ và hình thái. Nên chọn phương pháp điều trị thích hợp.
- Không gây các hậu quả xấu hơn, những rối loạn của bệnh trĩ.

5.2. Ngăn chặn các yếu tố thuận lợi:

- Chế độ ăn uống: ăn nhiều rau, trái cây, uống nhiều nước, cử rượu, thuốc lá, chất cay, tránh táo bón.
- Chế độ sinh hoạt: tránh ngồi lâu, đứng nhiều, tập đại tiện đúng giờ.
- Chế độ làm việc: tránh làm việc nặng, tăng áp lực ổ bụng.
- Điều trị các rối loạn đại tiện.
- Điều trị các bệnh lý mãn tính hiện có.

5.3. Điều trị nội khoa:

- Thuốc tăng cường thành mạch: Daflone, Ginkorfort.
- Giảm đau.
- Chống phù nề.
- Điều trị nội khoa chỉ có kết quả đối với trĩ độ I và độ II. Chỉ định trong các ca, cơn trĩ cấp tính. Để chuẩn bị cho các phương pháp điều trị khác.

5.4. Điều trị ngoại khoa: chuẩn bị làm sạch hậu môn trực tràng trước mổ.

5.4.1. Chỉ định:

- Trĩ độ II, có biến chứng, không đáp ứng điều trị nội.
- Trĩ độ III, IV, trĩ hỗn hợp, trĩ vòng.

5.4.2. Phẫu thuật:

- Milligan Morgan.
- Phẫu thuật Longo.

VI. Biến chứng và săn sóc sau phẫu thuật:

- Đau.
- Chảy máu:
 - + Cầm máu kỹ trong mổ.
 - + Nếu chảy máu nhiều phải mổ lại để cầm máu.
- Bí tiểu, nhiễm trùng tiểu.
- Nhiễm trùng tại chỗ.
- + Ngâm hậu môn bằng nước ấm.
- + Kháng sinh.

- Hẹp hậu môn:

+ Nông hậu môn hàng ngày.

+ Hẹp nhiều phải tạo hình hậu môn.

- Đại tiện mất tự chủ:

+ Són phân, nếu tổn thương một phần cơ thắt có thể tự hồi phục.

+ Mất tự chủ: điều trị tổn thương này rất khó khăn và phức tạp.

- Tái phát trĩ:

+ Xảy ra sau vài tháng, vài năm.

+ Phụ thuộc vào công việc có liên quan đến các yếu tố thuận lợi, đến phương pháp mổ và trình độ của phẫu thuật viên.

VIÊM RUỘT THỪA

I. ĐẠI CƯƠNG:

Viêm ruột thừa là một cấp cứu ngoại khoa thường gặp, chiếm khoảng 60 – 70% các cấp cứu về bụng. Nếu được chẩn đoán sớm tỉ lệ tử vong rất thấp khoảng 0,1% - 0,2%. Nếu mổ khi bệnh có biến chứng tỉ lệ tử vong lên đến khoảng 10%.

II. CHẨN ĐOÁN:

2.1. Triệu chứng lâm sàng:

Triệu chứng cơ năng: đau bụng quanh rốn hay thượng vị sau khu trú hố chậu (P) hoặc 1/4 bụng dưới bên (P).

Triệu chứng thực thể: khám bụng vùng hố chậu (P). Nếu bệnh nhân đến sớm, đau nhiều nhất ở điểm Mc Burney; nếu đến trễ, đau cả 1/4 bụng dưới (P) kèm phản ứng dội, phản ứng co cứng cơ thành bụng. Thăm trực tràng đau nhói cùng đồ (P).

2.2. Cận lâm sàng:

- Công thức máu: bạch cầu tăng $> 10000/\text{mm}^3$ (khoảng 80-85%), bạch cầu đa nhân trung tính tăng $> 75\%$.

- Siêu âm: cho thấy hình ảnh viêm ruột thừa (hình bia, dấu ngón tay), độ nhạy siêu âm # 85%.

- CRP tăng.

- CT-Scan bụng: những trường hợp khó chẩn đoán.

III. ĐIỀU TRỊ :

3.1. VIÊM RUỘT THỪA CẤP.

Sau khi đã chẩn đoán xác định, cần khẩn trương mổ cấp cứu để tránh những biến chứng có thể xảy ra.

3.1.1. Chuẩn bị trước mổ.

- ☐ Hạ sốt nếu thân nhiệt $> 39^\circ\text{C}$.
- ☐ Truyền dịch nếu lượng nước tiểu ít.
- ☐ Kháng sinh trước mổ.

Tuy nhiên có nhiều ca viêm ruột thừa cấp không sốt cao, có thể dùng một liều kháng sinh trước mổ là đủ.

- Bệnh nhân được gây mê NKQ.

3.1.2. Phẫu thuật:

☐ Cắt ruột thừa nội soi hoặc mổ mở (đường Mc Burney, cạnh bên hoặc đường chẩn giữa).

- ☐ Không cần dẫn lưu
- ☐ Kháng sinh.

□ Cho bệnh nhân xoay trở và đi lại sớm, cho bệnh nhân ăn chất lỏng dễ tiêu khi có trung tiện.

3.2. ĐÁM QUÁNH RUỘT THỪA.

Không có chỉ định mổ. Cần xác định rõ đám quánh ruột thừa với áp-xe cùng ruột thừa, vì việc điều trị hoàn toàn khác nhau.

Đối với đám quánh ruột thừa, vì ruột thừa đã được mạc nối ruột đến bám chặt, nếu cố gắng bóc tách sẽ làm thủng ruột, chảy máu mà không cắt được ruột thừa, trường hợp này nên điều trị kháng sinh và hẹn 3 tháng sau đến cắt ruột thừa.

3.3. ABCÈS RUỘT THỪA.

a. Đối với các ổ abcès đã dính vào thành bụng trước bên, mổ dẫn lưu ngoài phúc mạc, hẹn sau 3 tháng trở lại cắt ruột thừa.

b. Đối với các ổ abcès trong ổ bụng, tiểu khung hay phúc mạc thành sau. Phẫu thuật cắt ruột thừa nội soi hoặc mổ mở (mổ đường cạnh bên hoặc đường chẵn giữa) hút sạch mủ, lấy mủ soi, cấy, làm KSD, dẫn lưu ổ abcès, nếu không cắt được ruột thừa thì hẹn 3 tháng sau đến cắt, tuy nhiên đa số các trường hợp đều cắt được ruột thừa.

Hậu phẫu: - Kháng sinh điều trị

- Chăm sóc vết mổ và tình trạng bụng cho đến khi bệnh nhân trung tiện được. Cho ăn lỏng chất dễ tiêu và rút ODL khi đã hết dịch bẩn.

3.4. VIÊM PHÚC MẠC KHU TRÚ:

Cần hỏi sức bệnh nhân trước mổ:

- a. Dịch truyền theo dõi lượng nước tiểu.
- b. Hạ nhiệt
- c. Kháng sinh trước mổ

* Phẫu thuật :

- Cắt ruột thừa nội soi hoặc mổ mở (mổ đường cạnh bên hoặc đường chẵn giữa).

Vào bụng cắt ruột thừa và hút, lau sạch mủ, lấy mủ soi, cấy, làm KSD, dẫn lưu hô manh tràng. Hậu phẫu theo dõi tình trạng bụng cho đến khi có trung tiện cho bệnh nhân ăn thức ăn lỏng dễ tiêu. Theo dõi dịch ống dẫn lưu và rút khi ống dẫn lưu ra hết dịch bẩn.

3.5. VIÊM PHÚC MẠC TOÀN THỂ:

a. Hỏi sức tích cực cho đến khi tình trạng bệnh nhân tương đối ổn định.

- Đưa thân nhiệt xuống $< 38^{\circ}\text{C}$
- Kháng sinh đường tĩnh mạch.
- Theo dõi lượng nước tiểu.

b. Phẫu thuật:

Cắt ruột thừa nội soi hoặc mổ mở (đường Mc Burney, cạnh bên hoặc đường chẵn giữa).

Vào ổ bụng hút sạch mủ, lấy mủ soi, cấy, làm KSD cắt ruột thừa, rửa và dẫn lưu Douglas, tiếp tục cho kháng sinh sau khi mổ và theo dõi sát tình trạng bụng cho đến khi bệnh nhân có trung tiện và đi lại được, theo dõi các biến chứng sau mổ.

IV. BIẾN CHỨNG SAU MỔ:

4.1. Biến chứng sớm:

4.1.1. Chảy máu:

- a. Chảy máu vết mổ, xử trí kẹp và cột vết chảy máu ngoài vết mổ.
- b. Ca chảy máu trong ổ bụng:

Nguyên nhân do: tụt chỉ cột động mạch mạc treo ruột thừa.

Biểu hiện lâm sàng: Dấu hiệu mất máu, mạch nhanh, HA tụt, nếu có ODL sẽ thấy máu tươi ra ODL.

4.1.2. Viêm phúc mạc sau khi mổ:

Nguyên nhân:

- Do sau khi mổ lấy không hết mủ
- Do tụt chỉ mổ cắt ruột thừa. Viêm phúc mạc có thể khu trú hay toàn thể, biến chứng viêm phúc mạc thường xảy ra ngày thứ 4, thứ 5 sau mổ.

4.1.3. Abscess tồn lưu:

Nguyên nhân do trong khi lau xoang bụng không kỹ, abscess được quai ruột và mạc nối đến bám vào và bao bọc lại, có thể abscess xảy ra ở Douglas, dưới hóc gan, hóc lách và giữa các quai ruột.

4.1.4. Dò manh tràng.

Xảy ra ngày thứ 4, thứ 5 sau mổ thấy dịch vàng chảy ra sau đó là phân, theo dõi tình trạng bụng bệnh nhân vẫn trung tiện được, không có dấu hiệu viêm phúc mạc, cần chăm sóc HP nơi nhiễm trùng chân ODL cho đến khi dịch ODL ra hết phân.

4.1.5. Nhiễm trùng vết mổ.

Là biến chứng thường gặp, nhất là khi bệnh nhân đến trễ mổ xì ra vết mổ trong lúc mở bụng. Cần chăm sóc tại chỗ và kháng sinh

4.2. Biến chứng muộn:

Tắc ruột sau mổ là biến chứng hay gặp, nhất là những bệnh nhân đến trễ ruột thừa vỡ mủ gây viêm phúc mạc.

CHƯƠNG 8: LIÊN CHUYÊN KHOA**BÔNG MẮT DO HÓA CHẤT****1. ĐẠI CƯƠNG:**

Bông mắt do hoá chất là một cấp cứu đặc biệt trong nhãn khoa, bông có thể bị ở một mắt hoặc bị cả hai mắt và có thể bông rất nặng. Tổn thương cả mi cũng nhờ kết giác mạc và tổ chức nội nhãn, điều trị gặp nhiều khó khăn. Tiên lượng dè dặt có thể gây mù không hồi phục.

Thái độ xử trí ban đầu giúp nhiều đến tiên lượng của bệnh.

2. NGUYÊN NHÂN:

– Bông do axit gồm các loại như axit vô cơ (axit sunfuric, axit Clohydric) hay axit hữu cơ.

– Bông do bazơ như bông vôi, bông kiềm.

3. CHẨN ĐOÁN:**a. Lâm sàng**

– Cơ năng

+ Đau rát mắt, kích thích dữ dội, khó mở mắt, chảy nước mắt dãn dụa.

+ Nhìn mờ hoặc không nhìn thấy gì.

– Thực thể

+ Mi mắt bông các mức độ, đặc biệt bờ mi, có thể điểm lệ cũng bị tổn thương.

+ Kết mạc có thể gặp: cương tụ, phù kết mạc, chấm xuất huyết xung quanh rìa, xuất huyết dưới kết mạc, thiếu máu kết mạc test Amler (+).

+ Giác mạc có thể mờ đục nhẹ, có thể xước biểu mô giác mạc hay nặng hơn là giác mạc mờ đục thậm chí đục trắng sứ, nên không thấy mống mắt, thể thủy tinh.

+ Có phản ứng với màng bồ đào: Tyndal (+), dính mống mắt, có thể tăng nhãn áp.

+ Đo độ Ph xác định tính chất bông là axit hay bông kiềm.

– Triệu chứng toàn thân

+ Mệt mỏi, lo lắng, hoảng hốt

+ Nếu bông nặng, có diện tích bông rộng có thể gây sốc.

b. Cận lâm sàng

– Siêu âm: xác định các tổn thương phối hợp.

– XQ: xác định những tổn thương phối hợp ngoại vật nội nhãn trong ổ (Ví dụ ngoại vật bình ắc-quy).

– Đo pH

c. Phân loại bỏng

Theo phân loại của Poliak (1957): Bỏng được chia làm 4 độ

Độ	Biểu hiện ở mi	Biểu hiện ở kết mạc và củng mạc	Biểu hiện ở giác mạc
I	Cương tụ da	Cương tụ kết mạc	Chợt biểu mô nông
II	Bọng nước	Màng giả (Thiếu máu kết mạc)	Đục nông, vẫn thấy rõ hình ảnh móng mắt
III	Hoại tử da	Hoại tử kết mạc một phần	Đục sâu không hoàn toàn (như kính mờ)
IV	Hoại tử dưới da và sụn	Hoại tử kết mạc và củng mạc	Đục sâu hoàn toàn (màu trắng sứ)

d. Chẩn đoán xác định

- Dựa vào hỏi bệnh
- Dựa vào các triệu chứng lâm sàng như đau nhức, nhìn mờ, bọng mi, bọng kết mạc ở các mức độ, bọng giác mạc ở các mức độ.
- Đo pH
- Cận lâm sàng như siêu âm và X quang tìm các tổn thương phối hợp.

e. Chẩn đoán phân biệt

Phân biệt giữa bỏng axit hay bỏng bazơ.

4. ĐIỀU TRỊ

a. Nguyên tắc chung

- Loại trừ chất gây bỏng.
- Chống đau.
- Chống nhiễm khuẩn.
- Chống dính.
- Tăng cường dinh dưỡng giác mạc.
- Điều trị biến chứng, di chứng.
- Điều trị ngoại khoa khi cần thiết.

b. Điều trị cụ thể

– Rửa mắt, rửa nhiều nước, nhiều lần, mỗi lần rửa ít nhất 15' - 30'. Dung dịch để rửa mắt là nước muối sinh lý, dung dịch Ringer hoặc nước sạch sẵn có tại nơi xảy ra tai nạn. Tốt nhất là truyền nhỏ giọt liên tục Ringer. Mục đích rửa mắt làm loãng chất gây bỏng và giảm độc tố chất gây bỏng.

– Lấy hết dị vật nếu có, kiểm tra kỹ ở các túi cùng, đặc biệt với bông vôi phải lấy hết vôi. Vì vậy phải bóc lộ cùng đồ rộng bằng hai vành mi, lấy dị vật bằng panh.

– Chú ý: trường hợp bông vôi sống, trước khi rửa phải lấy hết vôi bám kết mạc sau đó rửa mắt.

– Chống đau bằng các thuốc an thần, giảm đau tại chỗ và toàn thân. Chú ý khi sử dụng các thuốc giảm đau tại chỗ như Dicain nhỏ mắt nhiều có thể gây độc cho biểu mô. Thuốc giảm đau toàn thân như Paracetamol (Efferangan...).

– Chống nhiễm khuẩn, chống viêm

– Điều trị chủ yếu để lớp biểu mô giác mạc tái tạo tránh loét, thủng giác mạc. Sau bông trên nền loét giác mạc có thể gặp nhiễm trùng thứ phát.

– Kháng sinh tra và uống kết hợp: kháng sinh phổ rộng như Quinolol thế hệ 3,4(Moxifloxacin, Gatifloxacin, Ciprofloxacin) nhỏ 4-6 lần/ngày; mỡ Tetracyclin. Đường uống sử dụng nhóm Cephalosporin thế hệ 3: 15mg/kg cân nặng uống hoặc truyền tĩnh mạch.

– Corticosteroid tại chỗ và toàn thân: tác dụng chống viêm màng bồ đào, dừng quá trình phát triển tân mạch vào giác mạc trong 2-3 tuần đầu sau bông.

– Atropin 1%: tác dụng chống viêm chống dính. Nếu tăng nhãn áp uống Acetazolamide.

– Chống dính: rửa mắt lau sạch tiết tổ hàng ngày, tách dính cùng đồ và hướng dẫn bệnh nhân tập vận động nhãn cầu, không được băng mắt.

– Các thuốc tăng cường dinh dưỡng: CB2, nước mắt nhân tạo, các thuốc tăng cường dinh dưỡng toàn thân.

– Kính tiếp xúc: có thể dùng sau vài tuần để bảo vệ lớp biểu mô và mô nhục, giúp lớp biểu mô tái tạo nhanh.

– Điều trị biến chứng: điều trị các biến chứng như viêm màng bồ đào, tăng nhãn áp bằng các thuốc kháng sinh, chống viêm và hạ nhãn áp tại chỗ và toàn thân.

5. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG

– Đặc điểm của hoá chất là quá trình tiến triển nặng đặc biệt bông kiềm thì càng tiên lượng khó khăn hơn, phụ thuộc vào những yếu tố sau:

+ Mức độ thiếu máu kết mạc

+ Tình trạng hờ mi

+ Tình trạng giác mạc: giác mạc không có lớp biểu mô che phủ sẽ phát triển màng máu từ kết mạc vào giác mạc. Loét giác mạc mãn tính, mạch máu xâm nhập vào lớp nhu mô làm cho giác mạc mờ đục và thị lực giảm.

– Những tổn thương nhãn cầu kết hợp:

+ Khô mắt do tắc ống bài tiết nước mắt.

+ Tăng nhãn áp do tổn thương góc.

+ Đục thể thủy tinh thứ phát với nghìn đồng tử.

6. PHÒNG BỆNH

- Giáo dục ý thức phòng chống tai nạn bỏng mắt cho tất cả mọi người.
- Đối với những người làm nghề có nguy cơ bỏng cao phải được trang bị đồ dùng bảo hộ lao động và chấp hành tốt các nội qui quy định về an toàn lao động.
- Cải thiện điều kiện làm việc: nơi làm việc phải thoáng khí, đủ ánh sáng, đủ rộng, không quá chật chội.
- Tổ chức tuyến sơ cứu, cấp cứu và xử trí tốt từ cơ sở lên đến tuyến trên. Cần phải chẩn đoán, xử trí kịp thời trong giai đoạn cấp cứu.

VIÊM KẾT MẠC CẤP

1. ĐẠI CƯƠNG

Viêm kết mạc cấp là tình trạng viêm cấp tính của kết mạc, thường do nhiễm trùng (do virus, vi khuẩn) hoặc dị ứng.

Viêm kết mạc cấp có nhiều hình thái:

– Viêm kết mạc cấp tiết tổ mủ do vi khuẩn: Đây là hình thái viêm kết mạc dạng nhú tối cấp.

– Viêm kết mạc cấp tiết tổ màng do vi khuẩn: là loại viêm kết mạc cấp tiết tổ có màng phủ trên diện kết mạc, có màu trắng xám hoặc trắng ngà. – Viêm kết mạc do virus: Là viêm kết mạc có kèm nhú, nhiều tiết tổ và hoặc có giả mạc, bệnh thường kèm sốt nhẹ và các biểu hiện cảm cúm, có hạch trước tai, thường phát triển thành dịch.

2. NGUYÊN NHÂN

Viêm kết mạc cấp tiết tổ mủ do vi khuẩn: thường gặp do lậu cầu (*Neisseria Gonorrhoeae*), hiếm gặp do não cầu (*Neisseria Meningitidis*).

– Viêm kết mạc cấp tiết tổ màng do vi khuẩn: thường gặp do vi khuẩn bạch hầu (*C. Diphtheria*) và liên cầu (*Streptococcus Pyogene*), phế cầu,...

– Viêm kết mạc do vi rus: do virus Adeno virus, Entero virus ...

3. CHẨN ĐOÁN

a. Lâm sàng

– Tại mắt:

Bệnh xuất hiện lúc đầu ở một mắt, sau đó lan sang hai mắt. Thời gian ủ bệnh từ vài giờ đến vài ngày, thường mủ nhiều nhất vào ngày thứ 5. Bệnh diễn biến rất nhanh:

+ Mi phù nề + Kết mạc cương tụ, phù nề mạnh. Có nhiều tiết tổ mủ bản, hình thành rất nhanh sau khi lau sạch.

+ Có thể có xuất tiết hoặc màng giả.

+ Nếu không điều trị kịp thời giác mạc bị thâm nhiễm rộng, tiến triển thành áp xe giác mạc và có thể hoại tử thủng giác mạc.

– Toàn thân:

+ Có thể có hạch trước tai, sốt nhẹ.

b. Cận lâm sàng

– Nhuộm soi: Nhuộm gram.

– Nuôi cấy trên môi trường thạch máu: phân lập vi khuẩn.

c. Chẩn đoán xác định

– Tại mắt

+ Mi phù nề.

- + Kết mạc cương tụ, phù nề mạnh, có nhiều tiết tố bản.
- Toàn thân
- + Có thể có sốt.
- + Có hạch trước tai.

d. Hình thái

- Viêm kết mạc cấp tiết tố có mủ.
- + Thời gian ủ bệnh từ vài giờ đến vài ngày, thường mủ nhiều nhất vào ngày thứ 5. Bệnh diễn biến rất nhanh.
- + Bệnh xuất hiện ở một mắt, sau đó lan sang hai mắt.
- + Có nhiều tiết tố mủ bản, hình thành rất nhanh sau khi lau sạch.
- + Xét nghiệm: Nhuộm soi (tiết tố mủ kết mạc): có song cầu khuẩn Gram (-) hình hạt cà phê.

- Viêm kết mạc cấp tiết tố màng do vi khuẩn.

Tại mắt:

- + Mi phù nề, căng cứng khó mở. Sau 1-3 ngày mi mềm dần.
- + Kết mạc cương tụ, phù nề. Sau 1-3 ngày xuất hiện màng thật hoặc màng giả trên bề mặt kết mạc. Màng thường bản, màu xám. Màng thật khi bóc sẽ lộ lớp tổ chức liên kết phía dưới và chảy máu nhiều. Màng giả bóc dễ dàng và ít chảy máu.
- + Nếu không điều trị kịp thời có thể bị viêm loét giác mạc, viêm nội nhãn. Toàn thân: Có thể có sốt, khó thở.

Cận lâm sàng:

- + Nhuộm soi: Vi khuẩn Gram (+)
 - + Nuôi cấy: phân lập vi khuẩn.
 - Viêm kết mạc do virus Tại mắt:
 - + Cảm giác xốn cộm như có bụi trong mắt.
 - + Mi phù nề.
 - + Kết mạc cương tụ, phù nề, ra nhiều tiết tố trắng hoặc dịch hồng.
 - + Sau 3-5 ngày có thể thấy có giả mạc màu trắng ở kết mạc sụn mi dày mỏng tùy từng trường hợp.
 - + Giác mạc có thể viêm chấm biểu mô.
- Toàn thân:
- + Triệu chứng cảm cúm: nhức đầu nhẹ, đau mỏi người sốt nhẹ...
 - + Hạch trước tai.

4. ĐIỀU TRỊ

a. Nguyên tắc điều trị

- Điều trị tích cực và khẩn trương
- Điều trị tại chỗ và toàn thân
- Điều trị theo nguyên nhân
- Phát hiện nguồn lây để điều trị và phòng lây lan

b. Phác đồ điều trị

- Tại mắt:
 - + Bóc màng hằng ngày
 - + Rửa mắt liên tục bằng nước muối sinh lý 0,9 % để loại trừ mủ và tiết tố + Trong những ngày đầu bệnh diễn biến nhanh, tra nhiều lần thuốc dưới dạng dung dịch (15-30 phút/lần) một trong các nhóm sau:
 - + Aminoglycosid: tobramycin...
 - + Fluoroquinolon: ofloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin...
 - + Thận trọng khi dùng Corticoid: Prednisolon acetat, Fluorometholon. Khi bệnh thuyên giảm có thể giảm số lần tra mắt. Phối hợp tra thuốc mỡ một trong các nhóm trên trưa và tối.
 - + Dinh dưỡng giác mạc và nước mắt nhân tạo.
- Toàn thân: Chỉ dùng trong viêm kết mạc do lậu cầu, bạch hầu. Có thể dùng một trong các loại kháng sinh sau khi bệnh tiến triển nặng, kèm theo triệu chứng toàn thân.
 - + Cephalosprin thế hệ 3: Người lớn:
 - ♣ Nếu giác mạc chưa loét: Liều duy nhất 1 gram tiêm bắp
 - ♣ Nếu giác mạc bị loét: 1 gram x 3 lần / ngày tiêm tĩnh mạch Trẻ em: Liều duy nhất 125mg tiêm bắp hoặc 25mg/kg cân nặng 2-3 lần/ngày x 7 ngày tiêm bắp.
 - + Fluoroquinolon: chống chỉ định dùng cho trẻ em dưới 16 tuổi.
 - + Thuốc nâng cao thể trạng.

5. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG

- Đối với hình thái viêm kết mạc do lậu cầu: Tốt nếu điều trị sớm và tích cực, có thể thủng hoại tử giác mạc nếu điều trị muộn và không tích cực.
- Đối với hình thái viêm kết mạc do bạch hầu thường không tốt nếu không điều trị toàn thân kịp thời và đúng.
- Đối với hình thái viêm kết mạc do vi rus: điều trị tích cực, đúng phác đồ bệnh sẽ khỏi sau 5-10 ngày, bệnh có thể kéo dài gây viêm giác mạc biểu mô.

6. PHÒNG BỆNH

- Điều trị bệnh lậu đường sinh dục (nếu có).
- Vệ sinh và tra thuốc sát khuẩn /kháng sinh cho trẻ sơ sinh ngay khi đẻ ra.

- Tiêm phòng đầy đủ các bệnh theo đúng qui định của trẻ.
- Luôn nâng cao thể trạng.
- Nếu bị bệnh cần điều trị tích cực tránh lây lan thành dịch.

VIÊM LOÉT GIÁC MẠC DO VI KHUẨN

1. ĐỊNH NGHĨA

Viêm loét giác mạc do vi khuẩn (bacterial keratitis) là hiện tượng mất tổ chức giác mạc do hoại tử gây ra bởi một quá trình viêm trên giác mạc do vi khuẩn, là một nguyên nhân thường gặp gây mù loà.

2. NGUYÊN NHÂN

Các loại vi khuẩn thường gặp gây viêm loét giác mạc:

- Vi khuẩn Gr(+): Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, Mycobacterium, Nocardia...

- Vi khuẩn Gr(-): Pseudomonas aeruginosa, Moraxella, Hemophilus influenza,...

3. CHẨN ĐOÁN

a. Lâm sàng

– Triệu chứng cơ năng

+ Đau nhức mắt, cộm chói, sợ ánh sáng, chảy nước mắt.

+ Nhìn mờ hơn, có thể chỉ cảm nhận được ánh sáng.

– Triệu chứng thực thể

+ Kết mạc cương tụ rìa.

+ Trên giác mạc có một ổ loét ranh giới không rõ, đáy ổ loét thường phủ một lớp hoại tử bầy. Khi nhuộm giác mạc bằng fluorescein 2% ổ loét sẽ bắt màu xanh, nếu ổ loét hoại tử nhiều sẽ có màu vàng xanh.

+ Giác mạc xung quanh ổ loét bị thâm lậu.

+ Mống mắt cũng có thể bị phù nề, mất sắc bóng. Đồng tử thường co nhỏ, có thể dính vào mặt trước thể thủy tinh, tuy nhiên khó quan sát.

b. Cận lâm sàng

– Bệnh phẩm: là chất nạo ổ loét.

– Soi tươi: thấy có vi khuẩn.

– Soi trực tiếp: xác định vi khuẩn gram (+) hay gram (-).

– Nuôi cấy vi khuẩn: xác định được các loại vi khuẩn gây bệnh: tụ cầu, liên cầu, trực khuẩn mủ xanh,...Nếu có điều kiện có thể kết hợp làm kháng sinh đồ để xác định kháng sinh điều trị phù hợp.

d. Chẩn đoán xác định

– Ổ loét giác mạc có đặc điểm: bờ nhám nhò, ranh giới không rõ, đáy thường phủ lớp hoại tử bầy, giác mạc xung quanh thâm lậu nhiều.

– Xét nghiệm vi sinh chất nạo ổ loét sẽ tìm thấy vi khuẩn.

e. Chẩn đoán phân biệt

– Loét giác mạc do nấm: một ổ loét ranh giới rõ, bờ gọn, đáy ổ loét thường phủ một lớp hoại tử dày, đóng thành vảy gồ cao, bề mặt vảy khô ráp và khó bóc.

Xét nghiệm vi sinh chất nạo ổ loét sẽ tìm thấy nấm.

– Loét giác mạc do virus herpes: ổ loét có hình cành cây hoặc địa đồ, nhu mô xung quanh thâm lậu ít.

Xét nghiệm tế bào học chất nạo bờ ổ loét sẽ thấy một trong các hình ảnh: tế bào nhiều nhân, hiện tượng đông đặc nhiễm sắc chất quanh rìa nhân, tế bào thoái hóa nhân trong hoặc tìm thấy tiêu thể Lipschutz.

Xét nghiệm PCR chất nạo bờ ổ loét hoặc thủy dịch sẽ tìm được gen của virus herpes.

– Loét giác mạc do amip (acanthamoeba): giác mạc có ổ loét tròn hoặc bầu dục, xung quanh có vòng thâm lậu đặc (áp xe vòng).

Xét nghiệm vi sinh chất nạo ổ loét sẽ tìm thấy acanthamoeba.

4. ĐIỀU TRỊ

a. Nguyên tắc điều trị

– Cần phải tìm được vi khuẩn gây bệnh và điều trị bằng kháng sinh nhạy cảm với loại vi khuẩn đó (dựa vào kháng sinh đồ), nếu không xác định được loại vi khuẩn gây bệnh cần phải dùng kháng sinh phổ rộng.

– Điều trị bằng thuốc tra mắt là chính, có thể kết hợp với dùng đường toàn thân.

– Phối hợp điều trị triệu chứng và biến chứng.

– Điều trị ngoại khoa khi cần thiết.

b. Điều trị cụ thể Kháng sinh chống vi khuẩn (theo kháng sinh đồ). Nếu không có kết quả kháng sinh đồ thì điều trị như sau:

– Thuốc tra mắt:

+ Nếu do vi khuẩn gram (-): tobramycin 0,3% hoặc levofloxacin 0,5%

+ Nếu do vi khuẩn gram (+): ofloxacin 0,3% hoặc moxifloxacin 0,5% hoặc gatifloxacin 0,5%.

Hai thuốc sau có phổ kháng khuẩn rộng nên có thể dùng điều trị cả vi khuẩn gram (-).

Cách dùng: Ngày đầu có thể tra mắt liên tục cách nhau 30 phút, những ngày sau tra mắt 10 lần/ ngày.

– Thuốc uống: có thể dùng một trong các loại kháng sinh sau

+ Cefuroxime axetil 250 mg ngày uống 2-3 viên chia 2 lần, trong 5-7 ngày. + Ofloxacin 0,2 g ngày uống 2 viên chia 2 lần, trong 5-7 ngày

+ Truyền rửa mắt liên tục trong những trường hợp nặng bằng kháng sinh (gentamycin 4mg x2 ống) và nước muối sinh lý (nacl 0,9%) x 200 ml.

– Điều trị phối hợp

+ Chống viêm non- steroid: Tra mắt: dung dịch indomethacine 0,1% tra mắt 4 lần/ngày.

+ Giãn đồng tử, liệt cơ mi: Dùng atropin 1- 4 % tra mắt 2 lần mỗi ngày. Nếu đồng tử không giãn phải tiêm tách dính màng mắt (tiêm dưới kết mạc bốn điểm cạnh rìa) hỗn hợp: atropin 1% và adrenalin 0,1%.

– Tăng cường dinh dưỡng tại chỗ và toàn thân.

– Hạ nhãn áp: khi loét giác mạc gây tăng nhãn áp, loét dọa thủng hoặc thủng. Uống acetazolamide 250 mg 2 viên mỗi ngày chia 2 lần. Cần phối hợp với uống kali chloride 0,6 g uống 2 viên mỗi ngày chia 2 lần tránh mất kali. – Tiêm huyết thanh tự thân dưới kết mạc: có tác dụng tăng cường dinh dưỡng cho giác mạc và hạn chế hoại tử giác mạc. Dùng trong những trường hợp loét hoại tử nhiều (đặc biệt do trực khuẩn mủ xanh).

– Chống chỉ định tuyệt đối dùng corticoid trong giai đoạn ổ loét đang tiến triển.

5. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG

a. Tiến triển Loét giác mạc do vi khuẩn là một bệnh nặng, nhất là những bệnh nhân được điều trị muộn và đã dùng corticoid trước đó. Khi bệnh khỏi sẽ để lại sẹo trên giác, ảnh hưởng đến thị lực của người bệnh.

b. Biến chứng

– Loét giác mạc dọa thủng (phồng màng Descemet).

– Tăng nhãn áp.

– Trường hợp nặng có thể gây loét thủng giác mạc, viêm mủ nội nhãn.

6. PHÒNG BỆNH

– Luôn giữ gìn mắt sạch sẽ, tránh những sang chấn vào mắt.

– Khi bị chấn thương trên giác mạc cần phải phát hiện và điều trị kịp thời bằng các kháng sinh tra mắt để phòng biến chứng viêm loét giác mạc do vi khuẩn.

– Cần phải điều trị các bệnh mắt là yếu tố thuận lợi gây viêm loét giác mạc: lông quặm, lông xiêu, hờ mi,...

VIÊM KẾT MẠC DỊ ỨNG CẤP

1. ĐẠI CƯƠNG

Viêm kết mạc dị ứng cấp tính là hình thái dị ứng nhanh của viêm kết mạc dị ứng khi bệnh nhân tiếp xúc với dị nguyên.

2. NGUYÊN NHÂN

Dị nguyên thường là các mỹ phẩm lạ, thuốc tra mắt, hóa chất, bụi, phấn hoa,....

3. CHẨN ĐOÁN

a. Lâm sàng

- Triệu chứng xảy ra rất cấp tính.
- Triệu chứng cơ năng: bệnh nhân có cảm giác bỏng rát trong mắt, ngứa mắt, đau, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, nhiều khi không mở được mắt.
- Dấu hiệu thực thể: mi sưng nề, mọng đỏ, kết mạc cương tụ, phù nề mọng nước, chảy nhiều dịch, tiết tố nhầy, phát triển nhú to trên kết mạc sụn mi, đôi khi xuất hiện viêm giác mạc chấm.

b. Cận lâm sàng

Xét nghiệm tìm dị nguyên khi có điều kiện.

c. Chẩn đoán xác định Lâm sàng:

- Ngứa mắt, đau, bỏng rát, sợ ánh sáng, chảy nước mắt
- Mi kết mạc phù nề, tiết tố nhầy, nhú viêm trên kết mạc sụn mi.

d. Chẩn đoán phân biệt

Viêm kết mạc cấp: không có tiền sử tiếp xúc dị nguyên, kết mạc cương tụ nhưng không phù nề nhiều như dị ứng, nhiều tiết tố nhầy...

4. ĐIỀU TRỊ

a. Nguyên tắc điều trị

- Ngừng tiếp xúc với dị nguyên gây dị ứng (nếu xác định được)
- Chống dị ứng tại chỗ và toàn thân.
- + Tra tại chỗ: chống viêm, chống dị ứng
- + Toàn thân: chống dị ứng chống phù (nếu cần)

b. Điều trị cụ thể

- Việc đầu tiên là phải loại trừ tác nhân gây dị ứng bằng rửa mắt bằng dung dịch như nước muối sinh lý.
- Dùng thuốc:
- * Thuốc tra:

+ Corticosteroid: prednisolon acetate 1%, fluorometholone 0,1% 6-8 lần/ngày, trong vài ngày đầu, sau đó bệnh giảm có thể tra rút xuống 3-4 lần/ngày và dừng khi các triệu chứng khỏi hẳn.

+ Nếu da mi phù, đỏ ngứa: bôi da mi mỡ có corticoid: mỡ hydrocortison 1%....bôi da mi 3 lần/ ngày

* Thuốc uống:

+ Thuốc kháng histamin: có thể dùng 1 trong các loại thuốc chống dị ứng như: loratadine, fexofenadine hydrochloride.

+ Loratadine 10mg:

Người lớn, trẻ em ≥ 12 tuổi: 1 viên/ngày

Trẻ em 6-12 tuổi ≥ 30 kg: 1 viên/ngày

Trẻ em 6-12 tuổi ≤ 30 kg: 1/2 viên/ngày

+ Fexofenadine hydrochloride: người lớn, trẻ em ≥ 12 tuổi: 60mg/viên x 2 lần/ngày hoặc 120mg-180mg/ 1 lần/ngày.

+ Trong những trường hợp có kèm theo triệu chứng toàn thân nặng cần phối hợp hoặc chuyển bệnh nhân đến chuyên khoa dị ứng.

5. TIẾN TRIỂN VÀ BIẾN CHỨNG

– Bệnh thường khỏi sau vài ngày.

– Bệnh có thể tái phát khi bệnh nhân lại tiếp xúc với dị nguyên gây dị ứng.

6. PHÒNG BỆNH

Tránh tiếp xúc với dị nguyên nếu xác định được tác nhân gây dị ứng.

NANG NHÁI SÀN MIỆNG

I. ĐẠI CƯƠNG:

Nang nhái sàn miệng là nang nhầy, khu trú ở sàn miệng. Lòng nang chứa dịch nhầy có nguồn gốc từ tuyến nước bọt dưới lưỡi, hoặc tuyến dưới hàm, hoặc tuyến nước bọt phụ ở sàn miệng.

II. NGUYÊN NHÂN:

Nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh đến nay vẫn chưa rõ ràng, một số tác giả cho rằng cơ chế gây nang là do ống một tuyến nước bọt bị tắc, giãn phình.

III. CHẨN ĐOÁN:

1. Chẩn đoán xác định:

1.1 Lâm sàng:

- Có khối phồng ở sàn miệng, kích thước thường khoảng 1-3cm hoặc lớn hơn.
- Bề mặt khối phồng có màu tím nhạt giống bụng nhái, ranh giới rõ.
- Niêm mạc mỏng căng, có thể tự vỡ ra dịch nhầy trong như lòng trắng trứng có albumin và mucin, dễ nhiễm khuẩn, hay tái phát.
- Nang phát triển từ từ, trường hợp to có thể lấn qua đường giữa, đẩy lệch lưỡi, ảnh hưởng chức năng.
- Thê lâm sàng hiếm gặp là nang nhái ở cổ, xảy ra khi nang xuyên qua cơ hàm móng và biểu hiện thành khối phồng ở vùng cổ.

1.2 Cận lâm sàng:

- X-Quang thường quy: không có dấu hiệu đặc trưng.
- Cộng hưởng từ (MRI): thấy khối giảm âm và giảm tỷ trọng ranh giới rõ.

2. Chẩn đoán phân biệt:

Nang nhái sàn miệng có các dấu hiệu lâm sàng khá điển hình và không cần chẩn đoán phân biệt.

IV. ĐIỀU TRỊ:

1. Nguyên tắc:

Phẫu thuật cắt bỏ nang.

2. Điều trị cụ thể:

Tùy từng trường hợp cụ thể mà có thể áp dụng một trong ba biện pháp điều trị dưới đây:

2.1 Phẫu thuật cắt bỏ nang:

- Chỉ định: nang có kích thước nhỏ, không liên quan tới tuyến nước bọt dưới lưỡi.
- Kỹ thuật:
 - + Gây tê tại chỗ.

- + Rạch niêm mạc bọc lộ nang.
- + Tách bóc vỏ nang ra khỏi mô xung quanh và lấy toàn bộ nang.
- + Khâu đóng niêm mạc.
- + Kháng sinh.

2.2 Phẫu thuật cắt bỏ nang và tuyến nước bọt dưới lưỡi:

- Chỉ định: nang có kích thước vừa phải và liên quan với tuyến nước bọt dưới lưỡi.
- Kỹ thuật:
 - + Phẫu thuật lấy bỏ nang
 - + Phẫu thuật lấy bỏ tuyến nước bọt dưới lưỡi.
 - + Kháng sinh.

2.3 Phẫu thuật mở thông nang:

- Chỉ định:
 - + Nang có kích thước lớn gây chèn ép và ảnh hưởng đến chức năng.
 - + Nang có kích thước lớn và tình trạng toàn thân của bệnh nhân không cho phép phẫu thuật kéo dài.
- Kỹ thuật:
 - + Gây tê tại chỗ.
 - + Rạch niêm mạc trên nang theo hình múi cam
 - + Tách bóc lấy bỏ phần niêm mạc miệng hình múi cam giữa hai đường rạch.
 - + Rạch vỏ nang.
 - + Khâu nối từng bên mép vỏ nang với mép niêm mạc sàn miệng, để thông lòng nang ra khoang miệng.
 - + Kháng sinh.

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG:

1. Tiên lượng:

Phẫu thuật cắt bỏ nang hoặc cắt bỏ nang và tuyến nước bọt dưới lưỡi, hoặc phẫu thuật mở thông nang, nếu thực hiện đúng kỹ thuật thì điều cho kết quả tốt, không tái phát.

2. Biến chứng:

Bội nhiễm: gây sưng tấy vùng sàn miệng và ảnh hưởng đến chức năng.

VI. PHÒNG BỆNH:

Khám sức khỏe răng miệng định kỳ để phát hiện nang sớm và điều trị kịp thời.

RĂNG KHÔN MỌC LỆCH

I. ĐẠI CƯƠNG:

Là tình trạng mọc bất thường về trục, hướng và vị trí của răng khôn làm cho răng không có chức năng ăn nhai và có thể gây biến chứng.

II. NGUYÊN NHÂN:

- Thiếu khoảng trên xương hàm do sự bất tương xứng về kích thước giữa răng và xương hàm.

- Có yếu tố cản trở răng mọc ở vị trí đúng: Lợi xơ, u xương hàm...

III. CHẨN ĐOÁN:

1. Lâm sàng: Có các biểu hiện răng mọc bất thường về trục, hướng, vị trí. Tùy trường hợp mà có thể có các biểu hiện dưới đây:

- Răng lệch trục:

+ Răng khôn hàm dưới thường có trục lệch gần hoặc lệch má ở các mức độ khác nhau.

+ Răng khôn hàm trên thường lệch phía ngoài.

- Răng có thể bị kẹt bởi cổ răng hàm lớn thứ hai, mặt nhai răng khôn có thể không chạm mặt phẳng cắn.

- Các dấu hiệu tổn thương răng kế cận: thường có tổn thương sâu cổ răng ở mặt xa răng hàm lớn thứ hai.

- Khi có biến chứng biến chứng viêm quanh thân răng hoặc các viêm nhiễm khác thì có các biểu hiện:

+ Đau tự nhiên, khá dữ dội vùng góc hàm.

+ Có thể có sốt.

+ Bệnh nhân khó há miệng nhẹ, ăn nhai đau...

+ Vùng sau răng 7 lợi nề đỏ có thể lan ra trụ trước Amidal và ngách tiền đình, có thể có viêm loét ở niêm mạc vùng lân cận.

+ Lợi ấn đau, chảy mủ.

+ Có thể thấy một hoặc hai núm răng lộ ra khỏi lợi, bờ lợi có thể loét nhẹ.

+ Có hạch dưới hàm.

2. Cận lâm sàng:

Phim X-Quang: phim sau huyết ổ răng, panoroma, hàm dưới chếch.

- Có hình ảnh răng mọc lệch trục, hướng và vị trí.

- Có thể có hình ảnh tổn thương mất mô cứng mặt xa răng hàm lớn thứ hai.

3. Chẩn đoán phân biệt:

Răng khôn mọc lệch luôn có các biểu hiện trên lâm sàng và X- Quang rõ rệt, vì vậy không cần chẩn đoán phân biệt.

IV. ĐIỀU TRỊ:

1. Nguyên tắc:

- Khi đã xác định được răng khôn hàm dưới mọc lệch thì nên nhổ bỏ càng sớm càng tốt để không làm mất xương phía xa răng hàm lớn thứ hai.
- Lấy được răng khôn ra khỏi huyết ổ răng mà không làm tổn thương răng kế cận. Trường hợp cần thiết, phải cắt thân răng hoặc phối hợp với chia tách chân răng.
- Trong một số trường hợp phải tạo vạt niêm mạc và mở xương để lấy răng.

2. Điều trị cụ thể:

2.1 Răng khôn lệch không có biến chứng:

- Vô cảm
- Tạo vạt nếu cần.
- Mở xương bộc lộ răng nếu có.
- Cắt thân răng, và chia cắt chân răng nếu cần.
- Lấy răng ra khỏi huyết ổ răng bằng dụng cụ thích hợp.
- Kiểm soát huyết ổ răng.
- Khâu phục hồi niêm mạc hoặc cắn gạc cầm máu.
- Hướng dẫn bệnh nhân dùng kháng sinh, chống viêm, giảm đau nếu cần.

2.2 Răng khôn lệch đã có biến chứng:

- Điều trị biến chứng viêm quanh thân răng cấp hoặc nhiễm trùng khác:
 - + Kháng sinh toàn thân.
 - + Bơm rửa túi quanh răng và chăm sóc tại chỗ khác...
- Sau khi hết giai đoạn nhiễm trùng cấp tính thì điều trị nhổ răng khôn lệch.

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG:

1. Tiên lượng:

- Trường hợp chưa có biến chứng: nếu nhổ sớm thì có thể bảo vệ tốt được răng hàm lớn thứ hai tránh khỏi mất xương ở phía xa chân răng, sâu cổ răng...
- Trường hợp đã có biến chứng: nếu điều trị đúng quy trình thì có thể tránh được các biến chứng.

2. Biến chứng:

- Viêm quanh thân răng cấp.
- Tổn thương răng hàm lớn thứ hai.
- Áp xe vùng má, áp xe vùng cơ cắn, áp xe vùng dưới hàm, áp xe quanh hàm ngoài...

- Viêm tấy lan tỏa vùng hàm mặt.
- Nhiễm trùng huyết.

VI. PHÒNG BỆNH:

Khám răng miệng định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

VIÊM TỦY RĂNG

I. ĐẠI CƯƠNG:

Viêm tủy là tình trạng tổn thương nhiễm trùng mô tủy răng, làm tăng áp lực nội tủy, chèn ép vào các tận cùng thần kinh gây ra triệu chứng đau và tổn thương mô tủy.

II. NGUYÊN NHÂN:

- Vi khuẩn: thường xâm nhập vào tủy qua lỗ sâu. Phản ứng viêm thường xuất hiện khi các vi khuẩn gây sâu răng xâm nhập vào tủy qua ống ngà. Vi khuẩn cũng có thể xâm nhập vào mô tủy qua ống ngà nếu có hiện tượng mòn răng - răng, nứt, rạn vỡ....

- Nhân tố hóa học: các chất hoá học có thể tác động trực tiếp tới vùng hõ tủy hoặc có thể khuếch tán qua ngà răng đã thay đổi tính thấm sau hàn.

- Kích thích vật lý: áp lực, tốc độ, kích thước mũi khoan cũng như nhiệt độ trong quá trình tạo lỗ hàn ảnh hưởng đến mô tủy.

- Chấn thương khí áp: là hiện tượng đau tủy có thể xảy ra khi tăng hoặc giảm áp lực đột ngột.

III. CHẨN ĐOÁN:

3.1 Viêm tủy có hồi phục:

3.1.1. Chẩn đoán xác định:

a. Lâm sàng:

* Triệu chứng cơ năng:

- Viêm tủy có hồi phục có thể không biểu hiện triệu chứng.
- Nếu có thường là các triệu chứng đặc thù: nhạy cảm với các kích thích nóng lạnh, không khí. Chỉ kéo dài vài giây hoặc vài chục giây sau khi loại bỏ kích thích.
- Kích thích nóng đáp ứng ban đầu có thể chậm nhưng cường độ nhạy cảm tăng lên khi nhiệt độ tăng. Đối với các kích thích lạnh thì thường ngược lại.

* Triệu chứng thực thể:

- Có lỗ sâu.
- + Có tổn thương tổ chức cứng lộ ngà.
- + Lỗ hõ tủy do tai nạn trong điều trị.
- + Răng không đổi màu.
- + Gõ không đau.
- +

b. Cận lâm sàng:

- X quang: có biểu hiện các tổn thương mô cứng, kháng dây chần quanh răng bình thường.
- Thử nghiệm tủy: bình thường hoặc có thể nhạy cảm mức độ nhẹ.

3.1.2. Chẩn đoán phân biệt:

Viêm tủy có hồi phục chẩn đoán phân biệt với sâu ngà sâu và viêm tủy không hồi phục: Dựa vào các dấu hiệu lâm sàng.

3.2 Viêm tủy không hồi phục:

3.2.1. Chẩn đoán xác định:

a. Lâm sàng:

- Triệu chứng cơ năng: Đau với các tính chất dưới đây:
 - + Đau tự nhiên, từng cơn.
 - + Thời gian cơn đau: có thể kéo dài hàng giờ hoặc đôi khi chỉ ngắn trong vòng vài phút, hoặc rất ngắn làm cho tính chất cơn đau gần như liên tục.
 - + Tính chất lan truyền: Cơn đau thường lan lên nửa đầu, nửa mặt cùng bên, bệnh nhân thường chỉ khu trú được vùng đau chứ không xác định được răng đau.
 - + Đau khi có tác nhân kích thích tác động và kéo dài sau khi đã hết tác nhân kích thích.
- Triệu chứng thực thể:
 - + Lỗ sâu trên mô cứng của răng: răng có thể có lỗ sâu giai đoạn tiến triển, đáy nhiều ngà mềm, ngà mủn, có thể có điểm hở tủy.
 - + Vết rạn nứt răng: có thể có sau sang chấn mạnh.
 - + Mòn mặt răng: cũng có thể có.
 - + Lỗ hình chêm ở cổ răng: có thể có.
 - + Hở tủy răng.
 - + Gõ ly tâm từng nướu răng hoặc thực hiện nghiệm pháp cắn bệnh nhân đau.
 - + Đường nứt ngầm màu bông xanh metylen.
 - + Răng có hiện tượng gián đoạn dẫn quang qua đường nứt khi chiếu đèn.
 - + Có thể không thấy lỗ sâu có biểu hiện viêm quanh răng toàn bộ, một răng hay một nhóm răng gây viêm tủy ngược dòng.
 - + Gõ răng chỉ nhạy cảm khi có viêm lan tỏa tới vùng cuống và dây chằng quanh răng.
 - + Thử nghiệm tủy: dương tính, ngưỡng thấp, kéo dài đáp ứng sau thử nghiệm.

b. Cận lâm sàng:

X- Quang: có thể có lỗ sâu mặt bên, mặt nhai, sâu tái phát dưới chất hàn sát hoặc thông với mô tủy, vùng cuốn có phản ứng nhẹ, dây chằng hơi giãn rộng. Cũng có thể nhìn thấy hình ảnh nứt vỡ răng liên quang với buồng tủy.

3.2.2. Chẩn đoán phân biệt:

- Viêm tủy có hồi phục.
- Viêm quanh cuốn răng cấp.

IV. ĐIỀU TRỊ:

4.1 Viêm tủy có hồi phục:

Chụp tủy bằng Hydroxit canxi hoặc MTA. Sau đó hàn kín phía trên bằng Eugenat cứng nhanh, GIC.

- Sửa soạn xoang hàn:

- + Dùng mũi khoan thích hợp mở rộng bờ men, bộc lộ rõ xoang sâu.
- + Dùng mũi khoan thích hợp lấy bỏ mô ngà hoại tử.
- + Làm sạch xoang hàn bằng nước muối sinh lý.
- + Làm khô xoang hàn.

- Đặt Hydroxit canxi:

+ Dùng que hàn lấy Hydroxit canxi hoặc MTA và đặt phủ kín đáy xoang hàn từng lớp từ 1-2mm.

- + Dùng gòn bông nhỏ lèn nhẹ và làm phẳng bề mặt Hydroxit canxi.

- Hàn phục hồi xoang hàn:

+ Dùng vật liệu thích hợp như composite, GIC, Amalgam... phục hồi phần còn lại của xoang hàn.

- + Kiểm tra khớp cắn.

- + Hoàn thiện phần phục hồi composite hoặc Amalgam.

4.2 Viêm tủy không hồi phục:

4.2.1 Điều trị tủy lấy tủy toàn bộ với nguyên tắc:

- Vô trùng.
- Làm sạch và tạo hình ống tủy.
- Hàn kín hệ thống ống tủy theo không gian ba chiều.

4.2.2 Các bước điều trị tủy:

- Bước 1: vô cảm khi tủy răng sống bằng gây vùng hoặc gây tê tại chỗ với Xylocain 2%.

- Bước 2: Mở tủy, lấy tủy buồng, tủy chân:

- + Dùng mũi khoan kim cương đầu tròn mở đường vào buồng tủy.
- + Dùng mũi khoan Endo Z để mở toàn bộ trần buồng tủy.
- + Lấy tủy buồng và tủy chân bằng châm gai.

- Bước 3: Thăm dò số lượng, kích thước ống tủy bằng các dụng cụ thích hợp.

- Bước 4: xác định chiều dài làm việc của ống tủy.

- Bước 5: Tạo hình và làm sạch hệ thống ống tủy:

+ Tạo hình bằng các phương pháp tạo hình như: Stepback, Stepdown và phương pháp lai. Sử dụng các trâm xoay máy và trâm xoay cầm tay để tạo hình làm rộng hệ thống ống tủy.

+ làm sạch hệ thống ống tủy bằng các dung dịch: nước muối sinh lý, Oxy già 3V, Natri hypoclorid 2,5-5%.

- Bước 6: Chọn, thử côn gutta-percha chính.
- Bước 7: Chụp X-Quang kiểm tra.
- Bước 8: Hàn kín hệ thống ống tủy bằng các kỹ thuật lèn dọc, lèn ngang với gutta-percha nóng, nguội.
- Bước 9: Hàn kín buồng tủy và phục hồi thân răng bằng vật liệu thích hợp.

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG:

- Biến chứng gần: viêm quanh cuống, u hạt, nang chân răng.
- Biến chứng xa: viêm xoang hàm, viêm nội tâm mạc.

VI. PHÒNG BỆNH:

- Chẩn đoán và điều trị bệnh lý tủy kịp thời.
- Khám răng định kỳ 6 tháng một lần.

VIÊM AMIDAN CẤP VÀ MẠN TÍNH

I. ĐẠI CƯƠNG:

- Viêm Amidan cấp tính là viêm sung huyết và xuất tiết của Amidan khẩu cái, thường gặp ở trẻ ở lứa tuổi học đường 5-15 tuổi, do vi khuẩn hoặc virus gây nên, thường thấy ở thời kỳ đầu của nhiều bệnh viêm nhiễm vì vậy có người coi Amidan là “cửa vào” của một số vi khuẩn hay virus như: viêm khớp cấp, bại liệt, dịch viêm não, viêm màng não.

- Viêm Amidan mạn tính là hiện tượng viêm thường xuyên, viêm đi viêm lại nhiều lần của Amidan khẩu cái. Tùy theo mức độ viêm nhiễm và phản ứng của cơ thể, Amidan viêm có thể phát triển to lên (viêm quá phát) thường gặp ở trẻ em hay người trẻ tuổi, hoặc Amidan có thể nhỏ lại (viêm xơ teo).

II. NGUYÊN NHÂN:

1. Các tác nhân gây viêm Amidan:

- Vi khuẩn: liên cầu β tan huyết nhóm A, S.pneu hemophilus, tụ cầu, liên cầu, xoắn khuẩn, các chủng ái khí và yếm khí.

- Virus: cúm, sởi, ho gà...

2. Có nhiều nguyên nhân thuận lợi gây viêm Amidan:

- Thời tiết thay đổi đột ngột (bị lạnh đột ngột khi mưa, độ ẩm cao...).

- Ô nhiễm môi trường do bụi, khí, điều kiện sinh hoạt thấp, vệ sinh kém.

- Sức đề kháng kém, cơ địa dị ứng.

- Có các ổ viêm nhiễm ở họng, miệng: như sâu răng, viêm lợi, viêm V.A, viêm xoang và do đặc điểm cấu trúc giải phẫu của Amidan có nhiều khe kẽ, hốc, ngách là nơi cư trú, ẩn náu và phát triển của vi khuẩn.

III. CHẨN ĐOÁN:

1. Chẩn đoán xác định:

1.1 Lâm sàng:

1.1.1 Viêm Amidan cấp tính:

- Toàn thân: bắt đầu đột ngột với cảm giác rét hoặc rét run rồi sốt 38°C - 39°C . Người mệt mỏi, đau đầu, chán ăn, nước tiểu ít và sẫm màu, đại tiện thường táo.

- Cơ năng:

+ Cảm giác khô, rát, nóng ở trong họng, nhất là thành bên họng vị trí Amidan, mấy giờ sau biến thành đau họng, đau nhói lên tai, đau tăng lên rõ rệt khi nuốt, khi ho.

+ Kèm theo viêm V.A, thường có viêm mũi hoặc ở trẻ em có Amidan to hay gặp thở khò khè, ngủ ngáy to, nói giọng mũi.

+ Viêm nhiễm có thể lan xuống thanh quản, khí quản gây nên ho từng cơn, đau và có đờm nhầy, giọng khan nhẹ.

- Thực thể:

+ Lưỡi trắng, miệng khô, niêm mạc họng đỏ.

+ Amidan sưng to và đỏ, có khi gần xác nhau ở đường giữa. Đôi khi thấy hai Amidan sưng đỏ và có những chấm mủ trắng ở miệng các hốc, dần biến thành một lớp mủ phủ trên bề mặt Amidan, không lan đến các trụ, không dính chắc vào Amidan, dễ chùi sạch, không chảy máu, để lộ niêm mạc Amidan đỏ và nguyên vẹn: đó thể viêm Amidan mủ do vi khuẩn gây nên (liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn).

+ Tổ chức lympho ở thành sau họng to và đỏ: đó là thể viêm Amidan ban đỏ thường do virus gây nên.

1.1.2 Viêm Amidan mạn tính:

- Toàn thân:

+ Triệu chứng nghèo nàn. Có khi không có triệu chứng gì ngoài những đợt tái phát hoặc hội viêm có triệu chứng giống như viêm Amidan cấp tính.

+ Đôi khi có tổng trạng gầy yếu, da xanh, sờ lạnh, ngầy ngáy sốt về chiều.

- Cơ năng:

+ Thường có cảm giác nuốt vướng ở họng đôi khi có cảm giác đau như có dị vật trong họng, đau lan lên tai.

+ Hơi thở thường xuyên hôi mặc dù vệ sinh răng miệng thường xuyên.

+ Thỉnh thoảng có ho và khàn tiếng, trẻ em có thở khò khè, ngủ ngáy to.

- Thực thể:

+ Trên bề mặt Amidan có nhiều khe và hốc. Các khe và hốc này chứa đầy chất bã đậu và thường có mủ màu trắng.

+ Thể quá phát: Amidan to như hai hạt hạnh nhân ở hai bên thành họng lún vào làm hẹp khoang họng, trụ trước đỏ, thường gặp ở trẻ em.

+ Thể xơ teo: thường gặp ở người lớn, Amidan nhỏ, mặt gồ ghề, lỗ chỗ hoặc chằng chịt xơ trắng biểu hiện bị viêm nhiễm nhiều lần. Màu đỏ sẫm, trụ trước đỏ, trụ sau dày. Amidan mất vẻ mềm mại bình thường, ấn vào Amidan có thể thấy phòi mủ hôi ở các hốc.

1.2 Cận lâm sàng:

1.2.1 Viêm Amidan cấp tính:

Thể viêm do vi khuẩn, xét nghiệm công thức máu có số lượng bạch cầu tăng cao, nhiều bạch cầu đa nhân trung tính.

1.2.2 Viêm Amidan mạn tính:

Viêm Amidan mạn tính có thể là một ổ viêm nhiễm gây nên những bệnh toàn thân khác, nhưng nhiều khi khẳng định điều đó trong những trường hợp cụ thể lại là vấn đề khó khăn và tế nhị. Người ta đã đề xuất khá nhiều test để chẩn đoán khẳng định:

- Test Viggo – Schmidt: thử công thức bạch cầu trước khi làm nghiệm pháp. Dùng ngón tay xoa trên bề mặt Amidan trong vòng 5 phút, thử lại công thức bạch cầu. Nếu Amidan viêm sẽ thấy số lượng bạch cầu tăng lên. Bạch cầu tăng dần trong vòng 30 phút, giảm dần trong vòng hai giờ, sau trở lại bình thường.

- Test Le Mese: Nếu Amidan viêm đã gây các biến chứng, sau khi xoa trên bề mặt Amidan có khi thấy khớp đau hơn, xuất hiện phù nhẹ hoặc trong nước tiểu có hồng cầu.

- Đo tỷ lệ ASLO trong máu: bình thường 200 đơn vị, khi viêm do liên cầu khuẩn sẽ tăng cao từ 500-1000 đơn vị.

2. Chẩn đoán phân biệt:

Viêm Amidan cấp tính	Bệnh bạch hầu
Sốt cao bắt đầu đột ngột Mạch nhanh, mạnh Mặt mũi vừa, mặt đỏ Chấm mủ ở bề mặt Amidan hoặc màng mủ, không vượt khỏi Amidan Màng mủ mềm dễ nát và không dính chắc vào tổ chức Amidan Hạch cổ thường không sưng to rõ rệt Nước tiểu rất ít khi có Albumin Không tìm thấy trực khuẩn Klebs-Loeffer	Sốt, bắt đầu từ từ Mạch chậm, yếu Mặt mũi rõ rệt, mặt xanh tái Giả mạc không giới hạn ở miệng hốc và có thể vượt ra ngoài Amidan Giả mạc chắc, dính, khó bóc, nếu bóc dễ chảy máu Hạch cổ sưng to, ngay cả trường hợp thông thường Nước tiểu thường có Albumin Có trực khuẩn Klebs-Loeffer khi soi giả mạc

* Viêm Amidan mạn tính cần phân biệt với:

- Lao Amidan: Có hội chứng nhiễm độc lao, xét nghiệm lao loại trừ.
- Giang mai thời kỳ hai: Niêm mạc họng đỏ với những vết trợt niêm mạc ở Amidan, màn hầu, xét nghiệm giang mai loại trừ.
- Ung thư Amidan: Thường một bên Amidan to, xù xì, có thể loét hoặc không, mật độ cứng chắc, hay có hạch cổ to cùng bên. Cần sinh thiết để loại trừ.

IV. ĐIỀU TRỊ:

1. Nguyên tắc điều trị:

- Đối với viêm Amidan cấp tính chủ yếu là điều trị triệu chứng, nâng cao thể trạng, chỉ dùng kháng sinh khi nghi ngờ nhiễm khuẩn hay đe dọa biến chứng.
- Viêm Amidan mạn tính: vấn đề điều trị chủ yếu là cân nhắc chỉ định phẫu thuật cắt Amidan.

2. Điều trị cụ thể:

2.1. Viêm Amidan cấp tính:

- Nghỉ ngơi, ăn nhẹ, uống nhiều nước.
- Giảm đau, hạ sốt: Paracetamol...
- Kháng sinh: trong trường hợp nhiễm khuẩn dùng nhóm β lactam (Cefotaxim, Cefuroxim, Ofmantin,...), nếu dị ứng thì dùng nhóm macrolid.
- Nhỏ mũi bằng thuốc sát trùng nhẹ.

- Súc miệng bằng các dung dịch kiềm ấm: bicarbonate natri, borat natri...(nữa thìa cà phê trong một cốc nước ấm).

- Nâng đỡ cơ thể: yếu tố vi lượng, sinh tố, calci...

2.2. Viêm Amidan mạn tính:

Phẫu thuật cắt Amidan hiện nay là rất phổ biến, tuy nhiên cần có chỉ định chặt chẽ. Chỉ cắt khi nào Amidan thực sự trở thành một ổ viêm (focal infection) gây hại cho cơ thể.

2.2.1. Chỉ định phẫu thuật:

- Amidan viêm mạn tính nhiều lần (thường là 5-6 lần trong một năm).

- Amidan viêm mạn tính gây biến chứng viêm mũi, viêm xoang, viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm phổi, viêm tấy hạch dưới hàm hoặc thành bên họng...

- Amidan viêm mạn tính gây biến chứng xa: viêm màng trong tim, viêm cầu thận, viêm khớp, rối loạn tiêu hóa kéo dài, nhiễm khuẩn huyết.

- Amidan viêm mạn tính quá phát gây khó thở (hội chứng ngạt thở khi ngủ-hội chứng Pickwick sleep), khó nuốt, giọng nói như miệng ngậm một vật gì (khó nói).

2.2.2. Chống chỉ định phẫu thuật:

*** Chống chỉ định tuyệt đối:**

- Các hội chứng chảy máu: bệnh ưa chảy máu, rối loạn đông máu.

- Các bệnh nội khoa như: cao huyết áp, suy tim, suy thận, suy gan giai đoạn mất bù...

*** Chống chỉ định tương đối:**

- Khi đang có viêm họng cấp tính hay đang có biến chứng áp xe Amidan.

- Khi đang có viêm, nhiễm khuẩn cấp tính như: viêm mũi, viêm xoang, mụn nhọt.

- Khi đang có viêm, nhiễm virus cấp tính như: cúm, sởi, ho gà, bại liệt, sốt xuất huyết...

- Khi đang có biến chứng do viêm Amidan như: viêm thận cấp, thấp khớp cấp... thì phải điều trị ổn định, hết đợt cấp mới được cắt.

- Khi đang có bệnh mạn tính chưa ổn định như: đái tháo đường, viêm gan, lao, bệnh giang mai, AIDS...

- Phụ nữ đang thời kỳ kinh nguyệt, thời kỳ mang thai hoặc đang nuôi con bú.

- Thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh.

- Người quá yếu, trẻ quá nhỏ, người trên 50 tuổi.

- Thận trọng: trong các trường hợp dùng các thuốc nội tiết tố, hoặc thuốc giảm đau trước đó, các bệnh nhân đang đợt tiêm chủng, địa phương đang có dịch truyền nhiễm...

VIÊM HỌNG CẤP TÍNH

I. ĐẠI CƯƠNG:

- Viêm họng cấp tính là viêm cấp tính của niêm mạc họng miệng kết hợp chủ yếu với viêm Amidan (A) khẩu cái, một số ít trường hợp kết hợp với viêm Amidan đáy lưỡi.

- Là bệnh rất thường gặp ở cả người lớn lẫn trẻ em, nhất là vào mùa đông khi thời tiết thay đổi. Bệnh có thể xuất hiện riêng biệt hoặc đồng thời với viêm VA, viêm Amidan, viêm mũi, viêm xoang v.v... hoặc trong các bệnh nhiễm khuẩn lây của đường hô hấp trên như cúm, sởi...

II. NGUYÊN NHÂN:

1. Tác nhân:

- Do virus là chủ yếu, chiếm 60-80%, gồm Adenovirus, virus para-influenzae, virus Coxsackie, virus Herpes, virus Zona, EBV...

- Do vi khuẩn chiếm 20-40% gồm liên cầu (tan huyết nhóm A, các nhóm B, C, G ít gặp), Haemophilus influenza, tụ cầu vàng, Moraxella catarrhalis, vi khuẩn kỵ khí. Các vi khuẩn Neisseria, phế cầu, Mycoplasma rất hiếm gặp.

2. Nguyên nhân bệnh sinh của viêm họng:

Do thời tiết thay đổi, nhất là về mùa lạnh. Viêm họng đỏ cấp thường bắt đầu bằng sự nhiễm virus. Sau đó do độc tố của virus, cấu trúc giải phẫu của Amidan và sức đề kháng của cơ thể đã gây nên sự bội nhiễm các tạp khuẩn khác, thường là các vi khuẩn hội sinh có sẵn trong họng như liên cầu, phế cầu và đặc biệt nguy hiểm là loại liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A.

Bệnh lây lan bằng nước bọt, nước mũi.

III. CHẨN ĐOÁN:

1. Chẩn đoán xác định:

1.1. Lâm sàng: viêm họng cấp thường xảy ra đột ngột

1.1.1. Triệu chứng toàn thân:

Sốt vừa 38-39⁰C hoặc sốt cao, ớn lạnh, nhức đầu, đau mình mẩy, mệt mỏi, kém ăn. Phản ứng hạch góc hàm di động, ấn đau.

1.1.2. Triệu chứng cơ năng:

- Đau họng nhất là khi nuốt, ho, nói thì đau nhói lên tai.
- Có thể ho từng cơn, ho khan hoặc ho có đờm nhầy.

1.1.3. Triệu chứng thực thể:

- Toàn bộ niêm mạc họng đỏ, xuất tiết. Tổ chức bạch huyết ở thành sau họng đỏ mọng và có những mao mạch nổi rõ.

- Hai Amidan khẩu cái cũng sưng to đỏ, có khi có những chấm mủ trắng hoặc lớp bọt trắng (như bọt cháo trắng) phủ trên bề mặt Amidan.

- Trụ trước và trụ sau đỏ.

- Có hạch góc hàm sưng nhẹ và hơi đau.

1.2. Cận lâm sàng:

- Xét nghiệm công thức máu: Giai đoạn đầu bạch cầu trong máu không tăng, nhưng nếu có bội nhiễm thì bạch cầu đa nhân trung tính tăng cao.
- Phết dịch họng nuôi cấy vi khuẩn: để định loại được nguyên nhân gây bệnh.

2. Chẩn đoán phân biệt:

- Dị vật đường ăn: đau nhói họng đột ngột khi ăn, soi họng thấy dị vật.
- Viêm niêm mạc miệng: niêm mạc miệng đỏ, có thể thấy vết trợt, loét ở bên má, lưỡi.

IV. ĐIỀU TRỊ:

1. Điều trị toàn thân:

- Hạ sốt, giảm đau: Paracetamol, aspirin...
- Kháng sinh: Amoxicilin, cephalixin, cefuroxim, spiramycin, cefotaxim,..
- Kháng viêm: Alphachymotrypsin, prednisolone 5mg.

2. Điều trị tại chỗ:

Xông họng: kháng sinh + giảm viêm.

3. Nâng đỡ cơ thể:

Bổ sung các yếu tố vi lượng, sinh tố, vitamin...

VIÊM MŨI HỌNG CẤP

I. ĐẠI CƯƠNG:

Viêm mũi họng cấp tính là viêm cấp tính niêm mạc mũi và họng, thường kết hợp với viêm Amydan, VA,... thuộc vòng bạch huyết Waldeyer khi bệnh nhân còn các tổ chức lympho này.

II. NGUYÊN NHÂN:

viêm mũi họng cấp tính thường gặp vào mùa lạnh, khi thời tiết thay đổi, khởi đầu là một viêm nhiễm virus, dưới tác dụng của độc tố sức đề kháng giảm sút, là điều kiện cho bội nhiễm vi trùng, thường là vi trùng nằm vùng có sẵn trong mũi họng như liên cầu, phế cầu đặc biệt là liên cầu beta tan huyết nhóm A, có thể lây lan trong cộng đồng từ nước bọt, nước mũi do khi nói, khi ho hay hắt hơi...

1. Viêm mũi họng đồ cấp đơn thuần hay kết hợp có bọt trắng: có thể do vi khuẩn hoặc virus.

1.1 Do vi khuẩn: chiếm 20-40% tổng số viêm mũi họng gồm:

- Liên cầu beta tan huyết nhóm A, B, C, G
- Haemophilus influenza
- Tụ cầu vàng
- Moraxella catarrhalis
- Các vi khuẩn kỵ khí

1.2 Do virus: chiếm 60-80% gồm:

- Adenovirus
- Vú cúm
- Virus para – influenza
- Virus Coxsackie nhóm A hoặc B trong đó nhóm A gây viêm họng có bóng nước Herpangine.
- Virus Herpes gây viêm họng có bóng nước nhưng gây viêm miệng nhiều hơn ở họng.
- Virus Zona gây viêm họng có bóng nước Zona.
- Epstein Barr Virus (E.B.V) gây bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn và gây viêm mũi họng cấp tính.

2. Viêm mũi họng loét:

- chỉ xảy ra ở khoảng 5%
- Thường bị một bên như viêm họng cấp Vincent, sảng giang mai, bị cả hai bên như viêm họng do các bệnh về máu như bạch cầu cấp, bệnh mất bạch cầu hạt, viêm họng có giả mạc như viêm họng bạch hầu...

III. CHẨN ĐOÁN:

1. Chẩn đoán xác định:

1.1 Lâm sàng:

Bệnh thường xảy ra đột ngột với các triệu chứng toàn thân, cơ năng và thực thể như sau:

- Triệu chứng toàn thân: có thể chỉ sốt vừa 38°C – 39°C nhưng cũng có khi sốt cao 40°C ở trẻ em, ớn lạnh, nhức đầu, đau mình mẩy, mệt mỏi, chán ăn, không làm việc được...

- Triệu chứng cơ năng: nuốt đau, đau nhói lan lên tai, ho kích thích, lúc đầu ho khan, sau ho có đờm, thường có ngạt mũi, chảy mũi nước, lúc đầu trong nhầy, sau đục. Tiếng nói mất trong hay khàn nhẹ....

- Triệu chứng thực thể: niêm mạc họng đỏ rực, xuất tiết, trẻ em, hay bệnh nhân trẻ tuổi hai Amydal sưng to, sung huyết, hay có những chấm mủ trắng, bựa trắng phủ trên bề mặt Amydal. Niêm mạc mũi sung huyết, xuất tiết nhầy, có thể có sung hạch góc hàm, ấn đau nhẹ...

1.2 Cận lâm sàng:

Thông thường viêm mũi họng cấp không cần xét nghiệm cận lâm sàng vì chỉ cần dựa vào triệu chứng toàn thân, cơ năng và đặc biệt khám thực thể vùng mũi họng là đủ, nhưng nếu viêm mũi họng có xu hướng nặng kéo dài dễ gây biến chứng thì phải xét nghiệm vi trùng làm kháng sinh đồ thì điều trị có hiệu quả hơn. Đặc biệt nếu nghi các bệnh lây nhiễm nguy hiểm thì bắt buộc phải xét nghiệm để phòng dịch như bạch hầu, lao, giang mai,...các xét nghiệm cơ bản khác cũng có thể làm để tham khảo như công thức bạch cầu, nếu số lượng giảm và nhiều lympho thì có thể nhiễm virus. Làm phản ứng ASLO tìm kháng thể trong nhiễm liên cầu bê-ta.

2. Chẩn đoán phân biệt:

- Dị vật mũi: gây viêm mũi cấp thường chỉ điều trị một bên.

- Viêm mũi họng trong giai đoạn đầu một số bệnh nhiễm trùng lây như sởi, thủy đậu, cảm cúm.... Lúc này điều trị bệnh chính gây ra là quan trọng chứ không chỉ triệu chứng về mũi họng...

IV. ĐIỀU TRỊ:

1. Nguyên tắc điều trị:

Nhiều tác giả trong và ngoài nước đều thống nhất rằng tất cả mọi viêm mũi họng đỏ cấp, có chấm mủ trắng hay bựa trắng trên bề mặt Amydal đều phải điều trị như viêm mũi họng đỏ cấp do liên cầu khi chưa có xét nghiệm phân loại vi khuẩn hay virus. Đó là điều trị kháng sinh, hạ sốt, kháng viêm, giảm đau, sát trùng họng và nhỏ mũi sát khuẩn, co mạch, chống dị ứng....

2. Phác đồ điều trị:

Dù chưa có xét nghiệm vi trùng, virus, kháng sinh đồ, kháng virus đồ thì chúng ta cũng phải điều trị kháng sinh ngay cho kịp thời, khi có kết quả xét nghiệm (thường sau 3,4 ngày) ta lại điều chỉnh phù hợp kháng sinh đồ.

- Kháng sinh (Cefuroxim, Spiramycin, Cefixim,...)

- Hạ sốt giảm đau.
- Giảm viêm.
- Điều trị kháng sinh theo đúng kháng sinh đồ.
- Chế độ ăn uống và sinh tố nâng cao thể trạng.

3. Điều trị cụ thể:

3.1 Kháng sinh:

- Cephalosporine thế hệ 1, hoặc Peniciline A (Amoxciline) trong 10 ngày.
- Trường hợp bệnh nhân dị ứng với Peniciline thì có thể thay thế nhóm Macrolide như Rulide, Zithromax, Dynabac, hay Josacine trong 5-7 ngày.
- Tốt nhất là điều trị theo kháng sinh đồ nếu có kết quả xét nghiệm sớm, phải thay đổi thuốc kịp thời.

3.2 Hạ sốt, giảm đau, kháng viêm.

Paracetamol, Alphachymotrypsine, Aspirine... cho liều phù hợp với trẻ em và người lớn, uống sau ăn, lưu ý hỏi tiền sử viêm dạ dày tá tràng để chống chỉ định vì hầu như tất cả tá tràng để chống chỉ định vì hầu như tất cả tá tràng để chống chỉ định vì hầu như tất cả các thuốc giảm đau hạ sốt đều có nguy cơ chảy máu dạ các thuốc giảm đau hạ sốt đều có nguy cơ chảy máu dạ dày và hệ thống đường tiêu hóa.

3.3 Chế độ dinh dưỡng, sinh tố:

Chế độ dinh dưỡng tốt, nhiều chất, dễ tiêu hóa, giàu năng lượng, đặc biệt cung cấp các loại trái cây, nhiều vitamine C, B1.

VIÊM ỚNG TAI NGOÀI

I. ĐẠI CƯƠNG:

- Viêm ớng tai ngoài là tình trạng nhiễm trùng của ớng tai ngoài do tổn thương da ớng tai khi nhiệt độ và độ ẩm trong ớng tai thay đổi.

- Viêm ớng tai ngoài cấp: khi nhiệt độ và độ ẩm trong ớng tai tăng lên làm tổn thương hàng rào bảo vệ là da ớng tai nên vi khuẩn xâm nhập gây bệnh.

- Viêm ớng tai ngoài bán cấp và viêm ớng tai ngoài mạn: Khi điều trị không đầy đủ, da ớng tai trở nên khô, tróc vảy giống trong bệnh eczema, có khi tăng sản da trong ớng tai đẩy lên làm bít ớng tai.

II. NGUYÊN NHÂN:

- Dùng móc tai, bông ngoáy tai.
- Tiêu đường - Xạ trị - Suy giảm miễn dịch.

III. CHẨN ĐOÁN:

Chia làm ba giai đoạn:

3.1 Giai đoạn 1: ngứa tai, thường xuất hiện sau khi bệnh nhân dùng tăm bông ngoáy tai hoặc dùng đồ móc tai.

3.2 Giai đoạn 2: Viêm cấp

- Nhẹ: ngứa tai, đau tai nhẹ, da ớng tai đỏ, phù nề nhẹ.
- Vừa: ngứa tai, đau tai nhiều hơn, da ớng tai đỏ, phù nề nhiều, tiết dịch trong.
- Nặng: tai rất đau, đôi khi đau lan ra vùng quanh tai, lòng ớng tai hẹp, chảy mủ tai, xuất hiện hạch cổ.

3.3 Giai đoạn 3: Viêm mạn: Đau tai ít, ngứa tai nhiều và kéo dài, da ớng tai bắt đầu dày lên, tróc vảy.

IV. ĐIỀU TRỊ:

4.1 Nguyên tắc điều trị:

- Làm sạch ớng tai thường xuyên.
- Sử dụng kháng sinh phù hợp.
- Điều trị kháng viêm, giảm đau.
- Phòng ngừa tái phát.

4.2 Điều trị cụ thể:

4.2.1 Giai đoạn 1:

- Làm sạch ớng tai.
- Thuốc: thuốc lau, nhỏ tai (cồn Boric, Betadin (Povidin) 5-10% lau tai ngày 2 lần).

4.2.2 Giai đoạn 2:

a. *Nhẹ*: Lau sạch ống tai. Thuốc: thuốc nhỏ tai (Neomycin + Hydrocortisone hoặc Ciprofloxacin nhỏ 2-3 lần/ngày).

b. *Vừa*: Đặt miếng meche nhỏ vào ống tai, nhỏ thuốc kháng sinh Polydexa hoặc Ciprofloxacin lên miếng meche, rút sau một ngày nếu tình trạng phù nề không giảm có thể đặt lại miếng khác. Thuốc: thuốc giảm đau (Acetaminophen liều lượng 500mg x 3-4 lần/ngày).

c. *Nặng*: Đặt meche và nhỏ kháng sinh như trên. Thuốc:

* *Kháng sinh*:

- Có thể sử dụng 1 trong các loại sau: Cephalosporin thế hệ 1 (Cefadroxil, Cefalexin, ...) liều lượng 500mg x 3-4 lần/ngày. Nếu đánh giá bệnh nặng có thể dùng kháng sinh chích (Cefotaxim,...)

- Hoặc Quinolone (Ciprobay, Tavanic...) liều lượng 500mg x 2 lần/ngày (nhóm Ciprofloxacin), 500mg x 1 lần/ngày (nhóm Levofloxacin), thời gian điều trị liên tục 2 tuần.

* *Chống viêm, chống phù nề*:

- Prednisolon 5mg, Methylprednisolon (Medrol 4-16mg)

- Diclophenac (Neo – pyrazone 50mg)

- Alphachymotrypsin 1-2 viên x 2-3 lần/ngày.

* *Giảm đau*: Acetaminophene (Eferangal 500mg, Hapacol 500mg, Panadol 500mg ...) liều lượng 500mg x 3-4 lần/ngày.

4.2.3 Giai đoạn 3:

- Thuốc nhỏ tai: Neomycin, Hydrocortisone (Polydexa), Ciprofloxacin (Ciprofloxacin 0.3%), Dexamethasone 0.1% (Dexacol) nhỏ 2-3 lần/ngày.

- Thuốc bôi tai: Triamcinolone 0.25% dạng pomate thoa ống tai ngày 2 lần.

CHƯƠNG 9: SẢN – PHỤ KHOA**ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE THAI TRƯỚC CHUYỂN DẠ**

Đánh giá sức khỏe thai trước chuyển dạ dựa vào:

- -Đếm cử động thai
- NST
- Stresstest
- Trắc đồ sinh vật lý
- Chỉ số ối AFI
- Đo vận tốc máu chảy bằng siêu âm doppler

I. Đếm cử động thai:

- Cử động thai: tăng dần theo thời gian, ổn định từ 32 tuần trở đi.
- Cơ sở: Khi tình trạng tưới máu bánh nhau bị giảm sút và thai nhi bị toan hóa thì cử động thai cũng giảm.
- Ưu điểm: thực hiện ở mọi thai phụ và không tốn kém
- Khuyết điểm:
 - Làm tăng sự sử dụng các biện pháp khác
 - Tăng nhu cầu nhập viện
- Các yếu tố ảnh hưởng:
 - Con so/ con rạ
 - Tư thế mẹ: nằm > ngồi > đứng
 - C
 - Nhau mặt trước
 - Chu kỳ ngủ của thai: cử động giảm hay mất khi thai ngủ, thường chu kỳ ngủ của thai 20 – 40 phút, hiếm khi quá 90 phút
 - Thuốc hướng thần kinh: trị trầm cảm, thuốc mê
 - Hút thuốc lá: giảm cử động thai thoáng qua
 - Hỗ trợ phổi: giảm cử động thai thoáng qua trong 2 ngày
 - Thai dị tật
- Cách đếm:
 - Sau bữa ăn
 - Thời điểm nhất định trong ngày
 - Làm trống bàng quang, nằm thư giãn

- Thời gian theo dõi tối đa: 2 giờ
- Đếm cho tới 6 cử động thai riêng biệt

- Diễn giải:

- Thai kỳ không có yếu tố nguy cơ:

6 CĐT/2 giờ = thai nhi có sức khỏe ổn định

• Thai bệnh lý: đếm cử động thai đơn thuần không đủ an toàn mà phải cần thêm các phương pháp khác

- RCOG 2011:

- Đối với thai > 28 tuần, nếu < 10 lần/ 2 giờ → nằm nghiêng trái và theo dõi thêm 2 giờ nữa, nếu vẫn < 10 lần → báo NVYT

- Sản phụ lo lắng vì giảm CĐT không nên đợi đến ngày hôm sau để đánh giá tình trạng thai.

*Xử trí trường hợp cử động thai bất thường:

- Khai thác bệnh sử: nguy cơ thai lưu
- Khai thác yếu tố nguy cơ
- Nghe Doppler tim thai
- Siêu âm: tim thai, thể tích ối, kích thước thai
- NST

II. NST:

1. Nguyên lý

Hành não là cơ quan điều phối nhịp tim thai thông qua các đáp ứng giao cảm và phó giao cảm.

• Dao động nội tại bình thường và đáp ứng tăng nhịp tim thai khi có cử động thai = Thai nhi không bị nhiễm toan hoặc tổn thương hành não

• NST cho phép lượng giá tính toàn vẹn của hành não thai nhi, không cho phép kết luận về tình trạng nhiễm toan hay có tổn thương trung ương

• Độ nhạy: 97%, Giá trị tiên đoán (+): 15% (tỷ lệ có bệnh khi test (+)).

Cách thực hiện:

- Ngoài chuyển dạ, không có cơn co tử cung
- Thai phụ khuyến đi tiểu trước
- Tư thế nằm thoải mái nghiêng trái hoặc Fowler
- Đặt monitor ghi tim thai, cơn gò và cử động thai
- Hướng dẫn sản phụ ấn nút khi thấy thai máy

Thời gian đo: ít nhất 20 phút, có thể kéo dài đến 90 phút

2. Đọc biểu đồ ghi EFM

Trước khi đọc cần kiểm tra thông tin: thời gian có cập nhật không, luôn bắt đầu và kết thúc bằng 1 đoạn trắng nhằm đảm bảo giá trị pháp lý, phần đầu ghi ngày giờ, tên tuổi của sản phụ. Tốc độ ghi của máy (1cm/ph).

❖ Diễn giải kết quả:

Cách đánh giá NST (SOGC 2008)

Thông số		NST bình thường (Đáp ứng)	NST không điển hình (Không đáp ứng)	NST bất thường
Trị số tim thai căn bản (nhịp/phút)		• 110-160	• 100-110 • > 160 kéo dài < 30 phút • Tăng baseline	• < 100 • > 160 kéo dài > 30 phút • Tim thai căn bản thất thường
Dao động nội tại (nhịp/phút)		• 6-25 • ≤ 5, kéo dài < 40 phút	• ≤ 5, kéo dài 40-80 phút	• ≤ 5, kéo dài > 80 phút • ≥ 25, kéo dài > 10 phút • Nhịp hình sin
Nhịp giảm		• Không có • Hoặc nhịp giảm bất định < 30 giây	• Nhịp giảm bất định 30-60 giây	• Nhịp giảm bất định > 60 giây • Nhịp giảm muộn
Nhịp tăng	Thai đủ tháng	• ≥ 2 nhịp tăng, tăng ≥ 15 nhịp, kéo dài ít nhất 15 giây, trong 40 phút làm NST	• ≤ 2 nhịp tăng trong 40-80 phút	• ≤ 2 nhịp tăng trong > 80 phút
	Thai < 32 tuần	• ≥ 2 nhịp tăng, tăng ≥ 10 nhịp, kéo dài ít nhất 10 giây, trong 40 phút làm NST	• ≤ 2 nhịp tăng trong 40-80 phút	• ≤ 2 nhịp tăng trong > 80 phút
Hành động		• Việc đánh giá tiếp theo cần dựa vào bối cảnh lâm sàng	• Việc đánh giá tiếp theo là cần thiết	• Cần hành động khẩn cấp • Đánh giá tổng thể tình trạng hiện tại, thực hiện ngay siêu âm hay thực hiện BBP là cần thiết • Một số trường hợp cần lấy thai ra

❖ Hướng xử trí

- NST bình thường (có đáp ứng): có giá trị đảm bảo trong 1 tuần → đo lại 1 tuần sau.
- Cas Thai quá ngày, IUGR, ĐTĐ TK, TSG: 2 lần/tuần. TSG nặng: mỗi ngày
- NST bất thường--> đánh giá ngay lập tức và có thể xem xét chấm dứt thai kỳ.
- NST không điển hình (không đáp ứng): đánh giá toàn bộ bối cảnh lâm sàng cũng như tình trạng thai nhi, cần thêm các test hỗ trợ khác: AFI, ST.

III. Siêu âm Doppler động mạch thai nhi:

- Đánh giá vòng tuần hoàn nhau thai

Tuần hoàn tử cung – nhau: ĐMTC

Tuần hoàn nhau – thai: ĐMR

- Thai thiếu oxy ⇒ dẫn mm não ⇒ tái phân phối máu đến các cơ quan ⇒ Tăng trở kháng ĐMR, Giảm trở kháng mm não

- Các chỉ số cần khảo sát: tỷ số tâm thu/ tâm trương (S/D) và chỉ số kháng lực RI = (S-D)/S

- Bình thường: S/D giảm dần về cuối thai kỳ

Thai 26 – 30 tuần : S/D ratio ≤ 4

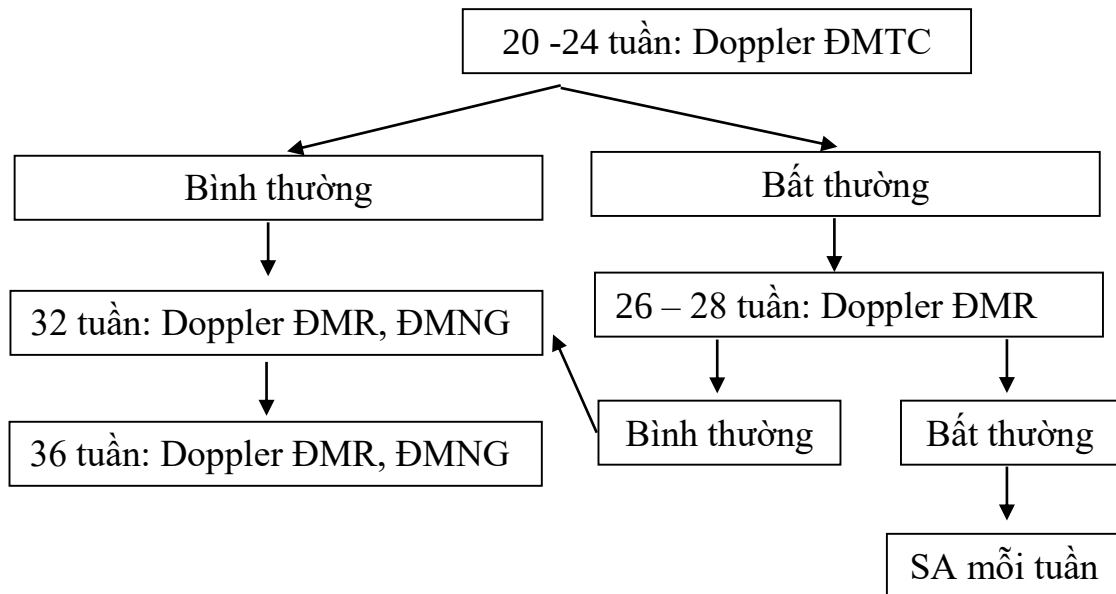
Thai 30 – 34 tuần : S/D ratio $\leq 3,5$

Thai > 34 tuần : S/D ratio ≤ 3

- Dấu hiệu bất thường:

- Doppler ĐMR: mất hoặc đảo ngược sóng tâm trương của ĐMR,
- RI ĐMNG < 0.7 sau 30 tuần

SÀNG LỌC CHO THAI KỲ NGUY CƠ CAO



ĐÁNH GIÁ SỨC KHỎE THAI TRONG CHUYỂN DẠ

CTG: (Cardiotocography) hay Electronic Fetal heart rate monitoring

I. Chỉ định :

- Bệnh lý của mẹ trước sanh :
 - CHA, TSG, ĐTĐ
 - Thiếu máu nặng
 - Bệnh tim, thận, cường giáp
 - Nhiễm trùng...
- Tình trạng thai trước sanh :
 - Non tháng, Già tháng, IUGR
 - Thiếu ối, Doppler bất thường, Đa thai
- Tình trạng trong chuyển dạ:
 - Chuyển dạ kéo dài
 - Mất máu
 - Ới xấu
 - Khởi phát CD hoặc tăng co, tim thai bất thường...

- **Tư thế** : Fowler đầu cao 45 độ, nghiêng 15 độ sang trái

II. Phân loại

- Định nghĩa: ACOG 2009

Tim thai căn bản	Giá trị trung bình của tim thai quanh sự biến đổi 5-25 nhịp trong 10 phút, ngoại trừ: - Những thay đổi mang tính chu kỳ hay bất chợt - Đoạn dao động tim thai mạnh > 25 nhịp - Tim thai căn bản phải kéo dài ít nhất 2 phút trong 10 phút băng ghi
Dao động nội tại	Những dao động quanh tim thai căn bản của ≥ 2 chu kỳ/phút Trị số dao động được đo lường bằng cách lấy biên độ từ đỉnh đến đáy - Vắng mặt: biên độ không xác định được - Tối thiểu: biên độ ≤ 5 nhịp - Trung bình: biên độ 6-25 nhịp - Tăng: > 25 nhịp
Tim thai chậm	Tim thai <110 nhịp/ph
Tim thai nhanh	Tim thai >160 nhịp/ph

Nhịp tăng	Sự tăng đột ngột (từ lúc bắt đầu tới đỉnh < 30 giây) trên tim thai căn bản Thời gian của nhịp tăng được xác định từ lúc bắt đầu thay đổi đến lúc tim thai trở về tim thai căn bản Từ tuần 32 trở đi, nhịp tăng tăng ≥ 15 nhịp, thời gian ≥ 15 giây nhưng dưới 2ph Trước tuần 32, nhịp tăng tăng ≥ 10 nhịp, thời gian ≥ 10 giây nhưng dưới 2ph Nhịp tăng kéo dài: tồn tại ≥ 2ph nhưng < 10ph Nếu nhịp tăng ≥ 10ph, đó là thay đổi tim thai căn bản
Nhịp giảm sớm	Có liên quan đến cơn co tử cung, (từ lúc bắt đầu tới đáy ≥ 30 giây) Đáy nhịp giảm cùng lúc với đỉnh cơn gò
Nhịp giảm muộn	Có liên quan đến cơn co tử cung, (từ lúc bắt đầu tới đáy ≥ 30 giây) Bắt đầu, đáy, và hồi phục sau bắt đầu, đỉnh và kết thúc của cơn gò (>15giây)
Nhịp giảm bất định	Đột ngột (bắt đầu tới đáy < 30 giây) Giảm ≥ 15 nhịp, kéo dài ≥ 15 giây nhưng < 2ph
Nhịp giảm kéo dài	Giảm ≥ 15 nhịp, kéo dài ≥ 2 ph nhưng < 10ph

Các đặc trưng của hoạt động co tử cung:

- Tần số cơn co: số cơn co trong 10 phút
- Trương lực cơ bản lúc nghỉ: áp lực tử cung giữa hai cơn co, bình thường < 20mmHg
- Cường độ: áp lực tối đa của tử cung
- Biên độ: cường độ trừ đi TLCB lúc nghỉ
- Cơn co TC yếu: áp lực cơn co yếu không tương xứng với giai đoạn chuyển dạ, áp lực < 30 mmHg
- Cơn co TC thừa: < 3 cơn/10ph và thời gian co ngắn < 20 giây trong pha tiềm thời và < 40s trong pha hoạt động
- Cơn co nhanh: > 5- 6 cơn/10ph, không thấy TLCB giữa các cơn co

Kết quả CTG theo ACOG 2009

	Bao gồm tất cả các tiêu chuẩn sau	
Loại 1	• Trị số TTCB: 110 – 160 • ĐĐNT trung bình • Không có nhịp giảm bất định (đột ngột bắt đầu tới đáy < 30 giây, giảm ≥ 15 nhịp, kéo dài ≥ 15 giây nhưng < 2ph) • Không có nhịp giảm muộn (có liên quan đến cgtc, từ lúc bắt đầu tới đáy ≥ 30 giây, bắt đầu, đáy và hồi phục sau bắt đầu, đỉnh và kết thúc của cơn gò (>15giây) • Không có nhịp giảm kéo dài (giảm ≥ 15 nhịp, kéo dài ≥ 2ph nhưng < 10ph)	- Tình trạng cân bằng kiểm toan bình thường - Không cần can thiệp gì ở thời điểm khảo sát
Loại 3	Vắng mặt ĐĐNT và bất kỳ 1 trong 3 yếu tố sau: - Nhịp giảm muộn lặp lại (số nhịp giảm $\geq 50\%$ số cơn co) - Nhịp giảm bất định lặp lại (số nhịp giảm $\geq 50\%$ số cơn co) - TTCB chậm Nhịp hình sin: gồm tất cả các tiêu chuẩn sau: • TTCB trong giới hạn bình thường • Dao động đều đặn với biên độ 5 – 15 nhịp/ph • Tần số 2 – 5 chu kỳ/p • Dao động sóng sin nằm trên và dưới đường cơ bản • Không có đoạn nào khác cho thấy dao động bình thường hay tăng	- Có ý nghĩa bệnh lý, liên quan đến với rối loạn thăng bằng kiểm toan - Cần can thiệp thích hợp vào thời điểm khảo sát
Loại 2	Có ý nghĩa trung gian: không thỏa tiêu chuẩn loại 1 và 3, bao gồm - TTCB chậm không kèm mất dao động nội tại - TTCB nhanh - Dao động nội tại tối thiểu - Tăng dđnt - Không nhịp tăng sau kích thích thai	- Cần theo dõi và đánh giá liên tục - Kết hợp lâm sàng để có hướng xử trí phù hợp

TTCB > 160, do:

- Mạch mẹ tăng: sốt, dùng thuốc tác dụng giao cảm
 - Viêm màng ối
 - Thai nhi thiếu máu, thiếu oxy
 - >170 cảnh báo thai nhi ở trạng thái đe dọa
- Xử trí theo nguyên nhân

TTCB < 110, do:

- Mẹ hạ huyết áp kéo dài, bệnh tim tắc nghẽn
- Thiếu oxy do kích thích TC quá mức
- Chèn ép rốn cấp, Sa dây rốn

→ Xử trí theo nguyên nhân

TT phẳng, do:

- Thai ngủ
- Thai non tháng
- Thuốc an thần, MgSO₄
- Thai thiếu oxy trầm trọng

→ Cần xác định nguyên nhân để can thiệp

Nhịp giảm bất định: thường do chèn ép rốn tạm thời

DOẠ SANH NON, SANH NON

I. ĐẠI CƯƠNG:

- Theo Tổ chức Y tế thế giới, sanh non hay dọa sanh non thai kỳ bị đe dọa vào chuyển dạ hay chuyển dạ xảy ra từ tuần thứ 22 đến trước tuần 37 của thai kỳ tính theo kinh cuối cùng.
- Sanh non nguy hiểm cho trẻ sơ sinh, tỷ lệ tử vong chu sản càng cao khi tuổi thai càng non. Nguy cơ cao bị di chứng thần kinh với tỷ lệ 1/3 trước tuần 32, giảm xuống 1/10 sau 35 tuần. Dự phòng và điều trị dọa sanh non - sanh non luôn là một vấn đề quan trọng đối với sản khoa, sơ sinh và toàn xã hội.

II. YẾU TỐ NGUY CƠ:

- 50% không rõ nguyên nhân.
- Tiền căn sinh non.
- Tình trạng kinh tế xã hội thấp: tuổi mẹ < 17 hay > 35, hút thuốc, uống rượu.
- Bệnh lý toàn thân của mẹ: nhiễm trùng, chấn thương, bệnh toàn thân: bệnh tim, thiếu máu, ...
- Viêm nhiễm âm đạo, cổ tử cung.
- Dị dạng tử cung, chiều dài kênh cổ tử cung ngắn, hở eo tử cung, ...
- Do thai và phần phụ: đa thai, đa ối, nhau nhau tiền đạo, bong non, ...

III. DOẠ SANH NON:

1. Chẩn đoán:

a. Triệu chứng cơ năng

- Đau bụng từng cơn, không đều đặn, tức nặng bụng dưới, đau lưng.
- Ra dịch âm đạo dịch nhày, lẫn máu.

b. Triệu chứng thực thể:

- Cơn co tử cung thưa nhẹ (2 cơn trong 10 phút, thời gian co dưới 30 giây).
- Cổ tử cung đóng, hoặc xóa mở < 2cm.

c. Cận lâm sàng

- Siêu âm: khảo sát chiều dài kênh CTC. Dưới 35mm thai 28-30 tuần thì nguy cơ sinh non là 20%.
- Monitoring sản khoa: đánh giá cơn gò tử cung.
- Định lượng FFN (test fibronectin)

2. Chẩn đoán phân biệt:

- Các tổn thương cổ tử cung, đường sinh dục dưới gây chảy máu âm đạo.
- Rau tiền đạo, rau bong non, vỡ tử cung.

3. Điều trị

a. Không dùng thuốc:

- Nghỉ ngơi tuyệt đối tại giường, nghiêng trái.
- Không kích thích đầu vú.
- Tránh giao hợp.

b. Thuốc giảm/cắt cơn co:

❖ Chống chỉ định tuyệt đối:

- Nguy cơ cho mẹ và thai do kéo dài thai kỳ hoặc nguy cơ do thuốc cao hơn nguy cơ sanh non.
- Thai lưu, dị tật bẩm sinh nặng.
- Suy thai cấp.
- Tiền sản giật hay sản giật.

❖ Chống chỉ định tương đối:

- Xuất huyết trước sinh nhiều (do nhau tiền đạo).
- Thai suy dinh dưỡng nặng.
- Một số bệnh lý toàn thân của mẹ mà có chống chỉ định với một số nhóm thuốc giảm co. Ví dụ: ĐTĐ phụ thuộc insulin chỉ dùng được Atosiban, đa thai (tăng thể tích huyết tương và cường aldosteron) không nên dùng Nifedipin và Salbutamol do tác động nặng lên tim mạch, phù phổi cấp.
- Ồi vỡ non.

c. Liệu pháp Corticoid:

- Chỉ định cho thai từ 28 đến hết 34 tuần tuổi.
- Bethamethasone 12mg, 2 liều tiêm bắp cách nhau 24h.
- Dexamethasone 6mg/lần, tiêm bắp 4 lần cách nhau 12h.

❖ Sử dụng Progesterone đặt âm đạo từ 16 - 24 tuần ở thai kỳ đơn thai ở các trường hợp có tiền căn sinh non để giảm nguy cơ tái phát.

IV. SANH NON:

- Tránh sang chấn cho thai: bảo vệ đầu ối đến khi cổ tử cung mở hết, hạn chế sử dụng oxytocin, cắt tầng sinh môn rộng, mổ lấy thai nếu có chỉ định.
- Chống nhiễm khuẩn nếu ối vỡ sớm, dự phòng sót nhau, chảy máu sau sanh.
- Đảm bảo hồi sức, chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng.

CHUYÊN DẠ SANH NON

I. ĐỊNH NGHĨA - PHÂN LOẠI

- Sinh non là khi trẻ được sinh ra ở tuổi thai từ hết 22 tuần đến trước 37 tuần.
- Phân loại theo WHO 2014:
 - Sinh cực non: < 28 tuần
 - Sinh rất non: từ 28 – < 32 tuần
 - Sinh non trung bình: từ 32 – 33 tuần 6 ngày
 - Sinh non muộn: từ 34 – 36 tuần 6 ngày
 - Thai gần đủ tháng: từ 37 – 38 tuần 6 ngày
 - Thai đủ tháng: từ 39 – 41 tuần

II. YẾU TỐ NGUY CƠ

1. Tiền căn sinh non
2. Tuổi mẹ < 17 hay > 35
3. Tình trạng kinh tế xã hội thấp
4. Suy dinh dưỡng (BMI < 18,6)
5. Hút thuốc, uống rượu
6. Đa thai, chuyển nhiều phôi trong thụ tinh ống nghiệm.
7. Viêm cổ tử cung
8. Tử cung dị dạng, hở eo tử cung, chiều dài kênh cổ tử cung ngắn...

III. CHẨN ĐOÁN

1. Lâm sàng

- Có 4 cơn gò tử cung trong 20 phút hay 8 cơn trong 60 phút, cơn gò sờ thấy được và gây đau.
- Cổ tử cung mở $\geq 2\text{cm}$ hoặc xóa trên 80%.
- Có sự thay đổi ở cổ tử cung được nhận định bởi một người khám trong nhiều lần khám liên tiếp.
- Các dấu hiệu khác: ra nhót hồng hoặc dịch nhầy cổ tử cung, đau thắt lưng, trằn bụng.

2. Cận lâm sàng

- CTG: Theo dõi tim thai, cơn gò tử cung.
- Siêu âm ngả âm đạo đo chiều dài kênh cổ tử cung (< 25mm).
- Có thể xét nghiệm fetal fibronectin (fFN) (theo hướng dẫn của nhà sản xuất).

IV. XỬ TRÍ

1. Dự phòng

- Xác định nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao.
- Hướng dẫn sản phụ các yếu tố nguy cơ.
- Chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ dinh dưỡng.
- Không hút thuốc uống rượu, nghỉ ngơi nhiều, giảm vận động nặng.
- Tầm soát và điều trị viêm cổ tử cung ở tuổi thai từ 24-28 tuần.
- Khâu vòng cổ tử cung hoặc dùng Pessary cổ tử cung dự phòng hoặc nếu có hở eo tử cung.
- Phòng ngừa bằng Progesterone (ở sản phụ có tiền căn sinh non, cổ tử cung ngắn).
- Sử dụng thuốc từ 16-36 tuần.
- Không tiền căn sinh non, chiều dài kênh cổ tử cung qua siêu âm đường âm đạo vào thời điểm 16 – 23 tuần tuổi thai, khi không có cơn co tử cung. Nếu <25mm: uống Dydrogesterone (Duphaston) 10mg 1 viên x 2 (u) mỗi ngày đến khi thai được 36 tuần; hoặc đặt âm đạo Progesteron dạng mịn 100mg 01 viên x 2 lần/ngày khi không có ra máu ra nước âm đạo và không có viêm nhiễm âm đạo
- Tiền căn sinh non từ 20-36 tuần: tiêm 17 α Hydroxy progesteron caproate 250mg/tuần hoặc đặt âm đạo 200mg Progesteron/ngày kết hợp khâu cổ tử cung nếu chiều dài kênh cổ tử cung < 25mm và tuổi thai < 24 tuần.

2. Điều trị

a. Mục tiêu điều trị

- Cho phép can thiệp kịp thời các trường hợp sinh non (giảm bệnh suất và tử suất cho thai nhi).
- Đảm bảo an toàn cho mẹ và thai nhi.
- Hạn chế nhập viện các thai kỳ không có nguy cơ sinh non cao.
- Có thời gian dùng đủ liều corticosteroid cho tuổi thai từ 24-34 tuần.
- Hỗ trợ phổi thường quy cho thai 28-34 tuần.
- Thai 26-28 tuần: cân nhắc tùy trường hợp.

b. Nguyên tắc điều trị

- Hướng dẫn sản phụ nằm nghỉ ngơi tuyệt đối, không kích thích đầu vú và tránh giao hợp .
- Ăn uống hợp lý đầy đủ dinh dưỡng. Ăn nhiều trái cây, rau xanh, ngũ cốc để tránh táo bón.
- Dùng thuốc cắt cơn gò trong vòng 48 giờ, cố gắng trì hoãn cuộc sinh ít nhất 24 giờ.
- Không phối hợp nhiều loại thuốc cắt cơn gò cùng lúc.
- Không điều trị dọa sinh non cho thai từ 36 tuần trở lên.
- Hỗ trợ phổi thai bằng corticosteroid.
- Phối hợp với BS sơ sinh chuẩn bị phương tiện hồi sức và chăm sóc trẻ sơ sinh non

tháng

c. Điều trị cắt cơn gò bằng thuốc

Chống chỉ định tuyệt đối

- Nguy cơ cho mẹ và thai do kéo dài thai kỳ hay nguy cơ do thuốc cao hơn nguy cơ sinh non.
- Thai chết trong tử cung.
- Thai dị tật bẩm sinh nặng.
- Thai suy cấp.
- Tiền sản giật nặng hay sản giật.
- Nhiễm trùng ối.

Chống chỉ định tương đối

- Xuất huyết trước sinh nhiều (cân nhắc trong nhau tiền đạo).
- Thai suy dinh dưỡng nặng trong tử cung
- Đái tháo đường phụ thuộc insulin (có thể dùng Atosiban)
- Đa thai (tăng thể tích huyết tương, cường aldosteron) nguy cơ thuốc tác động nặng lên tim mạch, phù phổi cấp nên không sử dụng Nifedipine và Salbutamol.
- Ối vỡ non.

Thuốc	Chống chỉ định	Liều lượng	Tác dụng phụ	Theo dõi
Nifedipin (nhóm chẹn kênh calci)	HA mẹ <90/50mmHg, bệnh tim, gan, thận, đang dùng thuốc hạ áp khác.	- Tấn công: 20mg ngâm dưới lưỡi trong 20 phút (tối đa 03 liều) - Duy trì: 20mg, uống 6-8h/lần	-Hạ HA,Nhịp tim nhanh, đánh trống ngực. -Nóng bừng mặt, đau đầu, chóng mặt. -Buồn nôn -Thai suy.	- HA, M mẹ mỗi 30p trong giờ đầu. Đo HA sau 30p sau mỗi liều kế tiếp. - Theo dõi tim thai, cơn gò trong giờ đầu. Mỗi 6 giờ trong thời gian điều trị.
Magiesulfat (nhóm chẹn kênh calci)		- Tấn công: 4-6g pha trong 100ml Glucose 5%, truyền TM trong 20 phút. - Duy trì: 2g/h truyền tĩnh mạch trong 12h, sau đó 1g/h trong 24h	- Nóng bừng mặt - Giảm phản xạ gân xương - Úc chế hô hấp - Ngừng thở, ngừng tim	Cần theo dõi nồng độ ion Mg huyết thanh (5-7mg/dL)

Magnesi sulfat:

• Magnesi sulfat ($MgSO_4$) giúp bảo vệ thần kinh đối với bào thai, trẻ sinh non, làm giảm tần suất bại não và tử vong do bại não.

❖ **Chỉ định:**

• Sử dụng $MgSO_4$ cho sản phụ có nguy cơ sinh non trước 32 tuần tuổi để phòng ngừa bại não.

• Áp dụng cho cả đơn thai và đa thai.

• Chỉ nên cho nếu dự đoán sinh trong vòng 24 giờ

• Liều dùng: có 3 công thức

• Tiêm tĩnh mạch 4g trong 20 phút, sau đó duy trì 1g/giờ đến khi sinh hoặc đủ 24 giờ (tùy cái nào đến trước);

• Tiêm tĩnh mạch 4g trong 30 phút hoặc 4g bolus tĩnh mạch như liều duy nhất;

• Tiêm tĩnh mạch 6g trong 20-30 phút, sau đó duy trì 2g/giờ tĩnh mạch.

• Cần chú ý thử phản xạ gân xương (ở đầu gối hay ở cơ nhị đầu), xem lượng nước tiểu (ít nhất là 30ml/giờ), nhịp thở (16 lần trở lên) trước khi tiêm thuốc lần sau.

Dùng Corticosteroid

• Chỉ định: Tuổi thai từ 24-34 tuần. Dùng thuốc 1 đợt duy nhất.

• Thường quy cho thai 28-34 tuần.

• Thai 26-28 tuần: cân nhắc tùy trường hợp.

• Chống chỉ định sử dụng Corticosteroid: không thể trì hoãn hoặc không nên trì hoãn chuyển dạ trong 48 giờ hay tuổi thai > 34 tuần hay tỉ lệ Leucithin/ Sphingomyelin >2.

• Betamethasone 12mg TB 2 liều cách nhau 24 giờ

• Hoặc Dexamethasone 6mg TB 4 liều cách nhau 12 giờ.

Khuyến cáo	Mức độ chứng cứ
Sử dụng 1 đợt corticosteroid từ 24-34 tuần trong các trường hợp có nguy cơ sinh trong vòng 7 ngày (ACOG – Khuyến cáo A)	1
Sử dụng progesterone đặt âm đạo từ 16-24 tuần ở thai kỳ đơn thai ở các trường hợp có tiền căn sinh non để giảm nguy cơ tái phát (ACOG – Khuyến cáo A)	1
Nifedipin và Atosiban gây ít tác dụng phụ và có hiệu quả trì hoãn sinh non đến 7 ngày và cải thiện kết quả sơ sinh (RCOG - Khuyến cáo A)	1
Điều trị duy trì thuốc giảm co không có lợi ích và không được khuyến cáo vì không có sự khác biệt rõ về bệnh suất và tử vong chu sinh (RCOG - Khuyến cáo A)	1

Khâu CTC làm tăng nguy cơ sinh non trong song thai nên không khuyến cáo khâu CTC khi chiều dài kênh CTC < 25mm trong song thai (ACOG - Khuyến cáo B)	1
Không sử dụng phối hợp nhiều loại thuốc giảm co vì sẽ tăng nguy cơ tác dụng phụ trên mẹ và thai nhi (RCOG – Khuyến cáo B)	2
Đối với tuổi thai từ 32 – 34 tuần, khuyến cáo sử dụng đầu tay với Nifedipine. Thuốc kế tiếp được khuyến cáo sử dụng là beta-adrenergic receptor agonist, nếu có điều kiện thì nên dùng Atosiban (Uptodate - Khuyến cáo B).	2

KHỞI PHÁT CHUYỂN DẠ**I. Chỉ định KPCD:**

- Tiền sản giật nặng
- Mẹ bị đái tháo đường: Thai 38 - 39 tuần.
- Mẹ có bệnh lý nội khoa nặng.
- Mẹ bị ung thư.
- Thai chết lưu trong tử cung, hoặc tiền căn thai chết lưu trong tử cung nhiều lần
- Thai quá ngày dự sanh
- Thai nhi có dị tật bẩm sinh nghiêm trọng.
- Vỡ ối tự nhiên
- Thiếu ối
- Nhiễm trùng ối

II. Chống chỉ định KPCD:

- Tử cung có sẹo mổ cũ
 - Bất xứng đầu-chậu tuyệt đối
 - Các bất thường ở đường sinh dục như: Ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến triển, Herpes sinh dục đang giai đoạn hoạt động.
 - Các bệnh lý mạn tính nghiêm trọng của mẹ
 - Đa thai (**)
 - Não úng thủy nặng
 - Ngôi bất thường: ngôi ngang, ngôi chéch, ngôi trán.
 - Ngôi mông, ngôi mặt (**)
 - Tiền sử sanh con to nhiều lần (**)
 - Nhau tiền đạo, mạch máu tiền đạo, nhau bám thấp (**),
 - Xuất huyết âm đạo 3 tháng cuối chưa rõ nguyên nhân
 - Tử cung quá căng trong đa ối (**)
- (**) chống chỉ định tương đối

III. Đánh giá trước khi gây chuyển dạ:

- Đánh giá chỉ định, chống chỉ định của KPCD
- - Đánh giá sức khỏe thai trước khi khởi phát chuyển dạ bằng Modified biophysical profile (Non-Stresstest và siêu âm nước ối) hoặc Stress-test.

IV. Các phương pháp khởi phát chuyển dạ:**1. Kích thích núm vú**

- Se đầu vú từng bên trong 5 đến 30 giây, cách khoảng 2 đến 3 phút, ngưng kích thích khi đang có cơn co tử cung nhưng phương pháp này chỉ hiệu quả nếu CTC đã thuận tiện.

2. Lóc ối

- Khám âm đạo, đưa ngón tay vào giữa màng ối và cổ tử cung, đầu ngón tay phải áp sát cổ tử cung để tách màng ối ra khỏi thành cổ tử cung và đoạn dưới tử cung.

3. Bấm ối: Bấm ối chỉ thực hiện được khi cổ tử cung đã mở, bằng cách dùng 1 kim chọc dò dài hoặc 1 càn Kocher để gây thủng màng ối, sau đó dùng ngón tay xé rộng màng ối. Có thể bấm ối đơn thuần hoặc kết hợp với truyền oxytocin.

- Đánh giá số lượng và màu sắc dịch ối.
- Theo dõi nhịp tim thai trước và ngay sau khi bấm ối.
- Khuyến cáo RCOG 2001:
- Không bấm ối đơn thuần để KPCD
- Bấm ối nên thực hiện khi cơn co chuẩn hoặc khi có Oxytocin

4. Sonde Foley

a. Chống chỉ định

- Nhau tiền đạo
- Ối vỡ
- Viêm âm đạo, viêm cổ tử cung

b. Kỹ Thuật

- Rửa sạch, sát trùng âm hộ, âm đạo bằng dung dịch Betadin 5%
- Đặt mỏ vịt bộc lộ cổ tử cung và sát khuẩn cổ tử cung
- Dùng kẹp hình tim đưa ống thông 16-18 khi bóng còn xẹp vào kênh cổ tử cung. Để đảm bảo phần bóng ống thông nằm gọn ở kênh cổ tử cung bằng cách dùng kẹp hình tim kẹp ống thông ở vị trí giới hạn dưới của phần bóng rồi đưa vào cổ tử cung đến chỗ kẹp dừng lại.
- Dùng ống xy lanh 50ml, bơm dung dịch nước muối sinh lý 9‰ 30ml vào nhánh đường bơm vào của ống thông → dùng tay kéo nhẹ ống thông ra ngoài, hướng ra sau để bóng ống thông giữ chặt ở kênh cổ tử cung. Cố định ống thông lên mặt trong đùi thai phụ.

5. Oxytocin

- Các bước tiến hành:
- Cho 5 đv oxytocin pha vào 500ml dung dịch glucose 5%, truyền nhỏ giọt tĩnh mạch chậm, liều lượng lúc đầu 5 - 8 giọt/phút cho đến khi xuất hiện cơn co tử cung.
- Theo dõi và điều chỉnh số giọt để đạt được số cơn co phù hợp với sự tiến triển của chuyển dạ.

– Trong quá trình theo dõi chuyển dạ sanh. Nếu thấy có cơn gò tử cung nhiều (>6 cơn trong 10 phút) và không thay đổi nhịp tim thai nhi bất thường thì giảm hoặc ngưng truyền Oxytocin ngay. Nếu không kiểm soát được cơn gò tử cung thì chấm dứt cuộc chuyển dạ ngay bằng sanh ngã âm đạo hay sanh mổ tùy theo tình trạng cổ tử cung, độ lọt của ngôi thai.

THAI SUY TRONG CHUYỀN DẠ**I. Chẩn đoán:****1. Lâm sàng:**

- Nước ối có phân su
- Tim thai thay đổi (doppler):
Hoặc nhanh hơn 160 lần/phút.
Hoặc chậm hơn 110 lần/phút.
- Cử động thai hỗn loạn (triệu chứng muộn).

2. Cận lâm sàng:**a. Có các thay đổi trên Monitoring như:**

- Trị số nhịp tim thai căn bản nhanh trầm trọng (> 180 lần/phút).
- Trị số nhịp tim thai căn bản nhanh trầm trọng (< 100 lần/phút).
- Đường biểu diễn tim thai phẳng (Dao động nội tại ≤ 5 nhịp/phút).
- Nhịp giảm bất định
- Nhịp giảm muộn
- Một nhịp giảm kéo dài > 3 phút

b. Nếu điều kiện soi buồng ối:

- Thấy nước ối màu xanh (chưa vỡ ối). Có thể do PH máu đầu thai nhi ($PH \leq 7.25$).

II. Xử trí:**1. Điều trị:**

- Tìm nguyên nhân suy thai:
 - * Nếu nguyên nhân rõ như : sa dây rốn, nhau bong non, dọa vỡ tử cung... thì mổ lấy thai.
 - * Nếu không có nguyên nhân rõ ràng: để sản phụ nằm nghiêng trái và thở oxy để tử cung không đè lên động mạch chủ dưới nữa, huyết áp trở lại bình thường, có thể cải thiện hoặc chấm dứt được tình trạng suy thai trong 15 – 30.
 - * Nếu sản phụ mệt mỏi vì chuyển dạ kéo dài thì hồi sức cho thai phụ
 - Thở oxy 6 lit/ph.
 - Nếu đang truyền với oxytocin thì ngưng truyền
 - Nằm nghiêng (T)
 - Nếu sau hồi sức 15 phút mà tim thai vẫn chưa trở lại bình thường thì mổ lấy thai nếu không đủ điều kiện sinh ngã âm ngay.

2. Dự phòng:

- Phát hiện và điều trị sớm những trường hợp thai kém phát triển trong tử cung để có thái độ xử trí kịp thời.

- Sản chỉ huy phải thực hiện đúng qui cách và liều lượng.
- Tránh chuyển dạ kéo dài.
- Tích cực theo dõi chuyển dạ kéo dài với máy monitor tim thai để phát hiện sớm và xử trí đúng thời điểm các trường hợp suy thai trong chuyển dạ.

THIẾU ỎI

I. Chẩn đoán:

- Nhập viện vì thiếu ối:
 - Xoang ối sâu nhất: $\leq 20\text{mm}$
 - Chỉ số ối (AFI) $\leq 5\text{cm}$
 - Nguy cơ thai chậm tăng trưởng, suy thai trường diễn, thai dị tật tăng.

II. Xử trí:

- Đánh giá tình trạng thiếu ối: xem có ối vỡ non không để chẩn đoán xác định là thiếu ối
- Đánh giá tuổi thai:
- Thai < 34 tuần hướng kéo dài thai kỳ bằng cách:
 - Gia tăng lượng nước ối: khuyến cáo BN uống nhiều nước > 2.5 lít nước mỗi ngày
 - Theo dõi tình trạng sức khỏe thai: theo dõi cử động thai, thực hiện NST 1-2 lần / tuần
 - Theo dõi tình trạng nước ối qua siêu âm
 - Cố gắng đánh giá dị dạng thai khi nước ối đủ để khảo sát nếu cần có thể chuyển tuyến trên để xác định
 - Nếu không cải thiện: chuyển tuyến trên
- Thai ≥ 34 tuần:
 - Gia tăng lượng nước ối: khuyến cáo BN uống nhiều nước > 2.5 lít nước mỗi ngày
 - Theo dõi tình trạng sức khỏe thai: theo dõi cử động thai, thực hiện NST 1-2 lần / tuần
 - Theo dõi tình trạng nước ối qua siêu âm
 - Nếu lượng ối cải thiện tăng qua siêu âm: hướng kéo dài thai kỳ
 - Nếu lượng ối không cải thiện tăng qua siêu âm: tham vấn chấm dứt thai kỳ, sau khi hỗ trợ trưởng thành phổi, đánh giá sức khỏe thai bằng NST, OCT:
 - NST có đáp ứng, OCT (-): khởi phát chuyển dạ
 - NST không đáp ứng, OCT (+): mổ lấy thai
 - NST, OCT khó đánh giá, lập lại nhiều lần để có thể xác định.

TĂNG HUYẾT ÁP THAI KỲ**I. ĐẠI CƯƠNG:**

Tăng huyết áp là biến chứng nội khoa thường gặp nhất ở phụ nữ mang thai chiếm khoảng 10% tổng số thai kỳ, là một trong ba nguyên nhân quan trọng gây tử vong mẹ trên toàn thế giới.

II. PHÂN LOẠI (theo ACOG 2014) gồm 4 nhóm:**1. Tiền sản giật- sản giật:**

Tiêu chuẩn chẩn đoán TSG	
Huyết áp	- HA tâm thu ≥ 140 mmHg hoặc tâm trương ≥ 90 mmHg trong hai lần đo ít nhất cách 4 giờ, ở thai sau 20 tuần tuổi trên phụ nữ có huyết áp bình thường trước đó. - HA tâm thu ≥ 160 mmHg hoặc tâm trương ≥ 110 mmHg, tăng huyết áp có thể xác nhận trong một khoảng thời gian ngắn (15 phút) để tạo điều kiện điều trị hạ huyết áp kịp thời
Protein niệu	$\geq 300\text{mg}/24$ giờ hoặc - Tỉ lệ Protein/creatinin $\geq 0,3$ (mg/dL mỗi giá trị) - Dipstick 1 + (Sử dụng nếu phương pháp định lượng khác không có sẵn)
Hoặc trong trường hợp Protein niệu âm tính, tăng huyết áp mới khởi phát kèm theo với bất kỳ dấu hiệu nào mới khởi phát sau đây:	
Giảm tiểu cầu	$< 100.000/\text{mm}^3$
Suy thận	Nồng độ creatinin/huyết thanh $> 1,1\text{mg}/\text{dL}$ hoặc tăng gấp đôi nồng độ creatinine huyết thanh trong trường hợp không có bệnh thận khác
Suy chức năng gan	Men gan tăng ≥ 2 lần giá trị bình thường
Phù phổi	
Triệu chứng não hoặc thị giác	

TIÊU CHUẨN TIỀN SẢN GIẬT NẶNG (bất kỳ dấu hiệu nào)

- Tăng huyết áp trầm trọng: HA ≥ 160 mmHg hoặc HA tâm trương ≥ 110 mmHg qua 2 lần đo cách nhau 4 giờ có nghỉ ngơi tại giường (ngoại trừ đã sử dụng thuốc hạ áp trước đó)

- Tiểu cầu $< 100.000/\text{mm}^3$

- Suy chức năng gan: men gan tăng gấp đôi bình thường. Đau hạ sườn phải hoặc thượng vị kéo dài không đáp ứng với thuốc và không có chẩn đoán thay thế, hoặc cả hai

- Suy thận tiến triển (nồng độ creatinin/huyết thanh $> 1,1$ mg/dL hoặc tăng gấp đôi nồng độ creatinin/ huyết thanh trong trường hợp không có bệnh thận khác)

- Phù phổi.
- Rối loạn não hay thị giác (triệu chứng thần kinh trung ương): rối loạn thị giác (hoa mắt, ám điểm, phù võ não, co thắt mạch máu võng mạc); nhức đầu nhiều, nhức đầu dai dẳng tăng lên, không đáp ứng thuốc giảm đau; thay đổi tri giác.
- Sản giật: đây là biến chứng nặng. Con co giật có thể xảy ra trước sinh, trong khi chuyển dạ, hoặc sau sinh 48 đến 72 giờ.

Hội chứng HELLP:

- Xảy ra trước hoặc sau sinh
- Lâm sàng: đau vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải, nhìn mờ, nhức đầu, vàng da, buồn nôn, nôn.
- Cận lâm sàng: dấu hiệu tán huyết (LDH tăng, Bilirubin gián tiếp tăng), tăng men gan và giảm tiểu cầu.
- 15 đến 20% hội chứng này không có tăng huyết áp, không có protein niệu

2. Tăng huyết áp mạn: Huyết áp tâm thu ≥ 140 mmHg và /hoặc HA tâm trương ≥ 90 mmHg trước khi có thai, hoặc xảy ra trước tuần lễ 20 của thai kỳ và kéo dài sau 12 tuần hậu sản.

3. Tiền sản giật trên nền tăng huyết áp mạn:

– Người bệnh có tăng huyết trước tuần lễ thứ 20, protein niệu dương tính trước hoặc sau tuần lễ thứ 20, cần phải tăng liều thuốc điều trị huyết áp, tăng men gan đột ngột, giảm tiểu cầu, đau $\frac{1}{4}$ trên phải, xung huyết phổi hay phù phổi, giảm chức năng thận hoặc đột ngột tăng tiểu đạm.

4. Tăng huyết áp trong thai kỳ: tăng huyết áp sau tuần lễ 20, protein âm tính không có các dấu hiệu trên.

III. XỬ TRÍ

– Theo dõi sát huyết áp cho đến 72 giờ sau sinh cho tất cả trường hợp tăng huyết áp thai kỳ và theo dõi huyết áp 7 đến 10 ngày sau sinh tại địa phương.

1. Tiền sản giật không dấu hiệu nặng

- Có thể theo dõi, điều trị ngoại trú
- Nhập viện, chấm dứt thai kỳ khi:
 - Thai ≥ 37 tuần hoặc
 - Nghi ngờ nhau bong non, hoặc
 - Thai ≥ 34 tuần và có bất kỳ triệu chứng sau:
 - + Chuyển dạ hoặc vỡ ối
 - + Siêu âm ước lượng trọng lượng thai nhỏ hơn bách phân vị thứ 5
 - + Thiếu ối: AFI < 5 cm ở 2 lần siêu âm liên tiếp cách nhau 24 giờ
- . Nếu chưa có chỉ định chấm dứt thai kỳ, có thể theo dõi ngoại trú hoặc nội trú.

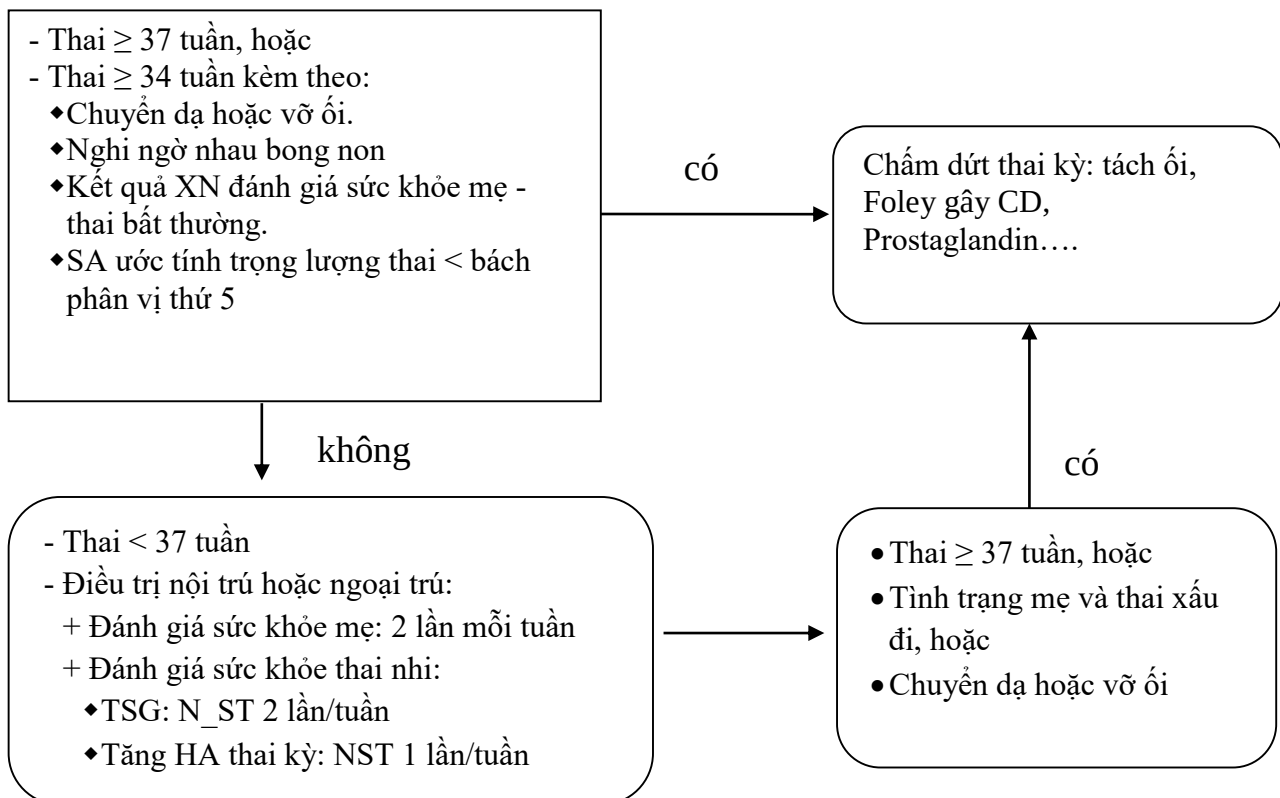
– Thai:

- + Đếm cử động thai
- + Siêu âm Doppler: xác định có thai chậm tăng trưởng 2 tuần/lần và đánh giá lượng ối 1 tuần/lần
- + NST: 1lần/tuần nếu tăng HA thai kỳ, 2 lần/tuần nếu tiền sản giật

– Mẹ:

- Theo dõi HA 2 lần/tuần
- Đạm niệu mỗi lần khám thai
- Xét nghiệm tiểu cầu, chức năng gan thận mỗi tuần
- Chế độ ăn hợp lý (nhiều đạm, rau xanh, trái cây)
- Lưu đồ hướng xử trí Tăng HA trong thai kỳ
- TSG không dấu hiệu nặng.
-

DẤU HIỆU MẸ VÀ THAI



2. Tiền sản giật nặng:

Chấm dứt thai kỳ khi TSG nặng xuất hiện sớm trước 25 tuần hoặc bất cứ tuổi thai nào khi có:

- + Phù phổi

- + Suy thận
- + Nhau bong non
- + Giảm tiểu cầu
- + Đông máu nội mạch lan tỏa
- + Các triệu chứng não dai dẳng
- + N_ST không đáp ứng (2 lần liên tiếp cách 4 đến 6 giờ ở tuổi thai 28 đến 32 tuần)
- + Siêu âm Doppler động mạch rốn: mất hoặc đảo ngược sóng tâm trương
- + Thai lưu

Điều trị mong đợi: thai < 34 tuần với tình trạng bà mẹ và thai nhi ổn định, tiếp tục theo dõi thai được tiến hành tại cơ sở có nguồn lực chăm sóc đặc biệt cho bà mẹ và trẻ sơ sinh đầy đủ.

Chích thuốc hỗ trợ phổi thai nhi khi thai ≤ 34 tuần. Tuy nhiên không chờ đợi đủ thời gian hỗ trợ phổi mà phải chấm dứt thai kỳ ngay khi có các dấu hiệu sau:

- + Tăng HA không kiểm soát được.
- + Sản giật
- + Phù phổi
- + NST không đáp ứng
- + Nhau bong non
- + Thai lưu
- + Đông máu nội mạch lan tỏa

Nếu tình trạng mẹ thai ổn định, trong vòng 48 giờ sẽ chấm dứt thai kỳ khi có bất kỳ dấu hiệu sau:

- + Vỡ ối
- + Chuyển dạ
- + Tiểu cầu < 100.000/ mm³
- + Men gan tăng kéo dài (≥ 2 lần giá trị bình thường)
- + Thai chậm tăng trưởng (ước lượng cân nặng nhỏ hơn bách phân vị thứ 5)
- + Thiểu ối (AFI < 5cm) (siêu âm 2 lần cách nhau 24 giờ)
- + Bắt đầu suy thận hoặc nặng thêm tình trạng suy thận

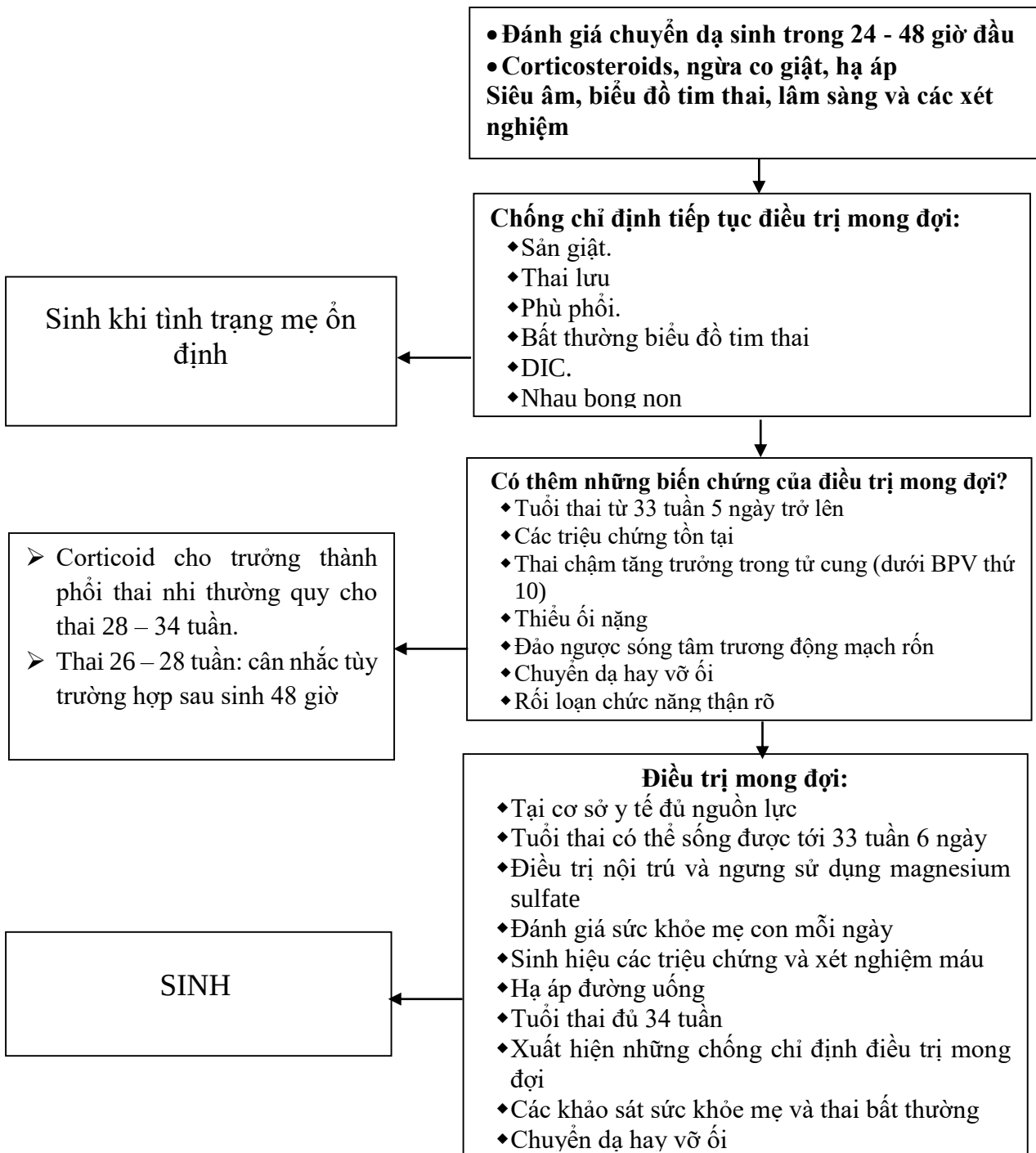
Một số lưu ý:

- Quyết định chấm dứt thai kỳ không dựa vào yếu tố đạm niệu
- Chỉ định dùng thuốc hạ áp khi HA tâm thu ≥ 150 mmHg hoặc HA tâm trương ≥ 100 mmHg
- Theo dõi
- Mẹ:

- + Sinh hiệu mỗi giờ/ 1 lần
- + Bilan dịch vào và ra mỗi 8 giờ/ lần
- + Dấu hiệu chuyển dạ
- + Xét nghiệm bilan TSG mỗi 1 đến 2 ngày

- Thai

- + Đếm cử động thai, NST mỗi ngày
- + Theo dõi biểu đồ cân nặng thai và Doppler động mạch rốn mỗi tuần
- + Phương pháp chấm dứt thai kỳ: tùy tuổi thai, ngôi thai, cổ tử cung, tình trạng mẹ- thai.



3. Sản giật

– Chấm dứt thai kỳ khi tình trạng nội khoa ổn định, không chờ đợi đủ thời gian tác dụng của thuốc hỗ trợ phổi thai nhi.

4. Hội chứng HELLP

– Chấm dứt thai kỳ ngay khi có chẩn đoán xác định là hội chứng HELLP đối với thai ≥ 34 tuần, hoặc thai < 34 tuần có dấu hiệu nặng lên: đông máu nội mạch lan tỏa, nhồi máu hay xuất huyết trong gan, phù phổi, suy thận, nhau bong non, N_ST không đáp ứng. Không chờ đợi đủ thời gian tác dụng của thuốc Corticoide hỗ trợ phổi thai nhi.

– Thai < 34 tuần, tình trạng mẹ - thai ổn định, có thể theo dõi 24 đến 48 giờ để chờ đợi đủ thời gian sử dụng corticoide hỗ trợ phổi.

IV. THUỐC ĐIỀU TRỊ

1. Magnesium sulfate: Dự phòng và chống co giật trong TSG nặng, hội chứng HELLP, sản giật

- Magnesium sulfate có thể tiêm TM, tiêm bắp hoặc truyền TM liên tục
- Liều tấn công 3 - 4,5g Magnesium sulfate 15%/50 ml dung dịch tiêm TM từ 15 đến 20 phút (tùy thuộc cân nặng của thai phụ, tiền căn sử dụng Magnesium sulfate)
- Duy trì 1 - 2g/giờ truyền TM. Pha 6g Magnesium sulfate 15% vào chai Glucose 5% 500ml truyền TM 30 giọt/phút.
- Theo dõi các dấu hiệu: phản xạ gân xương (có), nhịp thở (>16 lần/phút), lượng nước tiểu (> 100 ml/4 giờ).
- Đo nồng độ Magnesium huyết thanh khi cần thiết và điều chỉnh liều duy trì để giữ nồng độ Magnesium 4 - 7 mEq/L (4,8 - 8,4 mg/dL, 2 - 3,5 mmol/L)
- Magnesium sulfate dùng trước trong và duy trì tối thiểu 24 giờ sau sinh.
- Nguy cơ: BHSS, giảm dao động nội tại tim thai
- Ngộ độc Magnesium sulfate
- ✓ Liên quan nồng độ Magnesium /huyết thanh
 - 9,6 - 12 mg/dL (4,0 - 5,0 mmol/L): mất phản xạ gân xương
 - 12 - 18 mg/dL (5,0 - 7,5 mmol/L): liệt cơ hô hấp
 - 24 - 30 mg/dL (10 - 12,5 mmol/L): ngưng tim
- ✓ Xử trí ngộ độc Magnesium sulfate
 - Ngừng Magnesium sulfate
 - Thuốc đối kháng: calcium gluconate 10% 10ml, tiêm TM 1g trong 10 phút
 - Đặt nội khí quản và thông khí để cứu sống bệnh nhân nếu có suy hô hấp, ngừng thở

2. Thuốc hạ HA

– Chỉ định:

- ♦ Khi HA tâm thu ≥ 150 mmHg hay
- ♦ HA tâm trương ≥ 100 mmHg
 - HA đạt sau điều trị
- ♦ HA trung bình sau 2 giờ không giảm quá 25% so với huyết áp ban đầu
- ♦ HA tâm thu ở mức 130 - 150 mmHg
- ♦ HA tâm trương ở mức 80 - 100 mmHg
 - Chống chỉ định trong thai kỳ
 - ♦ Nitroprusside
 - ♦ Thuốc ức chế men chuyển
 - Các loại thuốc hạ HA dùng trong thai kỳ
 - ♦ Labetalol
 - ♦ Hydralazine
 - ♦ Ức chế calcium như Nifedipine, Nicardipine
 - ♦ Methyldopa

a. Labetalol

- Tấn công: bắt đầu 10 - 20 mg TM, sau đó TM 20 - 80 mg mỗi 20 - 30 phút, tổng liều tấn công để hạ áp < 300 mg. Ví dụ: TM 20 mg, tiếp theo 40 mg, tiếp 80 mg. Có thể truyền TM 1g - 2g 1 phút. HA sẽ hạ sau 5 - 10 phút và kéo dài 3 - 6 giờ
- Duy trì (khi HA ổn định): Labetalol (uống): 100 - 200 mg x 2 - 3 lần/ngày, liều tối đa 1200 mg/24 giờ
- CCĐ: suyễn, bệnh tim, suy tim xung huyết.

b. Hydralazine

- Cách dùng:
 - + Tiêm TM 5mg Hydralazine/ 1 - 2 phút sau đó 5 - 10 mg/20 - 40 phút hoặc truyền TM 0,5 - 10 mg/giờ
 - + Nếu tổng liều 30 mg không kiểm soát được HA, nên chuyển thuốc khác
 - + HA sẽ hạ sau 10 - 30 phút và kéo dài từ 2 - 4 giờ
- Hydralazine được chứng minh có hiệu quả trong phòng ngừa xuất huyết não.

c. Nicardipine

- Ống 10mg/10ml pha với 40 ml nước cất hoặc glucose 5%
- Tấn công: 0,5 - 1mg (2,5 - 5ml) tiêm TM chậm

- Duy trì bơm tiêm điện 1 - 3mg/giờ (5 - 15 ml/giờ) nếu không đáp ứng sau 15 phút tăng 2,5mg/giờ, tối đa 15mg/giờ.

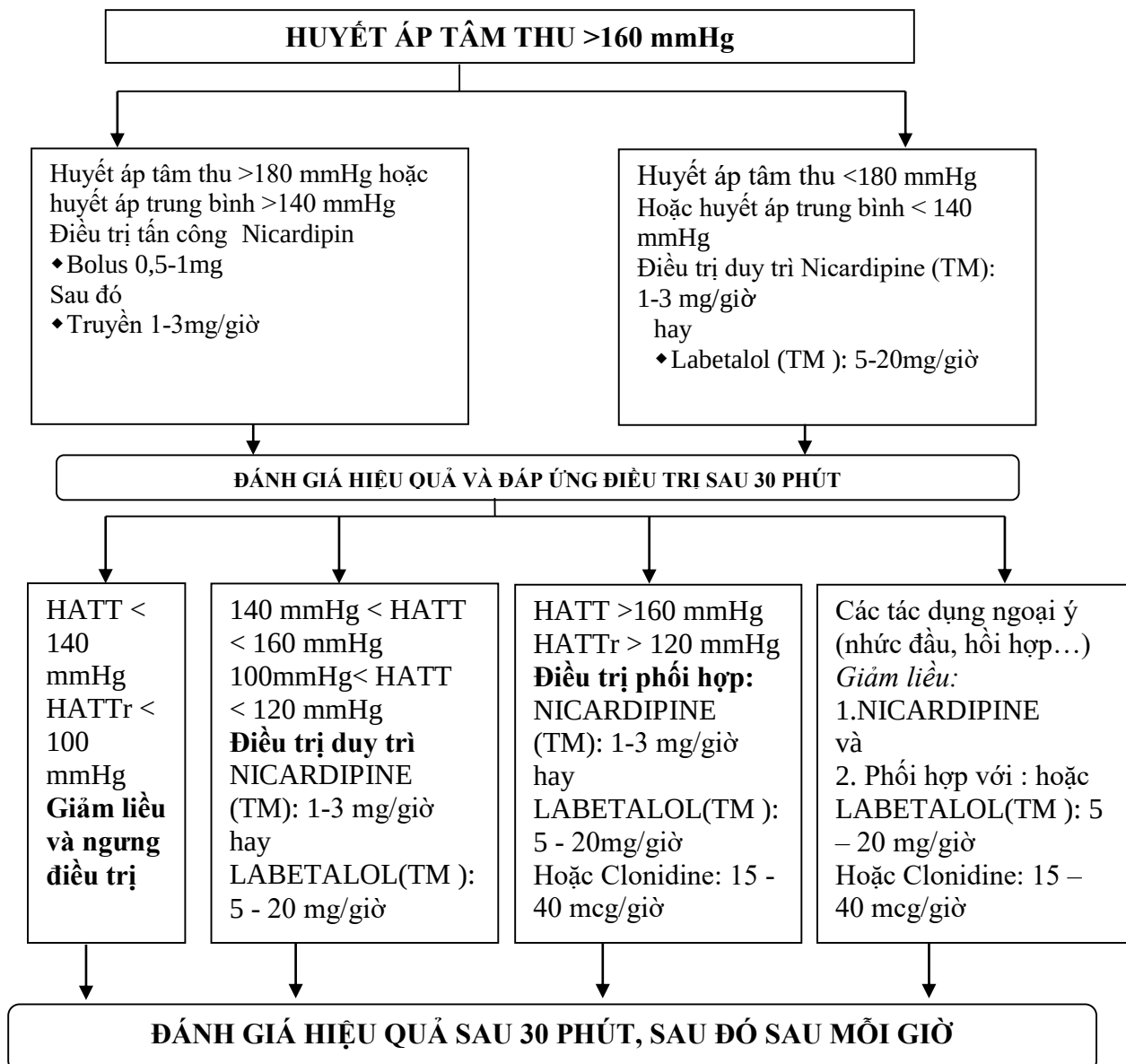
d. Nifedipine:

- Tấn công: uống 10 - 20mg, lặp lại sau 30 phút nếu cần. Sau đó 10 - 20 mg sau mỗi 6 - 8 giờ
- Duy trì: uống 30 - 100 mg/ngày, viên tác dụng kéo dài
- Tác dụng phụ: nhịp tim nhanh, nhức đầu.

e. Methyldopa: Methyldopa 250mg, uống 1 - 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày, liều tối đa 3g/ngày.

f. Thuốc lợi tiểu:

- Chỉ dùng khi có triệu chứng phù phổi cấp và phù phổi cấp- Furosemide 1 ống 20mg x 8 ống tiêm TM chậm
- Không dùng dung dịch ưu trương.



V. TIỀN LƯỢNG LÂU DÀI

- Theo dõi HA 12 tuần sau sanh, tư vấn nguy cơ TSG cho các lần có thai sau, cảnh báo nguy cơ bệnh tim mạch trong tương lai.
- Tăng HA tồn tại càng lâu sau sinh, nguy cơ tăng HA mạn càng cao

VI. PHÒNG NGỪA:

- TSG sớm và phải chấm dứt thai kỳ trước 34 tuần, hoặc TSG nhiều thai kỳ → Uống acid acetylsalicylic (Aspirin) liều thấp ≤ 81 mg/ngày từ cuối tam cá nguyệt đầu
- Canxi làm giảm mức độ nặng của TSG.

SANH THƯỜNG

I. Cận lâm sàng cần thực hiện

Huyết học: Công thức máu, nhóm máu ABO, Rh

Đông máu: TQ, TCK

Nước tiểu: tổng phân tích nước tiểu

Miễn dịch: test nhanh HIV (có tư vấn trước xét nghiệm), HBsAg

Siêu âm thai

Lưu ý:

Nếu bệnh nhân tiền sản giật, sản giật: Tăng huyết áp thai kỳ cần xét nghiệm thêm LDH, AST, ALT, GGT, Creatinin, Acid uric, Protein TP trong máu, tổng phân tích nước tiểu.

Bệnh nhân có bướu giáp cần xét nghiệm thêm T3, T4, TSH

Hoặc có các bệnh lý khác kèm theo thì cần thực hiện thêm 1 số xét nghiệm đặc hiệu liên quan

II. Chăm sóc, theo dõi hậu sản thường

+Đánh giá tổng quát

- Sự co hồi tử cung
- Tính chất sản dịch
- Chăm sóc vú
- Chăm sóc vết may tầng sinh môn

*** Vết may tầng sinh môn diễn biến bình thường:** Cefuroxim 500mg 1viên x2 lần/ngày x 3 ngày Thuốc bổ nâng thể trạng (chú ý với Fe...)

*** Vết may tầng sinh môn bầm tím , phù nề, đau :** Có thể thêm Alphachymotrypsine 2viên x 3 lần/ngày

*** Vết may tầng sinh môn nhiễm trùng**

Kháng sinh liều cao :Thông thường dùng Cephalosporine thế hệ III 1g (test) 1 lọ x 2 lần TMC / ngày , Có thể kết hợp metronidazol.

Ngoài ra có thể dùng thêm thuốc giảm đau (nếu cần)

MỔ LẤY THAI

I. Định nghĩa

Mổ lấy thai là một phẫu thuật nhằm lấy thai và phần phụ của thai qua một vết mổ ở thành tử cung còn nguyên vẹn. Định nghĩa này không bao hàm mổ bụng lấy thai trong trường hợp chứa trong ổ bụng và vỡ tử cung thai đã nằm trong ổ bụng.

II. Cận lâm sàng cần thực hiện khi mổ lấy thai

- *Huyết học*: Công thức máu, nhóm máu ABO, Rh - *Đông máu*: TQ, TCK
- *Sinh hóa máu*: đường huyết, AST, ALT, GGT, Ure, Creatinin, điê nÂ giải đồ
- *Miễn dịch*: test nhanh HIV (có tư vấn trước xét nghiệm) HbsAg (nếu + thử thêm HbeAg)
- *Nước tiểu*: tổng phân tích nước tiểu
- *Đo điện tim*
- *Siêu âm thai*

Ghi chú:

- Nếu bệnh nhân tiền sản giật, sản giật tăng huyết áp thai kỳ cần xét nghiệm thêm LDH, Acid uric, Protein TP trong máu.
- Bệnh nhân có bướu giáp cần xét nghiệm thêm T3, T4, TSH

III. Chỉ định mổ lấy thai:

* Nhóm nguyên nhân do mẹ:

- Các sẹo mổ ở thân tử cung: sẹo bóc tách u xơ, sẹo của phẫu thuật tạo hình tử cung, sẹo khâu chỗ vỡ, chỗ thủng tử cung, sẹo của phẫu thuật cắt góc, tử cung, sừng tử cung.
- Sẹo của phẫu thuật mổ ngang đoạn dưới tử cung:
- Đã có mổ lấy thai ngang đoạn dưới từ hai lần trở lên. -Lần mổ lấy thai trước cách chưa được 24 tháng. -Con co tử cung cường tính -Dọa vỡ tử cung, vỡ tử cung
- Chuyển dạ đình trệ
- Ôi vỡ non, cổ tử cung không thuận lợi
- Bất xứng đầu chậu khung chậu hẹp, khung chậu lệch méo –Nghiệm pháp lọt thất bại
- Con so lớn tuổi, con quý (có thể kèm lý do tiền sử điều trị vô sinh)
- Mẹ bị các bệnh lý toàn thân mạn tính hay cấp tính nếu để đường dưới có thể có nguy cơ cho tính mạng người mẹ (bệnh tim, tăng huyết áp, tiền sản giật nặng và sản giật).
- Các bất thường ở đường sinh dục dưới của người mẹ như: chít hẹp âm đạo (bẩm sinh hay mắc phải), tiền sử mổ rò, mổ sa sinh dục.
- Các dị dạng của tử cung như: tử cung đôi (tử cung không có thai thường trở thành khối u tiền đạo), tử cung hai sừng... đặc biệt là khi kèm theo ngôi thai bất thường (Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị., 2020)

*** Nhóm nguyên nhân do thai:**

- Thai to
- Suy thai
- Cạn ối
- Sa dây rốn
- Ngôi bất thường (ngôi ngang, ngôi thóp trước, ngôi mặt cằm sau...)
- Thai chậm tăng trưởng nặng hay bị bất đồng nhóm máu nếu không lấy thai ra thì có nguy cơ thai bị chết lưu trong tử cung

*** Nhóm nguyên nhân do phần phụ của thai**

- Khối u tiền đạo: thường hay gặp là u xơ ở eo tử cung hay cổ tử cung, u nang buồng trứng, các khối u khác nằm trên đường thai đi ra.
- Nhau tiền đạo trung tâm hay nhau tiền đạo gây chảy máu nhiều buộc phải mổ cấp cứu để cầm máu cứu mẹ.
- Nhau bong non...
- Tóm lại các chỉ định mổ lấy thai là rất phức tạp, được trình bày trong từng bài cụ thể. Có những trường hợp mổ lấy thai là tập hợp của những chỉ định tương đối.

THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG TRONG TỬ CUNG

I. ĐỊNH NGHĨA

Thai gọi là chậm tăng trưởng trong tử cung (IUGR) khi cân nặng thai dưới bách phân vị (BPV) thứ 10 theo tuổi thai trên siêu âm (ACOG).

II. NGUYÊN NHÂN

1. Do mẹ:

- Bệnh lý nội khoa (bệnh lý thận, tim mạch, nội tiết, huyết học, ...)
- Hội chứng kháng phospholipid
- Hút thuốc lá, nghiện rượu, thiếu dinh dưỡng,...

2. Do phần phụ của thai: Bệnh lý bánh nhau, dây rốn

3. Do thai: Đa thai, nhiễm trùng bào thai, các rối loạn di truyền, ...

Tuy nhiên, nguyên nhân IUGR đôi khi khó xác định và có thể do một hoặc nhiều nguyên nhân.

III. CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI

1. Xác định tuổi thai chính xác: kinh cuối và/hoặc siêu âm 3 tháng đầu

2. Tiêu chuẩn chẩn đoán IUGR: Chu vi vòng bụng (AC) và/hoặc ước lượng cân nặng thai < bách phân vị thứ 10 theo tuổi thai.

⇒ Nếu đủ tiêu chuẩn chẩn đoán theo siêu âm, thai phụ sẽ được theo dõi chu vi vòng bụng và trọng lượng thai bằng biểu đồ Hardlok.

3. Siêu âm doppler:

a. Đánh giá chức năng bánh nhau: Doppler ĐM rốn và ĐM tử cung

b. Đánh giá tình trạng sức khỏe thai: Doppler ĐM não giữa và ống TM.

• Phân loại IUGR theo ACOG 2014:

- Độ 0: Cân nặng và/hoặc AC < BPV thứ 10, Doppler ĐM rốn và ĐM não giữa bình thường
- Độ I: Cân nặng và/hoặc AC < BPV thứ 10 và Doppler ĐM rốn hoặc ĐM não giữa bất thường
- Độ II: Cân nặng và/hoặc AC < BPV thứ 10 và mất sóng tâm trương hoặc đảo ngược sóng tâm trương ĐM rốn
- Độ III: Cân nặng và/hoặc AC < BPV thứ 10 và bất thường ống tĩnh mạch.

• Phân loại IUGR theo tuổi thai tại thời điểm chẩn đoán:

- *Rất sớm*: tuổi thai ≤ 29 tuần
- *Sớm*: $29 \text{ tuần} < \text{tuổi thai} \leq 34 \text{ tuần}$
- *Muộn*: tuổi thai $> 34 \text{ tuần}$

IV. XỬ TRÍ

1. Mục tiêu: chấm dứt thai kỳ đúng thời điểm.
2. Thời điểm chấm dứt: khi nguy cơ thai chết trong tử cung lớn hơn nguy cơ chết sau sinh.
3. Nguyên tắc xử trí: tùy thuộc vào tuổi thai ở thời điểm chẩn đoán và mức độ chậm tăng trưởng.

- **Thai ≤ 29 tuần: tham vấn tiền sản, tùy từng trường hợp xử trí.**
- **Thai 29 đến ≤ 34 tuần:**

Độ 0: không xử trí gì, siêu âm Doppler mỗi 2 tuần.

Độ I:

- Điều trị ngoại trú: Corticosteroids hỗ trợ phổi*, siêu âm doppler + N_ST 2 lần/tuần: nếu N_ST có đáp ứng + AFI >5 : chấm dứt thai kỳ ở tuổi thai 37 tuần.
- Điều trị nội trú nếu kèm theo tiền sản giật.

Độ II: Điều trị nội trú

- Corticosteroids hỗ trợ phổi*
- N_ST 2 lần/ngày + siêu âm Doppler 1 lần/ngày
- Nếu N_ST có đáp ứng và siêu âm không thay đổi: theo dõi thai đến 34 tuần.
- Nếu N_ST không đáp ứng: chỉ định MLT.

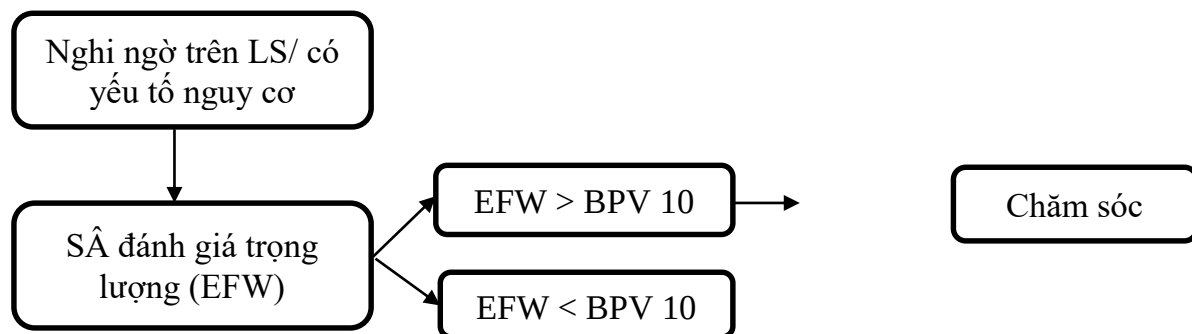
Độ III:

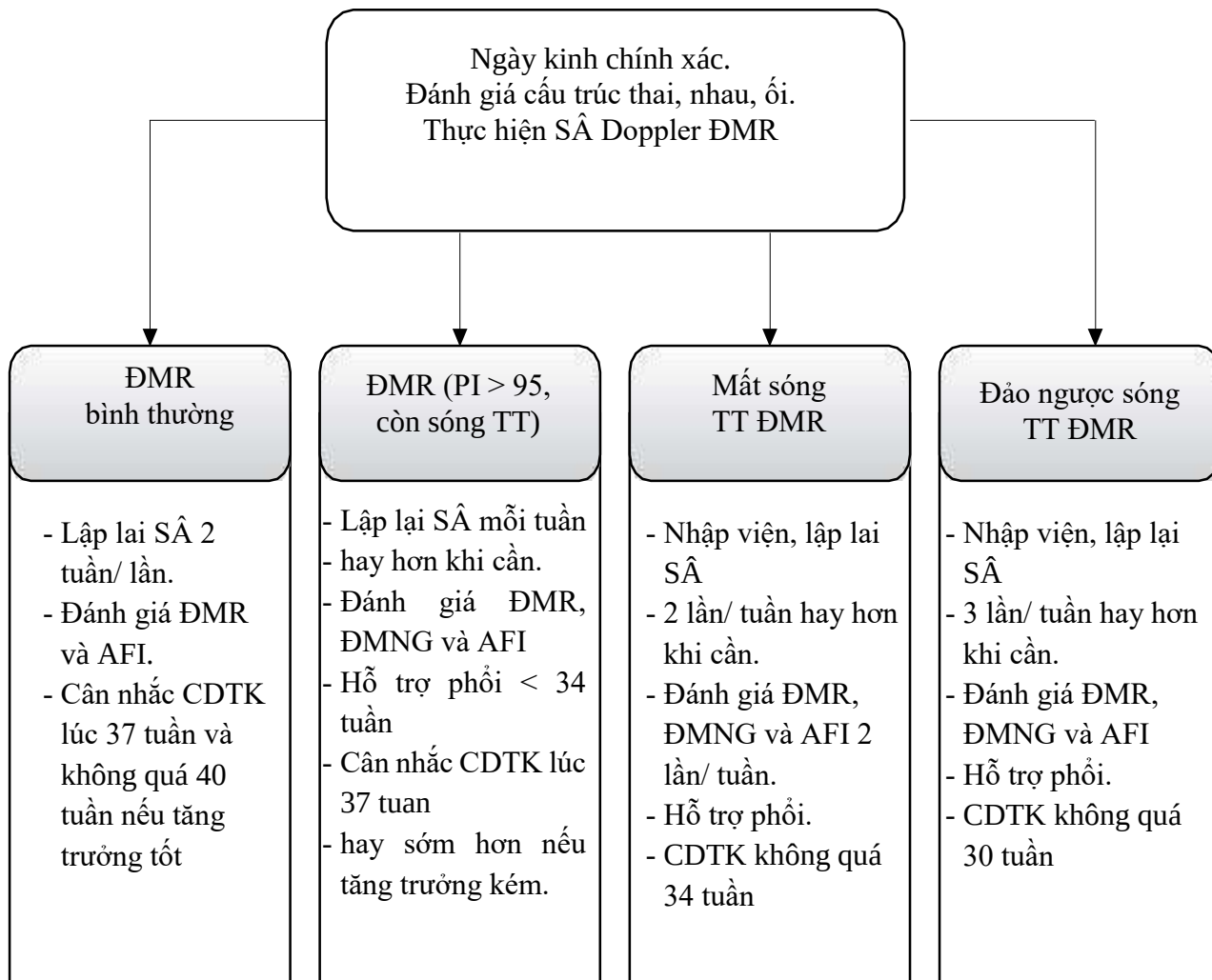
- Xử trí giống Độ II
- Chấm dứt thai kỳ lúc thai 32 tuần.

- **Thai > 34 tuần:**

- Corticosteroids hỗ trợ phổi: được chỉ định trong những trường hợp MLT chủ động
- XT như tuổi thai 29 – 34 tuần.

(*): xem Phác đồ Chuyển dạ sinh non





Trong tất cả các trường hợp, CDTK cũng được chỉ định với CTG bất thường, lưu ý khả năng sống của thai. Trong trường hợp mất hay đảo ngược sóng tâm trương, thảo luận với bác sĩ nhi thời điểm CDTK

BĂNG HUYẾT SAU SINH**I. Định nghĩa**

BHSS là tình trạng mất $\geq 500\text{ml}$ máu sau khi sinh đường âm đạo, mất $\geq 1000\text{ml}$ máu sau mổ lấy thai, hoặc ảnh hưởng tồn trạng. Hay Hct giảm 10%

Phân loại:

- Nguyên phát ($< 24\text{h}$ đầu)
- Thứ phát (sau 24h đến 12 tuần)

II. Chẩn đoán

- Đo lượng máu mất bằng thau (xô) hứng sau khi sổ thai và ra hết nước ối.
- Dấu hiệu mất máu cấp tính: mặt, vật vã, da xanh niêm nhạt, vã mồ hôi.
- Thay đổi tổng trạng, sinh hiệu: mạch nhanh, HA giảm.
- TC tăng thể tích.
- Ra huyết âm đạo đỏ tươi, lượng nhiều, liên tục.

Nguyên nhân:

- Đờ TC.
- Chấn thương sinh dục (đặc biệt là vỡ TC).
- Bất thường về bong nhau, sổ nhau.
- Rối loạn đông máu

III. Xử trí chung

- Hồi sức tích cực + co hồi TC + tìm nguyên nhân.
 - Huy động tất cả mọi người để cấp cứu.
 - Thiết lập đường truyền tĩnh mạch, cho dịch chảy với tốc độ nhanh, ít nhất 2 đường truyền tĩnh mạch, catheter 18G.
 - Đánh giá tình trạng mất máu và thể trạng chung của sản phụ (các dấu hiệu sinh tồn: mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ).
 - Nếu nghi ngờ có choáng hoặc bắt đầu có choáng phải xử trí ngay theo phác đồ xử trí choáng.
 - Thông tiêu.
 - Xoa đáy TC và dùng thuốc co hồi TC.
 - + Oxytocin 5 UI 4 ống pha 500ml dịch tinh thể, tối đa 80 UI.
 - + Methyl-ergometrin 0,2mg 1 ống TB (không sử dụng: tiền căn cao huyết áp, hội chứng Raynaud).
 - + Carbetocin (Duratocin 100mcg) 1 ống pha loãng 10 ml tiêm mạch chậm, 1 liều duy nhất (khuyên cáo sử dụng dự phòng những trường hợp nguy cơ cao BHSS).

+ Prostaglandin E1 (Misoprostol: Cytotec) 200mcg: từ 600-800mcg đặc hậu môn 1 lần duy nhất, có thể dùng cho người cao huyết áp hay hen suyễn. Theo dõi nhiệt độ sản phụ vì có thể sốt $\geq 40^{\circ}\text{C}$. Sử dụng khi không sử dụng được Oxytocin.

➤ Tìm nguyên nhân: kiểm tra đường sinh dục và thực hiện các biện pháp cầm máu cơ học khác.

➤ Làm xét nghiệm cơ bản: nhóm máu, huyết đồ, đông máu toàn bộ.

IV. Triệu chứng và xử lý theo bệnh cảnh lâm sàng

1. Đờ TC

a. Triệu chứng

- Chảy máu ngay sau khi sổ nhau là triệu chứng phổ biến nhất.
- TC giãn to, mềm nhão, co hồi kém hoặc không co hồi, không có khối an toàn.
- Có thể dẫn đến choáng nếu không xử lý kịp thời.
- Chèn gạc hoặc chèn bóng lòng TC, phẫu thuật may mũi B-Lynch hoặc thắt động mạch TC, cắt TC.
- Kết hợp vừa phẫu thuật vừa hồi sức, truyền máu.

2. Chấn thương đường sinh dục

Gồm rách âm hộ, âm đạo, tầng sinh môn, cổ TC, võ TC và máu tụ đường sinh dục.

a. Triệu chứng

- Tử cung co hồi tốt nhưng máu đỏ tươi vẫn chảy ra ngoài âm hộ.
- Khám thấy vết rách và máu tụ đường sinh dục.

b. Xử trí

- Khâu phục hồi đường sinh dục.
- Nếu bị tụ máu, tùy theo vị trí, kích thước và sự tiến triển của khối máu tụ để có thái độ xử trí thích hợp. Nguyên tắc chung là phải phá khối máu tụ khi tăng kích thước và khâu cầm máu kỹ, tránh tái phát. Làm tại phòng mổ khi khối máu tụ to, sâu hoặc ở vị trí khó kiểm soát.

3. Bất thường về bong nhau và sổ nhau

a. Triệu chứng

•Sốt nhau:

- Chảy máu thường xuất hiện sau khi sổ nhau.
- TC có thể co hồi kém.
- Ra máu rỉ rả, lượng máu ra có thể ít hoặc nhiều, máu đỏ tươi lẫn máu cục.
- Có thể phát hiện sớm sốt nhau bằng cách kiểm tra nhau và màng nhau.
- Nếu phát hiện muộn, không kịp thời, mất máu nhiều sẽ có dấu hiệu choáng.

•Nhau không bong:

- Nhau không bong trong vòng 30 phút sau khi sổ thai hoặc dùng biện pháp xử trí tích cực giai đoạn 3 của chuyển dạ không kết quả.

- Nhau bám chặt và không chảy máu.

- Nhau cài răng lược bán phần thì sau khi thai đã sổ 30 phút nhau không bong hoàn toàn, chảy máu nhiều hay ít tùy theo diện nhau bong rộng hay hẹp. Nhau cài răng lược toàn phần: ít gặp, không chảy máu.

b. Xử trí

•Sốt nhau:

- Truyền dịch tĩnh mạch ngay.
- Mời gây mê hỗ trợ cho thuốc giảm đau, tiến hành kiểm soát TC.
- Tiêm bắp 5 – 10 UI Oxytocin hoặc/và Ergometrin 0,2mg.
- Dùng kháng sinh toàn thân.
- Theo dõi mạch, huyết áp, chảy máu và co hồi TC.
- Hồi sức truyền máu nếu thiếu máu cấp.

•Nhau không bong:

- Nếu chảy máu, tiến hành bóc nhau và kiểm soát TC, tiêm bắp Oxytocin 10 UI, xoa bóp TC, hồi sức chống choáng, cho kháng sinh.

- Nhau cài răng lược bán phần chảy máu hoặc cài răng lược toàn phần phải cắt TC.

- Nếu chảy máu nhiều cần phải hồi sức chống choáng, truyền máu và phẫu thuật.
- Duy trì gò TC

4. Rối loạn đông máu:

Có thể tiên phát do các bệnh về máu nhưng thường là thứ phát do chảy máu nhiều, mất sinh sợi huyết (đông máu nội quản rải rác). Đông máu nội mạch rải rác có thể kết hợp với tiền sản giật nặng, thai chết trong TC, nhau bong non thể ẩn, nhiễm trùng ối hay thuyên tắc ối. Tất cả các tình trạng bệnh lý này có thể dẫn đến rối loạn đông máu.

V. Dự phòng:

- Đảm bảo công tác quản lý thai nghén tốt, phát hiện sớm các nguy cơ cao.
- Xử lý tích cực giai đoạn 3 của chuyển dạ.
- Áp dụng vẽ biểu đồ chuyển dạ, không để xảy ra chuyển dạ kéo dài.
- Đỡ sinh đúng kỹ thuật, nhẹ nhàng để tránh tổn thương đường sinh dục. Khi có chấn thương đường sinh dục cần phải hiện sớm và xử lý kịp thời.
- Theo dõi sát sản phụ 6 giờ đầu sau sinh, đặc biệt là trong 2 giờ đầu để phát hiện sớm các trường hợp chảy máu.

VỖ TỬ CUNG

I. Mở đầu.

– Vỡ tử cung là một trong 5 tai biến sản khoa, có thể gây tử vong cho thai nhi và sản phụ. Vỡ tử cung có thể xảy ra trong thời kỳ mang thai, nhưng thường gặp nhất trong chuyển dạ.

– Vỡ tử cung có triệu chứng điển hình là do sự vỡ tất cả các lớp của tử cung mà không do phẫu thuật, thường kèm chảy máu có thể tống xuất một phần hoặc tất cả các phần thai vào ổ bụng.

II. Chẩn đoán.

1. Vỡ tử cung trong thai kỳ.

– Thường xảy ra trên TC có sẹo mổ cũ hoặc dị dạng.

- Triệu chứng cơ năng

- ✓ Đột ngột đau nhói vùng tử cung, nhất là chỗ mổ cũ, có thể ra huyết âm đạo.
- ✓ Có thể có triệu chứng của choáng.

- Dấu hiệu thực thể

- ✓ Tổng trạng: cơ thể có dấu hiệu choáng.
- ✓ Nhìn: bụng có thể có sẹo mổ cũ, có thể biến dạng, lành phình.
- ✓ Sờ nắn:

+ Sờ thấy các phần thai nhi nằm ngay dưới da bụng, không sờ thấy đáy TC nếu thai bị đẩy ra khỏi buồng TC.

+ Có phản ứng thành bụng.

+ Đau nhói vùng VMC khi sờ nắn.

+ Gõ đục vùng thấp hoặc gõ đục toàn ổ bụng.

– Tim thai suy hoặc không nghe được tim thai.

– Khám âm đạo có thể không thấy ngôi thai khi thai bị đẩy vào ổ bụng, máu đỏ tươi theo găng.

- Cận lâm sàng

– Hct giảm.

– Có thể có bạch cầu tăng

– Siêu âm: dịch ổ bụng, vị trí thai bất thường, đuôi tứ chi, tim thai: nhịp chậm, rời rạc hoặc không có.

– Lưu ý: Trường hợp vết sẹo mổ cũ chỉ mới bị nứt, ít có dấu hiệu điển hình của xuất huyết nội.

2. Vỡ tử cung trong chuyển dạ.

a. Dọa vỡ tử cung trong thời kỳ chuyển dạ.

- Chỉ xảy ra trên TC không có sẹo mổ cũ.
- Triệu chứng cơ năng
 - + Thai phụ đau bụng nhiều
 - + Cơ co tử cung dồn dập, mạnh.
- Dấu hiệu thực thể
 - + Vòng Bandl lên cao (cao ngang rốn và trên rốn là sắp vỡ TC), TC có hình quả bầu.
 - + Dấu hiệu Frommel: hai dây chằng tròn bị kéo dài, căng lên như hai sợi dây đàn.
 - + Tim thai có thể bình thường, không đều hoặc suy.
 - + Khám âm đạo thấy đầu cao chưa lọt, các dấu hiệu bất xứng đầu chậu; có thể phát hiện các nguyên nhân: khung chậu hẹp, ngôi bất thường.

b. Vỡ tử cung.

- Triệu chứng cơ năng.
 - Sản phụ có dấu dọa vỡ, đột đau nhói nhưng sau đó bớt đau nhưng tổng trạng xấu dần.
 - Choáng: da xanh, niêm nhạt, mạch nhanh nhẹ khó bắt, tụt huyết áp, tay chân lạnh.
 - Xuất huyết âm đạo.
 - Nước tiểu có thể có màu đỏ.
- Dấu hiệu thực thể.
 - Triệu chứng tổng quát: có thể có choáng.
 - Nhìn: bụng có thể biến dạng, linh phình.
 - Sờ nắn:
 - + Phản ứng thành bụng.
 - + Đau nhói nơi vết vỡ.
 - + Sờ thấy thai nhi, không sờ thấy đáy TC nếu thai bị đẩy ra khỏi buồng TC.
 - Gõ đục vùng thấp hoặc gõ đục toàn ổ bụng.
 - Tim thai suy hoặc không nghe được tim thai.
 - Khám âm đạo có thể không còn thấy ngôi thai, máu đỏ tươi theo găng.
 - Trường hợp vỡ TC sau sinh thường, sinh giúp: thấy máu đỏ tươi chảy từ lòng TC, có thể choáng, soát lòng TC có thể phát hiện vết vỡ ở đoạn dưới TC, vết rách CTC lên tới đoạn dưới TC, sẹo mổ cũ không còn nguyên vẹn liên tục, bị mỏng hoặc bị rách vỡ rộng.

III. Xử trí.

➤ Dọa vỡ TC.

- Lập đường truyền TM với NaCl 0, 9% hoặc Ringer lactat.
- Thông tiểu.
- Mô lấy thai cấp cứu.

➤ Vỡ TC.

- Hồi sức tích cực
- Mô cấp cứu.
- Xử lý TC.

+ Bảo tồn TC nếu tổng trạng cho phép, <40 tuổi, <2 con, hoặc vết vỡ đơn giản, chưa có dấu nhiễm trùng.

+ Cắt TC toàn phần nếu choáng nặng, có nhiễm trùng, vết vỡ phức tạp, tuổi => 40, con => 2.

➤ Các vấn đề cần lưu ý.

- Hồi sức chống choáng thật tốt trước _trong_ sau phẫu thuật.
- Khánh sinh phổ rộng trước và sau mổ.
- Nếu bảo tồn TC.
 - + Phải cắt lọc trước khi khâu bảo tồn vết rách do sẹo mổ cũ.
 - + Cố gắng phủ được phúc mạc TC.
 - + Cần triệt sản nếu bệnh nhân đủ con.
- Cần thận không làm tổn thương niệu quản 2 bên.
- Quan sát, phát hiện tổn thương ở các cơ quan lân cận để giải quyết kết hợp kịp thời.
- Cần theo dõi biến chứng viêm phúc mạc toàn thể hay khu trú trong thời kì hậu phẫu.

IV. Dự phòng

- Quản lý thai tốt, đặc biệt đối với vết mổ cũ.
 - + Đánh giá lại thai kỳ và định hướng phương pháp sinh khi thai 38 tuần có VMC.
 - + Đối với phụ nữ có vết mổ trên cơ TC nên ngừa thai ít nhất 1 năm.
- Khi khởi phát chuyển dạ hoặc tăng co phải theo sát cơn gò với monitor sản khoa, phát hiện sớm các dấu hiệu bất xứng đầu chậu, cơn gò cường tính.
- Đối với các thai kỳ có chỉ định mổ lấy thai nên được mổ chủ động hoặc ngay khi chuyển dạ.
- Khi giúp sinh phải tôn trọng đúng chỉ định, đúng điều kiện và thực hiện đúng kỹ thuật.

BÍ TIỂU SAU SINH

I. ĐỊNH NGHĨA

- Có triệu chứng (30%): không có khả năng tổng xuất tự nhiên nước tiểu được từ 6 giờ sau sinh hoặc sau rút thông tiểu.
- Không triệu chứng (70%): tồn lưu nước tiểu/ thông Nelaton hoặc siêu âm >150ml.

II. YẾU TỐ NGUY CƠ

- Con so
- Con to
- Chuyển dạ kéo dài
- Tổn thương bàng quang
- Tổn thương thần kinh – cơ vùng tầng sinh môn
- Tầng sinh môn rách nhiều
- Kém vận động

III. BIẾN CHỨNG

- Bàng quang dẫn quá mức → BQ giảm hoạt động:
 - + Nhiễm trùng tiểu
 - + Tiểu không kiểm soát
 - + Vỡ BQ
 - Thời gian hồi phục chức năng bq:
 - + 10h sau gây tê tủy sống
 - + 6h sau tê ngoài màng cứng
- 24h – 72h → 1 tuần sau chấn thương BQ, cổ BQ, đau TSM.

IV. PHÒNG NGỪA

1. Chú ý làm trống BQ

- Trong quá trình theo dõi chuyển dạ: khuyến khích sản phụ đi tiểu mỗi 2 giờ
- Lúc rặn sanh, nếu có thông tiểu thì nên rút thông tiểu ra để tránh tổn thương cổ BQ.
- Sau sanh, khuyến khích sản phụ đi tiểu

2. Lưu thông tiểu các trường hợp: Sau mổ (lưu 12 giờ), Sau sanh giúp, bóp nhau bằng tay, may phục hồi rách TSM độ 3- 4, phù nề TSM, BHSS có điều trị 40UI Oxytocin, ...

3. Giảm đau, giảm sưng nề vết may TSM, cổ BQ: chườm lạnh, kháng viêm, thuốc dẫn cổ BQ Xatral 10mg 1viên (uống sau ăn)/24h, Alphachymotrypsin

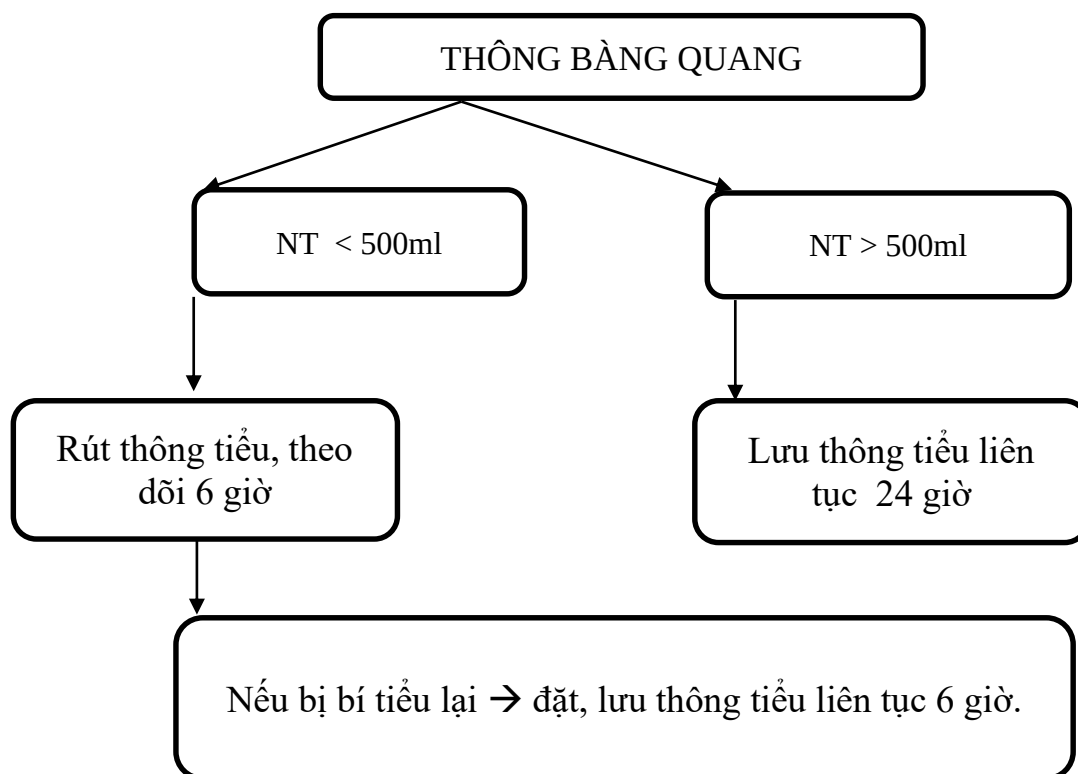
4. VLTL BQ: tiểu theo giờ, tư thế ngồi tiêu tiểu đúng, ép BQ, kích thích BQ.

V. XỬ TRÍ

- Tập tiểu (thành công 50- 60%)

- Vận động
- Ngồi xổm
- Uống nhiều nước 2- 3l/ngày
- Tắm nước ấm
- Chườm ấm vùng bụng dưới
- Ấn BQ hỗ trợ khi tiểu
- Nghe tiếng nước chảy
- Chườm lạnh TSM phù nề
- Điều trị táo bón (nếu có)

Thông bàng quang, khá



KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG SẢN PHỤ KHOA**I. ĐỊNH NGHĨA**

- Kháng sinh dự phòng (KSDP) là kháng sinh được sử dụng ngay trước, trong phẫu thuật - thủ thuật và kết thúc trong 24 giờ nhằm phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ.

- Đối với mổ lấy thai: Cần phát hiện và điều trị các nhiễm khuẩn âm đạo như: Bacterial vaginosis, Chlamydia trước.

II. PHẪU - THỦ THUẬT SẢN KHOA

Loại phẫu thuật	Kháng sinh dự phòng	Ghi chú
Mổ lấy thai cấp cứu hoặc chủ động	Cefazolin 1g (TMC) < 80kg: 1g liều duy nhất > 80kg: 2g liều duy nhất Thời điểm: trước rạch da trong vòng 30 phút	Nếu máu mất trong lúc mổ $\geq 1000\text{ml}$: tiêm thêm 1g Cefazolin ngay sau phẫu thuật Nếu dị ứng Penicillin hay Cephalosporin: Clindamycin 600mg truyền TM trước rạch da
Dự phòng viêm nội tâm mạc nhiễm trùng khi làm thủ thuật, phẫu thuật sản khoa	Amoxicillin 2g liều duy nhất uống trước 30 phút	
Khâu eo tử cung	Cefazolin 1g (TMC) trước thủ thuật	
Sinh thường	Amoxicillin 3g/24h	

Điều kiện sử dụng kháng sinh dự phòng trong MLT

- Tất cả các trường hợp MLT, ngoại trừ:

- Thai phụ có bệnh nội khoa chưa ổn định và đang điều trị: THA, tim mạch, ĐTĐ, cường giáp, phổi mãn tính, RL huyết học, thiếu máu, K, suy chức năng gan thận, suy giảm miễn dịch, SDD, ...

- Thai phụ đang có biểu hiện nhiễm trùng hay có nguy cơ nhiễm trùng được phát hiện trong quá trình phẫu thuật.

- Ối vỡ > 6h

- Phẫu thuật phức tạp hay có biến chứng

- Tổng lượng máu > 1000ml.

- Lặp lại liều 2 sau liều đầu 6h nếu cuộc mổ kéo dài trên 90 ph và không có yếu tố nguy cơ nhiễm trùng nào khác

Trường hợp cần chuyển sang KS điều trị, BS cần ghi rõ lý do.

III. PHẪU - THỦ THUẬT PHỤ KHOA

Loại phẫu/thủ thuật	Kháng sinh dự phòng	Ghi chú
Phẫu thuật cắt tử cung • Ngã âm đạo • Ngã bụng • Nội soi	Cefazolin 1g (TMC) trước rạch da	- Dị ứng Penicillin hay Cephalosporin: Clindamycin VÀ Gentamicin
Phẫu thuật nội soi • Chẩn đoán • Buồng tử cung • U buồng trứng •	Cefazolin 1g (TMC) trước rạch da	
Phá thai ngoại khoa	- Doxycycline 100mg 1viên (uống) 1giờ trước thủ thuật và 02 viên (uống) sau thủ thuật	
Đặt vòng tránh thai	Không khuyến cáo sử dụng (Khuyến cáo mức độ A)	Trừ trường hợp nhiễm khuẩn hoặc có bệnh lý lây lan qua đường tình dục
Chụp HSG	Doxycycline 100mg 01viên (uống)x 2 lần x 5 ngày Nên tầm soát STD trước khi chụp HSG	
Nạo sinh thiết buồng tử cung	Cefazolin 1g (TMC) Trước thủ thuật 30 phút	

CẤP CỨU SẶC SỮA

I. MỤC ĐÍCH

- Lấy ra được lượng sữa trẻ hít vào đường hô hấp
- Cấp cứu cho trẻ thoát khỏi tình trạng suy hô hấp

II. CÁCH NHẬN BIẾT

- Trẻ đang bú, sau bú đột ngột ho sặc sụa tím tái.
- Có thể thấy sữa trào ra mũi, miệng.
- Trường hợp nặng trẻ có thể ngừng thở, ngừng tim sau khi bú
- Trẻ đang ngủ sau bú có thể bị ọc, sau đó sặc ra hoặc đột ngột ngưng tim, ngưng thở
- Do sai lầm của người nuôi trẻ: bịt mũi trẻ cho trẻ nuốt, đánh trẻ lúc trẻ đang ngậm sữa trong miệng, đổ sữa quá nhiều vào miệng trẻ làm trẻ bị sặc.

III. CÁCH XỬ TRÍ SẶC SỮA

- Đặt trẻ nằm sấp trên tay hoặc đùi của bạn
- Đặt đầu trẻ ở vị trí thấp hơn thân, cổ ngửa.
- Vỗ lưng: dựng bàn tay phải vỗ 5 cái vào lưng trẻ ở khoảng giữa 2 xương bả vai
- Ấn ngực:
 - Đặt trẻ nằm ngửa bằng cách đỡ đầu trẻ và kẹp giữa 2 đầu gối để thấp hơn thân
 - Quan sát vùng họng và mũi trẻ: Nếu có sữa thì hút sạch
 - Dùng 2 ngón bàn tay phải ấn mạnh ở vùng giữa dưới ức 5 lần
- Đánh giá lại sau mỗi lần ấn ngực, vỗ lưng:

Nếu hồng hào khóc tốt : không cần làm tiếp

Nếu trẻ vẫn còn khó thở tiếp tục vỗ lưng, ấn ngực. Có thể thực hiện đến 8 lần

- Trong khi cấp cứu phải quan sát đánh giá trẻ. Nếu ngừng tim, ngừng thở thì tiến hành hồi sức ngừng tim, ngừng thở

- Theo dõi toàn trạng của trẻ sau sặc sữa

IV. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ CẤP CỨU

- Khi cấp cứu luôn thông báo cho đồng nghiệp hoặc người nhà hỗ trợ, giải thích nhanh cách sơ cứu và dụng cụ cần có (ví dụ máy hút đàm nhớt, khăn sạch...)
- Sau cấp cứu nếu bé có suy hô hấp thì chuyển lên khoa sơ sinh hoặc tuyến trên để tiếp tục điều trị cho trẻ.
- Nếu trẻ sặc sữa lượng ít và không có biểu hiện suy hô hấp thì phải theo dõi sát để đánh giá đúng tình trạng của trẻ để có hướng xử trí nếu cần.

VÀI BIỆN PHÁP DỰ PHÒNG

Dặn người nhà chăm sóc sơ sinh:

1. Không cho bú quá no hay quá nhiều trong cùng một lúc. Uống bằng miệng: uống từ chút một, không đổ thẳng vào họng, đổ từ từ một bên miệng để bé tự nuốt.
2. Vỗ lưng cho ợ hơi sau cử bú.
3. Nằm đầu cao, nghiêng một bên đặc biệt đối với những bé hay ọc, kém tiêu, đang khò khè.
4. Không tự cho uống bất kỳ thức uống nào không có chỉ định của bác sĩ.

THAI Ở SỢ MỔ LẤY THAI

I. ĐỊNH NGHĨA

Thai ở sợ mổ lấy thai (TOSMLT) là một dạng thai ngoài tử cung do thai làm tổ trong vết sợ mổ lấy thai

II. CHẨN ĐOÁN

a. *Lâm sàng*: có thai

- Trễ kinh
- Ra huyết âm đạo
- Đau bụng

50% không có triệu chứng, chỉ phát hiện qua siêu âm.

b. *Cận lâm sàng*

* *Siêu âm*

- Buồng tử cung trống, không có túi thai.
- Túi thai nằm ở thành trước đoạn eo tử cung, lớp cơ tử cung giữa bàng quang và túi thai không có hay rất mỏng.

- Siêu âm Doppler cho thấy mạch máu quanh túi thai.

** βhCG: dương tính, trong trường hợp âm tính cũng không thể loại trừ.*

c. *Chẩn đoán phân biệt*

- Thai trong tử cung
- Thai ở đoạn eo tử cung
- Thai ở cổ tử cung
- Sảy thai và khối thai tụt xuống đoạn eo ngang vết MLT

III. ĐIỀU TRỊ

a. *Nguyên tắc*

- Lấy khối thai
- Bảo tồn khả năng sinh sản nếu được
- Nếu xuất huyết ồ ạt cần can thiệp phẫu thuật cấp cứu, có khả năng cắt tử cung để cầm máu.

- Tình trạng ổn định, không xuất huyết, xuất huyết lượng ít có nhiều cách can thiệp, không nên can thiệp ban đầu bằng nạo vì nguy cơ xuất huyết ồ ạt

b. Lựa chọn các phương thức điều trị thường phối hợp các phương pháp và cân nhắc trên từng người bệnh.

- Tiêm MTX 50mg (TB) nếu không có chống chỉ định điều trị MTX.
- Lấy khối thai có nguy cơ thủng tử cung, xuất huyết ồ ạt, tổn thương bàng quang
- Trước khi nạo hút cần tư vấn nguy cơ thủng tử cung, tổn thương bàng quang phải

chuyển qua phẫu thuật cấp cứu để xử trí các tổn thương trên

- Trường hợp chảy máu từ trung bình đến nhiều: đặt bóng chèn bơm 20-30cc nước muối sinh lý có hiệu quả cầm máu. Cần đặt thông tiểu duy trì cùng bóng chèn. Rút bóng chèn và thông tiểu sau 12-24 giờ.

* Làm Bilan xét nghiệm trước điều trị bằng MTX (xem bài phác đồ điều trị TNTC).

- Sau thủ thuật cần thuốc như kháng sinh, co tử cung, cầm máu

- Hướng dẫn BN hạn chế vận động, nên nằm nghỉ.

c. Điều trị ngoại trú. Có đầy đủ tiêu chuẩn sau:

- Lâm sàng ổn định, không đau bụng, không ra huyết.

- β hCG giảm trên > 30% so với β hCG trước thủ thuật

- Giảm tăng sinh mạch máu

- Có khả năng theo dõi (siêu âm doppler, β hCG) và BN tuân thủ theo dõi, có điều kiện đến BV nhanh chóng khi có chảy máu

- β hCG: theo dõi mỗi tuần 1 lần trong 3 tuần liên tiếp, nếu giảm > 15%: sau đó mỗi tháng đến khi β hCG âm tính.

Siêu âm: khối thai và tăng sinh mạch máu mỗi tuần/3 tuần, sau đó mỗi tháng đến khi: kích thước túi thai không quan sát được

Nếu một trong các yếu tố: β hCG tăng, kích thước khối thai tăng, chảy máu thì nhập viện

d. Ngừa thai ít nhất 12-24 tháng, không đặt DCTC.